

제429회 국회
(정기회)

보건복지위원회회의록
(법안심사제2소위원회)
(임시회의록)

제 2 호

국 회 사 무 처

일 시 2025년11월19일(수)

장 소 보건복지위원회회의실

의사일정

1. 축산물 위생관리법 일부개정법률안(김미애 의원 대표발의)(의안번호 2209417)
2. 식품위생법 일부개정법률안(장종태 의원 대표발의)(의안번호 2206715)
3. 식품위생법 일부개정법률안(김도읍 의원 대표발의)(의안번호 2203138)
4. 식품위생법 일부개정법률안(강선우 의원 대표발의)(의안번호 2207231)
5. 식품위생법 일부개정법률안(강선우 의원 대표발의)(의안번호 2208925)
6. 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 일부개정법률안(김남희 의원 대표발의)(의안번호 2203011)
7. 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 일부개정법률안(이개호 의원 대표발의)(의안번호 2204184)
8. 장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률 일부개정법률안(최보운 의원 대표발의)(의안번호 2209999)
9. 노인복지법 일부개정법률안(안상훈 의원 대표발의)(의안번호 2209698)
10. 노인복지법 일부개정법률안(김남희 의원 대표발의)(의안번호 2210405)
11. 국민연금법 일부개정법률안(박희승 의원 대표발의)(의안번호 2201942)
12. 국민연금법 일부개정법률안(김선민 의원 대표발의)(의안번호 2201013)
13. 국민연금법 일부개정법률안(김미애 의원 대표발의)(의안번호 2211802)
14. 국민건강보험법 일부개정법률안(한지아 의원 대표발의)(의안번호 2212942)
15. 국민건강보험법 일부개정법률안(김선민 의원 대표발의)(의안번호 2212927)
16. 국민건강보험법 일부개정법률안(임종득 의원 대표발의)(의안번호 2213321)
17. 국민건강보험법 일부개정법률안(서미화 의원 대표발의)(의안번호 2210400)
18. 정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률 일부개정법률안(김예지 의원 대표발의)(의안번호 2213293)
19. 응급의료에 관한 법률 일부개정법률안(소병훈 의원 대표발의)(의안번호 2205860)
20. 응급의료에 관한 법률 일부개정법률안(이수진 의원 대표발의)(의안번호 2210220)
21. 공공보건의료대학 설립·운영에 관한 법률안(박희승 의원 대표발의)(의안번호 2201301)
22. 공중보건장학을 위한 특례법 전부개정법률안(김문수 의원 대표발의)(의안번호 2201520)
23. 자살예방 및 생명존중문화 조성을 위한 법률 일부개정법률안(정부 제출)(의안번호 2209098)

24. 비만질환의 예방 및 관리에 관한 법률안(이주영 의원 대표발의)(의안번호 2207836)
25. 비만 예방 및 관리에 관한 법률안(박희승 의원 대표발의)(의안번호 2205679)
26. 국민건강증진법 일부개정법률안(전용기 의원 대표발의)(의안번호 2212345)

상정된 안건

1. 축산물 위생관리법 일부개정법률안(김미애 의원 대표발의)(의안번호 2209417) 3
2. 식품위생법 일부개정법률안(장종태 의원 대표발의)(의안번호 2206715) 3
3. 식품위생법 일부개정법률안(김도읍 의원 대표발의)(의안번호 2203138) 3
4. 식품위생법 일부개정법률안(강선우 의원 대표발의)(의안번호 2207231) 3
5. 식품위생법 일부개정법률안(강선우 의원 대표발의)(의안번호 2208925) 3
6. 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 일부개정법률안(김남희 의원 대표발의)(의안번호 2203011) 3
7. 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 일부개정법률안(이개호 의원 대표발의)(의안번호 2204184) 3
8. 장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률 일부개정법률안(최보운 의원 대표발의)(의안번호 2209999) 3
9. 노인복지법 일부개정법률안(안상훈 의원 대표발의)(의안번호 2209698) 3
10. 노인복지법 일부개정법률안(김남희 의원 대표발의)(의안번호 2210405) 3
11. 국민연금법 일부개정법률안(박희승 의원 대표발의)(의안번호 2201942) 3
12. 국민연금법 일부개정법률안(김선민 의원 대표발의)(의안번호 2201013) 3
13. 국민연금법 일부개정법률안(김미애 의원 대표발의)(의안번호 2211802) 3
14. 국민건강보험법 일부개정법률안(한지아 의원 대표발의)(의안번호 2212942) 3
15. 국민건강보험법 일부개정법률안(김선민 의원 대표발의)(의안번호 2212927) 3
16. 국민건강보험법 일부개정법률안(임종득 의원 대표발의)(의안번호 2213321) 3
17. 국민건강보험법 일부개정법률안(서미화 의원 대표발의)(의안번호 2210400) 3
18. 정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률 일부개정법률안(김예지 의원 대표발의)(의안번호 2213293) 3
19. 응급의료에 관한 법률 일부개정법률안(소병훈 의원 대표발의)(의안번호 2205860) ... 3
20. 응급의료에 관한 법률 일부개정법률안(이수진 의원 대표발의)(의안번호 2210220) ... 3
21. 공공보건의료대학 설립·운영에 관한 법률안(박희승 의원 대표발의)(의안번호 2201301) 3
22. 공중보건장학을 위한 특례법 전부개정법률안(김문수 의원 대표발의)(의안번호 2201520) 3
23. 자살예방 및 생명존중문화 조성을 위한 법률 일부개정법률안(정부 제출)(의안번호 2209098) 3
24. 비만질환의 예방 및 관리에 관한 법률안(이주영 의원 대표발의)(의안번호 2207836) 3
25. 비만 예방 및 관리에 관한 법률안(박희승 의원 대표발의)(의안번호 2205679) 3
26. 국민건강증진법 일부개정법률안(전용기 의원 대표발의)(의안번호 2212345) 3

○소위원장 이수진 좌석을 정돈해 주시기 바랍니다.

성원이 되었으므로 제429회 국회(정기회) 제2차 법안심사제2소위원회를 개최하겠습니다.

법안심사에 들어가도록 하겠습니다.

1. 축산물 위생관리법 일부개정법률안(김미애 의원 대표발의)(의안번호 2209417)
2. 식품위생법 일부개정법률안(장종태 의원 대표발의)(의안번호 2206715)
3. 식품위생법 일부개정법률안(김도읍 의원 대표발의)(의안번호 2203138)
4. 식품위생법 일부개정법률안(강선우 의원 대표발의)(의안번호 2207231)
5. 식품위생법 일부개정법률안(강선우 의원 대표발의)(의안번호 2208925)
6. 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 일부개정법률안(김남희 의원 대표발의)(의안번호 2203011)
7. 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 일부개정법률안(이개호 의원 대표발의)(의안번호 2204184)
8. 장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률 일부개정법률안(최보윤 의원 대표발의)(의안번호 2209999)
9. 노인복지법 일부개정법률안(안상훈 의원 대표발의)(의안번호 2209698)
10. 노인복지법 일부개정법률안(김남희 의원 대표발의)(의안번호 2210405)
11. 국민연금법 일부개정법률안(박희승 의원 대표발의)(의안번호 2201942)
12. 국민연금법 일부개정법률안(김선민 의원 대표발의)(의안번호 2201013)
13. 국민연금법 일부개정법률안(김미애 의원 대표발의)(의안번호 2211802)
14. 국민건강보험법 일부개정법률안(한지아 의원 대표발의)(의안번호 2212942)
15. 국민건강보험법 일부개정법률안(김선민 의원 대표발의)(의안번호 2212927)
16. 국민건강보험법 일부개정법률안(임종득 의원 대표발의)(의안번호 2213321)
17. 국민건강보험법 일부개정법률안(서미화 의원 대표발의)(의안번호 2210400)
18. 정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률 일부개정법률안(김예지 의원 대표발의)(의안번호 2213293)
19. 응급의료에 관한 법률 일부개정법률안(소병훈 의원 대표발의)(의안번호 2205860)
20. 응급의료에 관한 법률 일부개정법률안(이수진 의원 대표발의)(의안번호 2210220)
21. 공공보건의료대학 설립·운영에 관한 법률안(박희승 의원 대표발의)(의안번호 2201301)
22. 공중보건장학을 위한 특례법 전부개정법률안(김문수 의원 대표발의)(의안번호 2201520)
23. 자살예방 및 생명존중문화 조성을 위한 법률 일부개정법률안(정부 제출)(의안번호 2209098)
24. 비만질환의 예방 및 관리에 관한 법률안(이주영 의원 대표발의)(의안번호 2207836)
25. 비만 예방 및 관리에 관한 법률안(박희승 의원 대표발의)(의안번호 2205679)
26. 국민건강증진법 일부개정법률안(전용기 의원 대표발의)(의안번호 2212345)

○소위원장 이수진 의사일정 제1항 축산물 위생관리법 일부개정법률안부터 의사일정 제26항 국민건강증진법 일부개정법률안까지 이상 26건의 법률안을 일괄하여 상정합니다. 심사 대상 안건의 명칭 및 순서는 배부해 드린 의사일정을 참고해 주시기 바랍니다.

효율적인 진행을 위하여 안전 순서대로 심사를 진행하되 같은 제명의 법률안의 경우 해당 법률안의 심사를 모두 마친 후 의결하도록 하겠습니다.

오늘 심사는 식품의약품안전처 소관 법률안부터 시작하겠습니다.

식품의약품안전처 김용재 차장님 수고해 주시기 바랍니다.

의사일정 제1항 축산물 위생관리법 일부개정법률안을 심사하겠습니다.

수석전문위원 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 이지민 자료 3쪽입니다.

현행법 제7조 1항에서는 가축의 도살·처리, 집유, 축산물의 가공·포장 및 보관은 제22조 1항에 따라 허가를 받은 작업장에서 하도록 하되 학술연구용으로 사용하기 위하여 도살·처리하는 경우 등 예외를 규정하고 있습니다.

개정안은 식품위생법 제37조 5항 본문에 따라 등록하여야 하는 영업으로서 대통령령으로 정하는 영업의 시설에서 축산물을 가공·포장 또는 보관하는 경우에도 허가를 받은 작업장 외에서 할 수 있도록 하려는 것입니다.

참고로 식품위생법 37조 5항 본문에 따라 등록하여야 하는 영업은 5페이지 왼쪽 편 하단의 조문을 참고해 주시기 바랍니다.

초고압살균기 등의 설치비가 고가인 점을 고려할 때 개정안에 따라 밀봉 포장된 축산물의 살균, 멸균 또는 급속냉동 공정시설의 임차 대상을 확대하게 될 경우 식품제조·가공업자 등의 부담을 완화할 수 있을 것으로 보입니다.

5페이지입니다.

다만 등록대상 영업인 식품제조·가공업, 식품첨가물제조업, 공유주방 운영업 중 어디까지를 허용대상으로 할 것인지 논의가 필요한 것으로 보입니다.

다음, 7쪽입니다.

도축업 및 축산물가공업 영업자의 자체위생관리기준 작성 운영·의무 규정 삭제입니다.

8쪽입니다.

현재 도축업 및 집유업의 영업자는 자체위생관리기준 및 자체 HACCP을 모두 작성·운영하고 있는 실정입니다. 자체위생관리기준의 항목과 자체 HACCP의 항목이 중복됨에도 불구하고 영업자는 2개 기준을 모두 작성·운영하여야 하는 불편함이 있습니다. 또한 축산물가공업의 경우 HACCP 의무적용이 완료되어 자체위생관리기준의 작성·운영이 면제됨에도 불구하고 자체위생관리기준을 작성·운영하여야 하는 대상으로 규정되어 있습니다.

이에 개정안은 자체 HACCP 작성·운영 대상인 도축업의 영업자 및 HACCP 의무화가 완료된 축산물가공업의 영업자를 자체위생관리기준 작성·운영 대상에서 제외하려는 것으로 필요한 입법조치로 보입니다.

11쪽입니다.

현행법령에 따르면 식용란을 생산하는 가축의 사육시설에서 직접 식용란을 수집하여 판매하는 식용란수집판매업의 영업자에게는 자가품질검사 의무가 부과되고 있는데 개정안은 식용란선별포장업의 영업자 중 대통령령으로 정하는 영업자에 대해서도 자가품질검사 의무를 부과하려는 것입니다.

12쪽입니다.

식용란선별포장업의 영업자가 자신이 직접 선별·세척 등을 거쳐 포장한 달걀을 판매하는 경우에는 식용란수집판매업의 신고를 별도로 하지 않더라도 식용란의 판매가 가능함에도 불구하고 현재 자가품질검사 의무가 없는 실정인데 개정안은 이러한 경우 자가품질검사 의무를 부과하려는 것으로 타당한 것으로 보입니다.

다만 안 부칙 제2조 적용례는 문구를 보다 명확히 수정할 필요가 있는 것으로 보입니다.

다음, 14쪽입니다.

위해 축산물에 대한 검사명령제 도입입니다.

15쪽입니다.

개정안은 국내외에서 유해물질이 검출된 축산물, 그 밖에 국내외에서 위해발생의 우려가 제기되었거나 제기된 축산물 등 어느 하나에 해당하는 축산물의 처리·집유·가공·포장·보관·운반 또는 판매 등을 하는 영업자에 대하여 식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률에 따른 축산물시험·검사기관 또는 국외시험·검사기관에서 검사를 받을 것을 명할 수 있도록 하되 검사로써 위해성분을 확인할 수 없다고 식약처장이 인정하는 경우에는 관계 자료의 제출로 갈음할 수 있도록 하고 이를 위반하여 검사기한 내에 검사를 받지 아니하거나 자료 등을 제출하지 아니한 자에게는 500만 원 이하의 과태료를 부과하도록 하려는 것으로 축산물의 안전관리 강화에 기여할 것으로 보입니다.

16쪽입니다.

자구수정 의견이 있습니다.

검사명령 대상은 축산물에 한정되는 것이므로 안 제12조의4제3항의 ‘축산물등’을 ‘축산물’로 수정할 필요가 있습니다.

다음, 21쪽입니다.

위해 평가를 위해성평가로 용어 통일하고 삭제된 조항 인용 조문을 정비하려는 것으로 별다른 문제가 없는 것으로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 이수진 정부 측 의견 들겠습니다.

○식품의약품안전처차장 김용재 개정안의 입법 취지와 수석전문위원의 수정안에 동의합니다.

○소위원장 이수진 질의하실 위원님들 계십니까?

김미애 의원님 대표발의한 법안이신데요.

○김미애 위원 잘 만들어져서 질의를 안 하겠다는데…… 속도를 내서……

○소위원장 이수진 잘 정리된 것 같습니까?

○김미애 위원 예. 제가 발의했는데 수석전문위원께서 문제점을 잘 지적해 주셨고 그에 대한 수정안도 잘 마련돼서 그대로 가면 될 것 같습니다.

○소위원장 이수진 그러면 더 이상 질의하실 위원님이 안 계시면 의결하겠습니다.

의사일정 제1항 축산물 위생관리법 일부개정법률안은 수정안을 채택하여 수정한 부분은 수정한 대로, 기타 부분은 원안대로 의결하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

의사일정 제2항부터 제5항까지 식품위생법 일부개정법률안을 심사하겠습니다.

수석전문위원 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 이지민 먼저 식품위생교육 제도 관련된 내용 보고드리겠습니다.
4쪽입니다.

현행법 제41조는 식품위생교육에 관하여 규정하고 있지만 교육 실시기관의 지정 기준 및 그 요건 등에 관하여 규정하고 있는 사항은 없어서 어떠한 기준이나 절차에 따라 교육 실시기관으로 지정되는지 알 수가 없고 행정처분의 성격을 지닌 지정취소는 그 요건과 근거를 법률에 두어야 함에도 불구하고 규정하고 있지 않은 문제가 있습니다. 식품위생교육기관의 지정 및 지정취소에 관한 근거 등을 법률에 직접 규정하려는 것으로 타당한 것으로 보입니다.

6쪽입니다.

검토의견 말씀드리면 김도읍 의원안은 식약위생교육기관의 지정 및 지정취소 권한을 식약처장 외에 시·도지사에게도 부여하고 있는데 식약처는 식품위생교육기관의 지정 주체를 다원화할 경우 교육기관의 지정, 운영 및 평가의 일관성을 확보하기 어려울 수 있다는 의견이고 식품산업협회 등 관련 단체도 지역별로 위생교육기관이 지정되어 교육의 수준이나 운영에 편차가 생길 수 있는 우려가 있으며 교육기관 난립에 따른 위생교육 부실화가 초래될 우려가 있다는 입장입니다. 따라서 식품위생교육기관의 지정 주체를 현행대로 식약처장으로 일원화하는 것이 바람직한 것으로 보입니다.

또한 김도읍 의원안은 식품위생교육기관의 지정 대상을 총리령에 위임하고 있는 반면 장종태 의원안과 강선우 의원안은 현행 시행규칙에서 규정하고 있는 교육기관을 법률로 상향하여 명시하고 있습니다. 식품위생교육기관의 지정 대상을 동업자조합, 식품산업협회 및 식품위생을 목적으로 식약처장의 허가를 받아 설립된 비영리법인으로 규정할 수 있을 것으로 보입니다.

8쪽부터는 수정조문입니다.

자구수정 외에 주요 수정의견 말씀드리면—14쪽입니다—식품위생교육기관은 식약처장의 자료제출 요청에 대하여 정당한 사유가 없으면 이에 따르도록 규정하는 내용을 추가하였습니다. 후단을 추가했습니다.

다음, 17쪽입니다.

17쪽 하단에 자료제출 요청에 따르지 아니한 경우를 행정처분 대상으로 추가하였습니다.

다음, 19쪽입니다.

시행일은 지금 개정안들은 6개월로 되어 있습니다만 식약처에서 하위 법령 등 시행 준비를 위해서 시간이 1년 정도 필요하다는 의견이 있어서 수정의견에서는 1년으로 담았습니다.

다음, 20쪽입니다.

앞의 내용과 유사한 취지인데요 조리사·영양사 교육제도 관련된 내용입니다.

21쪽입니다.

장종태 의원안과 강선우 의원안은 조리사 및 영양사 전문교육기관 지정에 관한 법적 근거를 마련하고 전문교육기관이 거짓이나 그밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 경우 등

에는 지정을 취소하거나 업무의 정지 또는 시정을 명할 수 있도록 하는 것입니다.

23쪽입니다.

장종태 의원안은 조리사 및 영양사에 대한 교육을 식품위생 관련 교육을 목적으로 하는 전문기관 또는 단체를 지정하여 교육의 실시를 위탁하도록 규정하고 있는 반면 강선우 의원안은 대한영양사협회와 한국조리사협회중앙회를 교육위탁기관으로 명시하고 있습니다.

강선우 의원안의 경우 조리사 교육은 한국조리사협회중앙회가, 영양사 교육은 대한영양사협회가 향후에도 현재와 같이 해당 교육을 독점적으로 수행하게 될 것으로 보이기에 따라 식약처장이 안 제56조의2에 따라 업무정지 또는 지정취소 처분을 하게 될 경우 조리사 또는 영양사가 교육을 이수할 수 없는 상황이 발생할 우려가 있습니다.

또한 장종태 의원안과 관련해서는 대한영양사협회와 한국조리사협회중앙회가 교육기관 지정 대상을 전문기관 또는 단체로 규정하는 데 반대 의견을 제시하고 있는 반면 식약처는 현행법 제56조제3항에서도 관계 전문기관이나 단체에 위탁할 수 있도록 규정하고 있다는 의견임을 고려할 필요가 있는 것으로 보입니다.

수정의견은 대한영양사협회와 한국조리사협회중앙회를 교육위탁기관으로 명시하되 식품위생교육기관 지정 대상과 같이 식품위생을 목적으로 식약처장의 허가를 받아 설립된 비영리법인을 교육위탁기관으로 추가하는 내용으로 되어 있습니다.

25쪽부터 수정조문이 있는데요. 자구정리 외에 주요내용 말씀드리면, 27쪽입니다.

말씀드린 대로 전문교육기관 지정 대상과 관련하여 수정의견을 3개 호로 정리하였습니다.

29쪽입니다.

자료제출 요청에 대하여 정당한 사유가 없으면 응하도록 하는 내용을 추가하였고요. 32쪽에 자료제출 요청에 따르지 아니한 경우를 행정처분 대상으로 추가하였습니다.

이상입니다.

○소위원장 이수진 정부 측 의견 들겠습니다.

○식품의약품안전처차장 김용재 개정안의 취지와 수석전문위원 수정의견에 동의합니다.

○소위원장 이수진 수석전문위원 수정의견의 뒷 부분에 영양사협회, 조리사협회 외에 식약처에서……

○식품의약품안전처차장 김용재 설립된 비영리법인……

○소위원장 이수진 비영리법인 추가해서……

혹시 위원님들 의견 있으신가요?

○김미애 위원 방금 간사님 말씀하신 것, 이것은 필요해 보입니다, 아까 수석전문위원 지적대로. 그래서 별다른 이견 없습니다.

○소위원장 이수진 장종태 위원님 말씀해 주세요.

○장종태 위원 식품위생교육과 관련해서 식품위생업 관련 단체에서 상당히 많이 저에게 민원성의 의견을 제시했어요. 식품위생교육을 시키는 것이 식품위생교육의 전문성을 가지고 있는 사람들이 교육할 수 있도록 해야지 교육을 위한 교육기관을 만들어서 운영을 하다 보니까 운영하는 과정에서 상당히 많은 혼란도 발생하고 어려움이 있다.

그래서 그분들 이야기는 다른 것은 다 지금 똑같습시다만 식약처장의 허가를 받아 설

립된 비영리법인이라고 했는데 식약처장의 허가를 받아 설립된 업종별 비영리법인으로 좀 해서 자기들 분야에 대해서는 아무래도 더 전문성이나 이런 것이, 또 실질적으로 필요성에 대한 어떤 대목에서……

그러니까 위생업소라고 하면 위생과 관련해서 좀 더 심도 있는 교육을 통해서 효과를 제고시킬 수 있다. 그래서 그 업종별 비영리법인으로 좀 세분화를 해서 규정을 해 줄 것을 요구를 했습니다. 이 부분이 꼭 담겨야 되겠다 하는 말씀을 드리고요. 어쨌든 당사자들, 관계자들이 꼭 필요하다고 하는 사항이기 때문에 특별한 문제가 없다고 하면 그걸 좀 수용했으면 좋겠다 하는 의견을 드립니다.

○소위원장 이수진 차장님 답변 주십시오.

지금 장종태 위원님은 대한영양사협회, 한국조리사협회중앙회를 교육위탁기관으로 명시하되 식약처장의 허가를 받아 설립된 업종별 비영리법인으로 하면 좋겠다 이런 의견을 주신 거잖아요. 답변 주세요.

○식품의약품안전처차장 김용재 일단 위원님 말씀하신 부분은 업종의 특성이 있으니까 그 특성을 반영해서 전문성 있는 기관을 중심으로 진행했으면 좋겠다는 취지는 이해해 가지고요 수정하도록 하겠습니다.

○김미애 위원 하나만 질의할게요.

비영리법인이 많습니까? 게다가 업종별로 세분화되어서 얼마나 있을까요?

○식품의약품안전처차장 김용재 현재 식약처에 법인은 식품분야는 32개가 있습니다.

○김미애 위원 업종별로?

○식품의약품안전처차장 김용재 아니, 이 중에 11개는 동업자조합, 식품산하협회해 가지고 실제로 교육하는 것이……

○김미애 위원 제가 질의한 것은 지금 영양사협회, 한국조리사협회중앙회 이분들만 하면 여기에 이 협회에 문제가 생길 때 교육기관이 없어지기 때문에 문제잖아요.

○식품의약품안전처차장 김용재 예, 맞습니다.

○김미애 위원 그래서 정하는데 업종별 비영리법인이 어느 정도 있는지 그게 파악이 돼야지 아니면 그게 또 뭐 1개가 있다든지 뭐……

○소위원장 이수진 지금 35페이지에 식품위생 관련 비영리법인 현황은 있어요. 그런데 지금 김미애 위원님은 말씀은 업종별 비영리법인으로 한정했을 때 여기서 몇 개나 되는지 예를 들면 여기에서 해당되는 데가 몇 개나 해당되나 이런 거 있을 것 같은데요.

○김미애 위원 그러니까 이게 최소한 3개 이상은 된다든지 5개 이상은 된다든지 그러면 지적하신 대로 해도 저는 무방하다고 봅니다.

○식품의약품안전처차장 김용재 현재로서는 식약처가 설립 허가한 곳도 있고요. 앞으로 이게 법이 되면 새롭게 이런 분야 해서 들어올 기관도 있다고 보고 있거든요. 현재 이 기관 같은 경우에도 이 법이 통과가 되면 그 업종에 맞게끔 또 신청할 수 있는 부분이 있기 때문에 아까 말씀하신 대로 그런 업종을 고려해 가지고 교육기관을 지정해서 관리 하면……

○김미애 위원 그러니까 식약처는 최소한 법안 심사를 하고 정부 의견을 낼 때는 그렇게 파악이 돼야 돼요. 그러면 우리가 심사를 할 때 큰 무리 없이 거기에 동의를 할 수 있는데 만약에 그 파악이 안 된 채 없다면 또 부랴부랴 이제 만들어야 되는데 그 과정이

이 입법 취지와 맞지 않을 것 같거든요. 그래서 최소한 이름으로 보면 비영리법인이 쪽 있는데, 몇 개는 있을 것도 같기도 한데……

○**식품의약품안전처차장 김용재** 예를 들자면 일단은 한국식품영양과학회도 있고요. 한국식품안전연구원도 있고 한국급식협회도 있고 집단급식조리사협회 등도 있습니다.

○**김미애 위원** 그게 영양사협회? 2개 중복될 것 같기도 한데요, 성격이. 영양사협회나 한국조리사협회중앙회가 업종별로 하더라도 분리가 됩니까, 두 업종이? 교육기관으로 한정해서 말씀드리는 겁니다.

○**식품의약품안전처차장 김용재** 일단 영양사협회는 집단급식소에 근무하는 영양사를 대상으로 교육하도록 돼 있습니다.

○**김미애 위원** 그러니까 업종별로 할 때 여기에 표를 보면 해당되는 게 있나요?

○**식품의약품안전처차장 김용재** 이쪽에 보면 이게……

○**김미애 위원** 영양사 관련하면?

○**수석전문위원 이지민** 잠깐, 앞에가 식품위생교육이고요. 두 번째가 조리사, 영양사에 대한 건데요. 지금 장종태 위원님 말씀하신 거는 앞에 식품위생교육 11쪽 말씀하신 것 같고요. 뒤에 27쪽에 영양사협회랑 조리사협회중앙회 관련해서는 업종별 넣자는 의견은 아니신 걸로 저는 알고 있는데요.

○**소위원장 이수진** 11쪽에 넣자는 말씀이신가요?

○**김미애 위원** 41조의3 이거 말씀하신 거예요? 장종태 위원님은 식품위생교육 말씀하시는 거지요?

○**장종태 위원** 그렇지요, 식품위생교육.

○**김미애 위원** 그러면 41조의3을 말씀하시는 거네요.

○**장종태 위원** 그렇지요.

○**김미애 위원** 그러면 동업자조합, 한국식품산업협회 그다음에 식품위생을 주된 목적으로 설립된 비영리법인……

○**소위원장 이수진** 이 비영리법인 앞에다가 업종별을 넣어 달라는 건가요?

○**김미애 위원** 여기다가 업종별을 추가해 달라는 그 취지입니까?

○**장종태 위원** 그렇습니다.

○**김미애 위원** 그럼 아까 그 말씀에 다른 거네.

○**소위원장 이수진** 이거에 대한 의견은 어떠신 건가요?

○**식품의약품안전처차장 김용재** 아까 말씀드린 대로 이게 업종별 특성이 있으니까 그런 특성을 반영해서 그런 기관이 들어올 수 있도록 해 달라는 취지로 이해해 가지고요. 그렇게 운영하도록 하겠습니다.

○**소위원장 이수진** 그래요.

김윤 위원님.

○**김윤 위원** 저는 56조의2에 대해서 질의드리겠습니다.

이 조항과 관련해서 영양사협회, 조리사협회중앙회가 다 교육기관의 난립 문제를 우려하고 있는데 그런 우려에도 불구하고 식약처가 추가로 교육기관을 지정할 수 있도록 하는 법적 근거를 만드는 데는 동의하는데요. 이게 관련 단체의 우려를 고려해서 추가로 교육기관을 지정하실 때 영양사협회나 조리사협회중앙회의 의견을 들어서 교육기관이 난

립한다는 우려가 현실화되지 않도록 그렇게 법의 시행 과정에서 신경을 좀 써 주시면 좋겠습니다.

○식품의약품안전처차장 김용재 예, 알겠습니다.

○김미애 위원 그럼 아까 56조의2는 수정안대로고?

○소위원장 이수진 위원님들 의견 더 없으신가요?

(「없습니다」 하는 위원 있음)

그러면 이 부분 수정안 그대로.

○김미애 위원 아니, 그거만 고쳐야지.

○소위원장 이수진 그러면 아까 지적한 56조의 그 수정안을 다시 한번 말씀해 주시겠어요? 어떻게 되는 거지요?

○수석전문위원 이지민 56조의2요? 자료 27쪽에 3개 호로 있습니다. 1호가 영양사협회고요. 2호가 한국조리사협회중앙회입니다. 이렇게 하자는 게 강선우 의원안이었고요. 관련 단체를 넣자는 게 장종태 의원님 안이었습니다, 관련 전문기관. 그래서 그걸 3호로 민법에 따라 식품위생을 주된 목적으로 설립된 비영리법인 이렇게 추가한 것입니다.

○소위원장 이수진 예, 그럼 그렇게……

○김윤 위원 제 의견은 수정안에 동의하는데 시행 과정에서 두 단체, 기존 큰 단체의 의견을 잘 반영해서 시행하면 좋겠다라는 겁니다.

○소위원장 이수진 차장님, 그렇게 하실 거지요?

○식품의약품안전처차장 김용재 예, 그렇게 하도록 하겠습니다.

○소위원장 이수진 그러면 더 이상 위원님들 의견이 없으시므로 의사일정 제2항부터 제5항까지 이상 4건의 식품위생법 일부개정법률안은 이를 통합 조정하고 위원님들과 전문위원의 의견을 반영하여 위원회 대안으로 채택하며 본회의에 부의하지 않는 것으로 의결하고자 합니다.

이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

이상으로 식품의약품안전처 소관 법률안에 대한 심사를 마치도록 하겠습니다.

김용재 차장님 수고하셨습니다.

지금부터 질병관리청 소관 법률안을 심사하겠습니다.

임숙영 차장님 수고해 주시기 바랍니다.

○질병관리청차장 임숙영 예.

○소위원장 이수진 의사일정 제6항 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 일부개정법률안을 심사하겠습니다.

전문위원 보고해 주시기 바랍니다.

○전문위원 정경윤 보고드리겠습니다.

자료 2쪽입니다.

김남희 의원안입니다.

개정안은 감염병관리위원회의 심의사항으로 기존의 예방접종의 실시기준과 방법에 관한 사항 외에 실시 대상·시기 및 주의사항을 추가하면서 이를 질병관리청장이 고시하도

록 하고 있습니다.

검토의견입니다.

현행 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률에서는 예방접종의 실시기준과 방법에 관하여 필요한 사항은 보건복지부령으로 정하도록 하고 있습니다. 이에 따른 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙에서는 예방접종의 실시 대상·시기 및 주의사항은 예방접종전문위원회의 심의를 거쳐 질병관리청장이 고시하도록 규정하고 있습니다.

금번 개정안은 법률의 명확성 제고를 위하여 기본적으로 이러한 시행규칙의 내용을 법률로 상향하여 규정하는 것으로 내용상 별다른 문제는 없는 것으로 보았습니다.

수정의견으로 일부 자구 정비가 있었습니다.

이상입니다.

○소위원장 이수진 정부 측 의견 들겠습니다.

○질병관리청차장 임숙영 지금 개정안에서는 실시기준 및 방법에 포함되는 실시 대상·시기, 주의사항 등을 구체화한 내용이 있어서 법의 문구가 좀 더 의미가 명확해질 수 있을 것으로 보입니다. 저희는 수용합니다.

○소위원장 이수진 질의하실 위원님 있으십니까?

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

그러면 특별한 질문이 없으시니까……

감염병 예방 및 관리에 관한 법률 일부개정법률안을 모두 심사한 후에 의결하도록 하겠습니다.

의사일정 제7항 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 일부개정법률안을 심사하겠습니다.

전문위원 보고해 주시기 바랍니다.

○전문위원 정경윤 보고드리겠습니다.

자료 2쪽입니다.

이개호 의원안입니다.

개정안은 소독업자가 사망한 경우 그 상속인, 소독업자가 영업을 양도한 경우 그 양수인 등에 대해서는 소독업자의 지위가 승계되도록 하면서 지위를 승계한 자는 지자체장에 그 사실을 신고하도록 하려는 것입니다.

검토의견입니다.

현행법은 소독업 지위승계에 관한 규정이 없어 지위승계를 위해서는 기존 소독업의 폐업 후 신규로 신고를 해야 하는 문제가 있는데 지위승계 규정 명시로 소독업 운영의 연속성이 보장되어 기존 소독업 폐업 및 신규 소독업 개설에 드는 행정적·사회적 비용 절감에 도움이 될 것으로 보입니다.

옆에 연간 소독업 개설 및 폐업 현황표를 보시면 2021년부터 2023년까지 3년간 지위승계를 위한 폐업은 41건에 이르는 것으로 파악되고 있습니다. 그 외 식품위생법, 공중위생관리법 등에서도 지위승계 규정을 두고 있습니다.

수정의견입니다.

개정안에서는 지위승계 신고를 하지 아니한 자에 대해서만 300만 원 이하의 벌금에 처하도록 하고 있는데 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지위승계 신고를 한 경우를 포함

해서 처벌하도록 하는 것으로 일부 문구를 정비하였습니다.

이상입니다.

○소위원장 이수진 정부 측 의견 들겠습니다.

○질병관리청차장 임숙영 이번 개정안은 소독업의 지위승계를 신설해서 소독업을 영위하는 국민들의 편의를 증진한다는 측면에서 수정의견을 수용합니다.

○소위원장 이수진 질의하실 위원님 있으십니까?

없으신 것 같네요.

차장님, 그동안 소독업 폐업하고 나서 다시 지위 승계하고 이런 불편함이 많이 있으셨네요.

○질병관리청차장 임숙영 예, 여태까지 그랬던 것 같습니다.

○소위원장 이수진 민원이 많이 쇄도했을 것 같은데……

○김미애 위원 그러니까요. 21년부터 이러는데 어떻게 지금까지는 그냥 있었는데 모르겠네.

○소위원장 이수진 그러면 위원님들 더 이상 질의가 없으시니까 의사일정 제6항 및 제7항 이상 2건의 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 일부개정법률안은 이를 통합 조정하고 위원님들과 전문위원의 의견을 반영하여 위원회 대안으로 채택하며 본회의에 부의하지 않는 것으로 의결하고자 합니다.

이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

이상으로 질병관리청 소관 법률안에 대한 심사를 마치도록 하겠습니다.

임숙영 차장님 수고하셨습니다.

○질병관리청차장 임숙영 감사합니다.

○소위원장 이수진 지금부터 보건복지부1차관 소관 법률안을 심사하도록 하겠습니다.

이스란 1차관님 수고해 주시기 바랍니다.

○보건복지부제1차관 이스란 예, 위원장님.

○소위원장 이수진 의사일정 제8항 장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률 일부개정법률안을 심사하겠습니다.

전문위원 보고해 주시기 바랍니다.

○전문위원 오세일 자료 2쪽입니다.

개정안은 장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률에 근거하여 제기된 소송에서 패소한 당사자의 소송비용 전부 또는 일부를 국가가 지원할 수 있도록 하려는 것으로 장애인의 사법 접근성 제고와 인권 보장 측면에서 긍정적인 효과가 있을 것으로 보입니다.

다만 이 법에 근거하여 제기된 장애인의 권리에 관한 소송을 지원 대상으로 규정하고 있는데 적용 범위가 다소 포괄적으로 해석될 소지가 있으므로 소송의 공익성, 소송 당사자의 경제적 취약성 등과 같은 구체적 요건을 법률에 명시하는 방안을 논의할 필요가 있다고 보았습니다.

또한 개정안은 패소한 당사자에 대한 소송비용 지원만 규정하고 있는데 실제 장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률에 따른 공익소송은 패소 사례도 많지만 조정이나 화

해권고결정 등에 의한 종결 사례도 적지 않기 때문에 이러한 경우를 포함할 수 있도록 수정이 필요하다고 보았고, 개정안은 시행일을 공포 후 3개월이 경과한 날로 규정하고 있는데 관련 예산 확보나 시범사업 실시, 하위법령 개정 등에 걸리는 시간을 고려하여 충분한 유예기간을 부여할 필요가 있다고 보았습니다.

다만 기획재정부나 법무부에서 반대 의견을 제시하고 있어 수정의견은 따로 달지 않습니다.

이상입니다.

○소위원장 이수진 정부 측 의견 들겠습니다.

○보건복지부제1차관 이스란 전문위원 말씀하신 대로 현재 법률 조항에 대상자가 좀 구체적이지 않다는 점 그다음에 사실은 소송비용이 패소자 부담 원칙하고 상충된다는 문제 그다음에 법원에서도 지금 소송구조 제도를 운영하고 있어서 다른 제도와의 중복 문제 등이 있어서 우선 정부는 신중한 입장 갖고 있습니다.

○소위원장 이수진 질의하실 위원님 있으신가요?

○김미애 위원 차관님, 혹시 장애인 말고 다른 국민들 중에는 이렇게 소송비용의 전부 또는 일부를 국가가 지원할 수 있도록 규정하는 게 없습니까, 보건복지부 산하에? 아동 관련 한다면지 한부모라든지. 별로 없어요?

○보건복지부제1차관 이스란 없는 걸로 알고 있고요. 장애인은 저희가 법률구조법에 따라 예산 사업으로 일부 지원은 하고는 있습니다.

○김미애 위원 장애인은?

○보건복지부제1차관 이스란 예.

○김미애 위원 법률구조법에 따라서?

○보건복지부제1차관 이스란 예, 법률구조공단하고 저희가 해서요 일부는 좀 지원을 하고 있고 최보운 의원님 발의하신 거는 조금 더 폭넓게 지원하자는 취지로 이해는 하고 있습니다.

○김미애 위원 제가 볼 때는 전문위원님 의견처럼 그냥 이게 개정안처럼 그대로 하면 너무 범위가 넓어지는 문제가 있기 때문에 여기에서 구체적 요건을 소송의 공익성, 소송 당사자의 경제적 취약성 등 이런 것에 따라서 보건복지부령에 위임해서 그런 경우에는 지원할 수 있다 정도는 할 수 없나요? 그렇게 하면 좀 구체적이고 남소의 우려도 줄어들고 그런 과정에서……

진짜로 이 규정은 있지만 권리구제를 실질적으로 못 하게 되는 게 패소 부담 때문에 아예 못 할 가능성이 있잖아요. 승소를 자신하는 것은 별로 문제 되지 않을 거고 소송까지 안 갈 텐데, 애매모호한데 꼭 권리구제가 필요한 것 가지고 소송으로 갈 텐데 그러면 이것 때문에 아예 봉쇄되는 것이기 때문에 이 요건을 부령이라도 위임하든지 아니면 대통령령에 위임해서 구체화시켜서……

○최보운 위원 대통령령으로 위임되어 있습니다. ‘할 수 있다’ 해서 대통령령에 위임 있습니다.

○김미애 위원 대통령령이에요?

○보건복지부제1차관 이스란 예, 위임 조항은 있습니다.

○김미애 위원 그렇게 위임 조항이 있네요.

그러면 이것을 지원의 대상과 범위, 절차, 이렇게 하면 또 그냥 무턱대고 남소할 우려도 있어서 이 안에다가 전문위원이 지정한 이 정도의 내용을 포함시키면 어떨까요? 그러면 권리구제를 받으려고 하는 사람들도 좀 더 고민해서 시작할 수도 있을 것 같기 때문에 그 방법은 어떻습니까?

○**보건복지부제1차관 이스란** 위원님 말씀대로 현행 조문이 포괄위임이기 때문에 구체화는 필요하다고 판단하고 있고요.

또 하나는 어차피 법안이 법사위를 가야 되는데 법무부가 완강하게 반대하는 입장이어가지고 부처 협의도 필요한 상황이기는 합니다. 법률 조문을 좀 구체화해서 법무부가 운영하고 있는 소송구조제도하고 상충 문제가 없다든지 아니면 우리가 포괄적으로 보호하기 위한 거라든지 그렇게 협의가 사실은 좀 필요합니다.

○**김미애 위원** 현장에 있다 보면 여러 소송구조제도가 있기는 해요.

○**보건복지부제1차관 이스란** 예, 그렇습니다.

○**김미애 위원** 굳이 여기 아니어도 사실은 변호사협회에서도 구조하기도 하거든요. 그런데 또 발의하신 최보운 의원님 취지를 보면 아예 위축돼서 출발도 못 하는 그런 어려움이 있기 때문에 조금 더 법률에서 구체화시켜서 하는 것도 하나의 방법이겠다 싶습니다.

○**소위원장 이수진** 최보운 위원님 의견 말씀하시지요.

○**최보운 위원** 제가 조금 구체적으로 분석해서 설명을 드리겠습니다.

현행 소송구조제도가 있는데요. 현행 소송구조제도를 보시면 소송비용을 부담할 자금능력이 부족할 것이라는 부분이 있습니다. 그래서 이런 것들을 보면 경제적으로 취약한 분들만 소송구조가 되고요. 김미애 위원님 말씀하신 한부모가족 같은 경우에는 소송구조 받을 때 대상자가 되지만 장애인이라는 이유로 소송구조가 되지는 않고요. 따라서 소송구조제도에서는 장애인이면서 취약한 부분은 되고, 경제적으로 취약한 수급자라든지 여러 요건들이 많이 나와 있고 저는 현장에서 장애인이라는 이유만으로는 소송구조를 받아본 적이 아예 없습니다. 사각지대라고 보시면 됩니다.

그래서 여기 말씀하신 소송 당사자의 경제적 취약성을 만약에 이 법 요건에 넣는다면 이미 취약한 장애인분들은 받고 있기 때문에 굳이 넣을 필요가 없다는 게 제 의견이고요.

또 하나는 말씀하신 패소자 부담 원칙에 대해서 말씀을 드리면 패소자 부담 원칙을 저희가 정면으로 거스르겠다는 게 아니라 여기 의견에 나온 것처럼 유엔 장애인권리위원회에서도…… 국가보고서 최종 견해는 우리가 지켜야 될 부분입니다. 우리가 이것을 그냥 넘어갔을 경우에 다시 또 권고가 나올 부분인데, 여기에 정확하게 나와 있는데 패소하더라도 접근 가능하고 공정한 상환제도를 보장할 것을 권고한 것은 그 이유가 있습니다.

그래서 이런 부분에 대한 사각지대에 우리가 할 수 있는 방법을 여러 가지 고려했을 때 소송구조에서 하는 방법도 있지만 어쨌건 장애인 관련된 유엔 장애인권리위원회의 취지를 봤을 때는 보통 소송구조에서 장애인에 관한 권리를 장차법을 통해서 한다고 하면…… 그래서 이 장차법 안에서 장애인 권리라고 표현을 한 것입니다. 여러 가지에 대한 장애인 권리가 아니라 장차법상 권리에 규정되는 것이 여러 법제 체계를 보더라도 타당하다 그리고 이게 패소자 부담 원칙에도 반하는 부분이 아니게 대통령령으로 위임을

해서 그 부분을 구체화시킬 수 있다라는 취지에서 이 법안 자체로서도 완결성이 있다고 말씀을 드릴 수가 있고요. 그래서 이 사각지대를 해소하려는 노력을 꼭 해야 된다는 부분이고요.

그리고 여기 두 번째에 나온 조정·화해 권고 결정에 대한 종결 사례 말씀을 주셨는데 요.

우리가 변호사 업무에서 조정이나 화해 권고할 때 각자 부담하는 게 원칙이지만 원칙이라는 것뿐이고 이런 조정·화해제도에서는 분명히 또 여러 사정을 고려해서 이 비용에 대한 것들을 할 수 있는 여지가, 룬이 있습니다. 그렇지만 패소했을 경우에는 그런 부분이 불가능하기 때문에 그것까지 고려해서 이 법안을 발의한 것이라고 말씀드리고요. 그래서 둘째 부분은 오히려 되고 있기 때문에 이 법에 넣을 필요가 없다는 부분도 분명히 말씀드립니다.

여기 나온 검토의견 셋째 부분은 만약에 충분한 유예기간을 부여할 필요가 있다면 제안보다 더 충분한 기간을 두고 준비를 충실히 하는 부분에 대해서 좋다는 의견을 드립니다. 괜찮다고 수용 의견을 드립니다.

따라서 이것들을 종합해 볼 때 현 법제 체계하에서 장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률에 넣어서 장애인의 권리라고 표현한 부분은 오히려 적절한 부분이고, 그 부분에 대해서 패소한 당사자로 하는 것도 조정·화해를 빼고 패소한 당사자로 하는 게 오히려 범위를 좁혀서 적절한 부분이고, 또 대통령령으로 정하는 대상으로 해서 더 구체적으로 심사를 해서 남소가 되지 않도록 하는 것도 가능한 부분이기 때문에 적절히 위임된 부분이다, 또 하나 이것을 ‘할 수 있다’라고 재량으로 해서 ‘하여야 한다’랑은 달리 할 수 있도록 해서 이런 부분들을 더 충분히 고려할 수 있는 법이다라고 생각을 해 주시고요.

저희가 이 부분을 좀 빠르게 하고 싶은 이유는 유엔 장애인권리협약이나 유엔 장애인 권리위원회에서 한 부분을 우리가 지키려는 노력을 하지 않는 경우들이 굉장히 많고 지난번에 보셨지만 국감에서 제가 유엔 장애인권리협약의 의무 이행률, 정부에서 얼마나 이행하고 있나 봤을 때 굉장히 낮은 수치입니다.

그리고 제가 변호사 업무를 하면서 법무부 인권정책자문단 회의에도 참여하고 자문단으로 활동을 했었는데요. 거기서도 여러 노력들이 있지만 실질적으로 구체적 성과를 내기가 쉽지 않은 경우들이 많은데 이것들을 우리가 국회 차원에서 법률을 통해서 해결해 나간다면 이런 부분에 정부 이행률도 높이고 또 최종 견해를 수용하려는 노력도 보이는 것에서 우리가 국제적으로 장애인 권리보장의 기준을 한층 더 상향하고 업그레이드하고 국제적 글로벌한 스탠더드에 맞출 수 있는 그런 계기가 될 수 있습니다.

그래서 이런 부분을 잘 검토해 주시고, 오히려 대통령령에서 여러 의견을 거쳐서 구체화할 수 있다면 충분히 제도의 취지와 남용 방지도 막을 수 있다라는 부분에 의견 드립니다.

○소위원장 이수진 혹시 다른 위원님들……

백종현 위원님 하시고 김남희 위원님.

○백종현 위원 차관님 말씀에 대상자가 구체이지 않다고 하셨고 또 법률구조공단에서 일부 지원은 되고 있다고 하셨는데 복지부를 비롯한 관계 부처 모두 소송구조제도로써 장애인이 포함되어 있어서 별도 규정은 실익이 없다고 답변하셨는데 실제로 장애인 권리

관련 소송에서 소송구조가 얼마나 활용되고 있습니까?

○**보건복지부제1차관 이스란** 아까 말씀드린 법률구조공단을 통해서 저희가 한 1300여 건 지원한 바는 있습니다, 위원님.

○**백종현 위원** 민사소송법 제128조는 소송구조 요건으로 소송비용을 지출할 자금능력 부족과 두 번째로 패소할 것이 분명하지 않을 것을 모두 요구하고 있는데, 특히 두 번째 요건인 패소 가능성은 본안 판단 전에 미리 승소 가능성을 입증해야 한다는 그런 의미잖아요. 이는 공익소송 특성상 매우 어렵습니다.

실제로 장애인 권리 소송의 경우는 쟁점을 다루는 경우가 많아서 결과를 예측하기가 어려운데 이런 사건들이 소송구조에서 배제되고 있지는 않은지, 어떻게 생각하십니까?

○**보건복지부제1차관 이스란** 위원님, 저희가 이 안에 대해서 부정적이라는 말씀을 드린 게 아니라 이런 지원의 필요성은 있습니다만 현재 제안해 주신 법률이 포괄위임이고 그 다음에 말씀드린 대로, 아까 장애인권리협약 말씀 주셨는데 이게 주관 부처가 법무부입니다. 그러니까 사실 법무부하고도 얘기를 해 봐야 된다는 이야기인 거고요.

또 하나는 장애인차별금지법상은 법에 보면 입증 책임이 다른 민사소송과 달리 장애인에게 조금 유리하게 되어 있는 점도 있습니다. 그래서 이런 것을 다 했는데도 패소한 사람을 다 지원해야 된다는 이런 논리는…… 복지부 입장에서는 장애인이라는 이유만으로 소송비용을 지원하기는 어렵고 아까 말씀드린 다양한 것을 고려해서 또 다른 취약계층도 있는 점 감안해서 형평하게 봐야 될 필요가 있다는 말씀을 드리는 겁니다.

○**소위원장 이수진** 김남희 위원님.

○**김남희 위원** 사실은 제가 이것 때문에 지금, 제가 예전에 국회의원이 되기 전에 했던 사건으로 되게 어려움을 겪고 있는 게 있어서요.

제가 공익소송을 예전에 진행했는데 굉장히 어려운 상황에 있는 장애인이 학대받아서 사망했는데 그 유족들을 대리해서 관리감독을 소홀히 한 지자체나 국가 그리고 시설장을 상대로 손해배상청구 소송을 해서 상당히 많이 승소를 했어요. 그런데 상당히 많이 승소를 했어도 패소 부분이 있잖아요. 이것에 대해서 지방자치단체와 국가가 유족들에게 소송비용 추심을 보낸 거예요.

그런데 이 승소를 제가 한 3년 전에 했는데 소송비용 확정 절차가 늦어졌다고 이제 와서 추심 청구를 보내 가지고, 그 당시에 배상을 받고 굉장히 어려우신 분들과 그 돈을 다 쓰고 3년이 지나 가지고 갑자기 정부에서 소송비용 추심 청구가 날아오니깐 이분들은 너무 황당한 거지요. 그래서 저를 찾아와 가지고 하소연을 하시고 이런 상황인데……

사실 문제의 가장 근본적인 원인은 이런 사건이 장애인에 대해서만 있는 게 아니고 많은 공익소송에서 일어납니다. 팬찮은 제도개선을 위해서 열심히 좋은 소송을 했는데 전부 패소는 물론이고 일부패소 같은 경우에도 이렇게 소송비용…… 특히 소송비용의 핵심은 결국 변호사 비용이거든요. 변호사 비용이 상당히 크니까 이것을 공익소송의 당사자에게, 대부분 취약한 상황에 놓인 사람에게 청구를 하는 게 굉장히 많은 문제를 낳고 있어요. 이 문제 제기가 오늘 처음 나온 것도 아니고 여러 각도에서 여러 방면으로 민변이나 이런 단체에서도 계속 제기를 해 왔던 이슈고, 그래서 저는 이제는 한국 사회가 이 문제에 대해서는 어느 정도 매듭을 지어야 될 시점에 왔다……

그런데 다만 복지부에서 이 문제에 대한 해결책을 다 내놓기는 조금 어려운 지점은 저

는 있는 것 같아요. 최근에는 장애인뿐만 아니라 다른 코로나백신 피해자 같은 경우에도 유사한 상황에 놓여 가지고 문제 제기가 돼서 민사소송법 개정안도 올라가 있는 것으로 알고 있는데, 사실 이 이슈가 장애 문제에서 빨리 해결되면 더 좋겠다고 저도 생각을 하지만 그게 어렵다면 지금이라도 민사소송법 개정안 논의를 법무부한테 촉구해 가지고 좀 진행할 수 있도록 국가기관들 내에서 논의를 적극적으로 하셔야 된다고 생각합니다.

그리고 일부패소한 당사자에게 변호사 비용을 전부 부담시키는 게 과연 맞는가, 이 제도 자체에 대한 문제 제기도 사실 있거든요. 소송비용 부담에 변호사 비용까지 포함시킨 게 1990년 민사소송법 개정으로 들어간 내용인데, 원래는 소송비용만 부담시키고 변호사 비용은 각자 부담하는 게 원칙이었는데 이게 1990년인가 민사소송법 개정으로 패소 당사자에게 넘어가면서 그로 인한 사회적 문제들이 많이 발생하고 있단 말이에요. 그래서 저는 이것을 전반적으로 손을 볼 수 있는 논의를 해야 된다는 의견을 꼭 말하고 싶습니다.

이상입니다.

○소위원장 이수진 최보운 위원님.

○최보운 위원 방금 존경하는 김남희 위원님께서도 잘 지적해 주셨듯이 소송비용 청구에서의 문제가 있습니다. 소송비용 청구를 할 때 시기를 뒤늦게 청구하는 경우도 있고요. 또 하다 보면 이자까지 청구를 하거든요. 법정이자 5%까지 해서 청구를 하게 되면 그것을 알고 있지 못하다가 나중에 결국 이 비용까지 부담을 하게 되는 사례들이 종종 발생하고 있습니다. 그런 현실 상황을 알고 계셔야 될 것 같아요.

그리고 방금 차관님께서 다 해야 한다고 말씀을 주셨는데 분명히 법 개정안은 재량입니다. 그래서 그런 부분을 꼭 잊지 말고 생각을 해 주셔야 돼서, 다 해야 한다는 것과 할 수 있다는 것은 굉장히 차이가 있고 저도 그런 부분을 고려해서 법 발의를 했다는 점을 다시 한번 강조드리고요.

그리고 또 법률구조공단 얘기가 아까 나와서 다시 한번 부연 설명을 드리자면 장애인 분들이 소송을 이용할 때 법률구조공단을 이용할 수도 있고 사적인 공익소송을 하는 변호사님들을 이용해서 할 수도 있습니다. 그런데 그걸 선택권으로 볼 수 있는데 장애인의 경우에는 법률구조공단을 이용했을 경우에 지원이 일부 있다는 것입니다.

그래서 많은 경우에 사실 법률구조공단도 열심히 하고 있지만 이런 전문적인 분야의 소송에, 의료소송, 장애인 공익소송 이런 부분에 대해서는 법률구조공단이 그만큼 더 전문적으로 해 주면 좋겠지만 아직 현실은 그렇지 않은 경우들이 많기 때문에 다른 변호사를 이용할 때 이런 부분들이 발생한다는 점을 말씀드립니다.

그리고 김남희 위원님께서도 말씀하셨듯이 다방면에서 다 되면 좋겠지만 적어도 유엔 장애인권리협약이나 장애인권리위원회가 지적한 장애인 소송에서만은 일단 이런 법안을 통해서 지원될 수 있는 것부터 시작으로 해서 여러 방면에서 또 개정이 이루어질 수 있다면 좋을 것 같아서 이런 부분을 다시 한번 말씀을 드리려고요.

그래서 이런 부분들이 오해가 없이 법무부에서도 잘 설명이 되고 복지부에서 의지를 갖고 한번 실현을 해 보시면 법무부에서도 같이 의견이 잘 전달될 수 있고 협업이 될 수도 있다고 생각을 하고요. 만약에 법무부에서 이런 부분에 대해서 얘기를 한다면 저희는 더 강하게 이런 것들을 더 지적하고 얘기할 수 있다고 생각합니다.

그래서 소송구조 제도와 중첩 가능성이 있다라는 부분을 법무부가 얘기했지만 본 위원이 말씀드린 것처럼 중첩이 아니라 오히려 사각지대가 발생하고 있는 부분이 많은데, 이런 것들을 법무부에서 모르고 있다면 복지부에서 오히려 더 정확하게 이런 부분을 지적해서 이런 의견이 나오지 않도록 충분히 설명할 필요가 있다고 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다.

○소위원장 이수진 차관님, 지금 여러 위원님들 말씀을 들어 보니 입법 취지에 대해서는 다 공감을 하세요. 그렇지요?

○보건복지부제1차관 이스란 예.

○소위원장 이수진 차관님도 공감하시지요?

○보건복지부제1차관 이스란 예, 그렇습니다, 위원장님.

○소위원장 이수진 그리고 지금 보면은 ‘해야 한다’가 아니라 ‘지원할 수 있다’라고 하고 또 대통령령으로 위임 조항이 있잖아요. 그래서 아까 범위가 너무 넓어진단든지 이러한 것은 대통령령에 공익소송이나 여러 가지 재정적 어려움이 있는 거라든지 또 다른 조건이나 아니면 또 그렇게 만들어서, 그래서 이게 예산상의 문제도 있고 또 법무부와 의 논의도 있기는 하겠으나 이것을 바로 시행하라는 그런 의미가 아니잖아요.

그렇다라면 시범사업이라도 어느 정도 내년 예산을 잡아 가지고 이러이러한 케이스들은 지원을 한다든지 그런 것들이라도, 저는 좀 길인 것 같아요. 할 수 있는 발걸음인 것 같아요.

그래서 이 법 정도면 그렇게 어렵지는 않지 않나요, 이 정도 수준이면?

○보건복지부제1차관 이스란 위원장님, 이것은 아까 존경하는 김미애 위원님 말씀 주셨는데 이 법률 포괄적 위임 부분에 대해서는 구체화가 사실 좀 필요하고요. 그다음에 이 걸 가지고 저희가 법무부랑 한번 더 논의를 할 수 있는 시간을 주시면 좋겠습니다. 그다음에 한번 결론을 내려 주시면 감사하겠습니다.

제가 이 법안의 취지를 절대적으로 공감을 합니다만 말씀드린 대로 이게 상임위 이후에 법사위도 가야 되고 계속 법안 절차들이 있는데 아무 협의 없이 하는 것은 결과적으로 다시 법사위에 걸릴 우려도 있고 한번 상의를 하는 시간을 주시면 감사하겠습니다.

○김미애 위원 제가 봐도 이게 또 일각에서는 소송구조, 법률구조가 너무 많다 이런 비판의 지점도 있기는 하거든요. 그런데 그것을 또 필요한 곳에는 꼭 해야 되는데 그런 부분을 놓치고 있단 말이에요.

그래서 이런 부분을 법무부와 잘 협의해서 범위를 법에 최소한 포괄위임이 아니라 어느 정도 구체화시켜 가지고 하면 장애인 당사자들 스스로도 어느 범위에서는 해야지 할 수도 있기 때문에 그런 걸 논의를 해서 가능하도록 그렇게 해 주시면 안 되겠습니까?

○보건복지부제1차관 이스란 저희가 미리 법무부하고 말씀드리지, 얘기하지 못한 점 송구하게 생각하고요.

바로 이야기해서 최소한 법무부가 이런 내용들을 인식은 하고 있어서 이런 일은 나중에 다른 큰 문제를 제기하지 않도록 그렇게 하겠습니다.

○김남희 위원 법무부랑 논의할 때 저나 최보운 위원이랑 같이 논의를 하는 테이블을 한번 만들어 주시면 좋을 것 같습니다.

○보건복지부제1차관 이스란 그래 주시면 위원님, 더 감사하겠습니다.

○**김남희 위원** 왜냐하면 이게 하루이틀 된 논의가 아니라 되게 많은 논의가 기존에도 있었고 국회에서도 진행이 많이 됐었던 내용들이라 그것을 가지고 논의해야 될 것 같아요.

○**보건복지부제1차관 이스란** 저희가 사회적 약자를 담당하고 다른 부처에 맨날 이렇게 부탁하는 처지여서요 위원님들께서 힘을 좀 모아 주시면 감사하겠습니다.

○**소위원장 이수진** 그래요.

그러면 이것은 여야가 크게 이견이 있는 것이 아니니까 방금 말씀하신 대로 지금 통과시키지 못하는 아쉬움이 있겠지만 법사위에서 잡히면 오히려 더 오랫동안 진행이 안 되니까 법무부와 위원님들과 논의해서 될 수 있는 방향, 방법을 찾아서 다음번에 다시 논의하시는 것으로 그렇게 정리하겠습니다.

의사일정 제8항은 보다 깊이 있는 검토를 위해 계속 심사하기로 하겠습니다.

의사일정 제9항 노인복지법 일부개정법률안을 심사하겠습니다.

전문위원 보고해 주시기 바랍니다.

○**전문위원 정경운** 예, 보고드리겠습니다.

자료 3쪽입니다.

안상훈 의원안입니다.

개정안은 노인학대 예방 및 신고의무 교육 대상을 노인학대 신고의무자가 소속된 모든 기관·시설로 확대하려는 것입니다.

현행법상 노인학대 예방 및 신고의무 교육 대상 기관은 노인학대 신고의무자 중에서 노인복지시설, 요양병원 및 종합병원, 장기요양기관에 한정되어 있습니다.

검토의견입니다.

매년 증가하고 있는 노인학대 예방에 도움이 될 것으로 보입니다.

노인학대 예방 및 신고의무 교육 대상을 현행과 같이 노인복지시설 등에 한정할 필요성은 적은 것으로 보았습니다.

관련 입법례로 아동복지법과 장애인복지법에서도 신고의무자가 소속된 모든 기관에서 신고의무에 관한 교육을 실시하도록 하고 있습니다.

수정의견입니다.

개정안이 수용되는 경우 노인학대 예방 및 신고의무 교육 대상이 대폭 확대되는 만큼 신규 제도 수용성 강화를 위해 시행일을 공포 후 6개월에서 1년으로 수정하였습니다.

이상입니다.

○**소위원장 이수진** 정부 측 의견 들겠습니다.

○**보건복지부제1차관 이스란** 발의하신 안상훈 의원님께 감사드리고요, 수정의견에 동의합니다.

○**소위원장 이수진** 질의하실 위원님 있으십니까?

없으시지요?

의사일정 제9항은 노인복지법 일부개정법률안을 모두 심사한 후 의결하도록 하겠습니다.

의사결정 제10항 노인복지법 일부개정법률안을 심사하겠습니다.

전문위원 보고해 주시기 바랍니다.

○전문위원 정경윤 보고드리겠습니다.

자료 3쪽입니다.

김남희 의원안입니다.

개정안은 노인여가복지시설의 기능에 급식 제공을 추가하면서 양곡구입비, 부식구입비 등의 보조 대상을 현행 경로당에서 노인여가복지시설로 확대하려는 것입니다.

아래 표를 보시면 노인여가복지시설은 노인복지관, 경로당, 노인교실 이렇게 3곳이 되겠습니다.

검토의견입니다.

개정안은 노인계층의 결식 예방 및 복지 증진에 기여하려는 것으로 현실적으로도 노인여가복지시설 중에서 공간이 협소한 노인교실을 제외한 대부분의 노인복지관과 경로당에서 급식 또는 식사를 제공하고 있는 상황이기도 합니다.

다만 경로식당 무료급식 등은 2005년 지방이양된 사업으로 보조금 지급 제외 사업으로 지정되어 있어 관련 부처의 협의도 필요해 보입니다.

자료 4쪽과 5쪽에 관련 부처 등 의견이 첨부되어 있습니다.

5쪽에 대구시 동구와 경기도 양주시 의견을 보시면 장소 협소 등의 이유로 식품위생법상의 집단급식소 기준 충족에 어려움 등이 있을 수 있다는 의견이 제시되었습니다.

여기까지 보고드리겠습니다.

○소위원장 이수진 정부 측 의견을 들겠습니다.

○보건복지부제1차관 이슬란 전문위원 검토보고대로 현재 노인복지관과 경로당에서는 식사 지원을 하고 있는데 이게 지방이양사업으로 되어 있고 노인교실은 또 장소가 협소한 점 감안해서 정부는 신중한 입장 견지하고 있습니다.

○소위원장 이수진 질의하실 위원님 있으신가요?

김남희 위원님.

○김남희 위원 사실 제가 계속 경로당 식사 문제에 대해서 챙기고 있는데요.

사실 이 법을 내게 된 취지는 경로당도 경로당이지만 노인복지관에서 식사를 상당히 많이 하세요. 지역에서 보시면 아시겠지만, 이유가 경로당은 얘기하신 대로 조금 공간이 협소하고 또 한정된 인원들이 있다 보니까 많은 분들이 경로당 내에서 서로 갈등이 생기거나 이러면 안 가는 경우들도 있고 이런 경우들이 있는데 어쨌든 노인복지관은 상당히 큰 규모로 급식을 제공하다 보니까 지역사회에서 더 많은 인원들이 편하게 이용을 하고 점점 활성화가 되고 있는 상황인데, 문제는 이게 지방이양사업으로 되어 있다 보니까 지방 간의 격차가 너무 심한 거예요.

지역별로 지원하는 금액이나 이런 것들이 너무 달라 가지고 점점 이용하시는 분들이 많은데 제가 가면 너무 안타까운 게 뭐냐 하면 복지관 식당에 가면 식권이 하루에 딱 몇 백 장 이렇게 한정이 되어 있어서 어르신들이 ‘기다렸는데 못 받았어요’하고 돌아가시는 거예요.

그래 가지고 지원이 너무 부족하다 보니까 사실은 노인인구가 늘어나고 노인식사 문제도 워낙 중요해지면서 경로식당을 이용하시는 분들은 앞으로 점점 늘어난 것 같은데 워낙 지역별 편차가 심하고 어려움이 있다 보니 실질적으로 필요해도 가서 기다려도 식사를 못 하고 돌아가시는 일들이 막 생긴다. 그래서 현장에서는 어떻게든 지원을 받을

수 있는 방법이 없냐라는 이런 안타까운 사연들을 저한테 복지관협회 이런 쪽에서 전달을 해 주셔서 제가 계속 문제 제기를 하게 됐고요.

그래서 사실은 부처에서는 이게 지방이양사업이고 하니까 쉽지 않다라는 입장을 가지고 계신 것 이해를 못할 바는 아닌데 이 문제에 대해서 조금 더 국가적인 차원의 관심과 지원이 필요한 것은 맞다.

그러면 앞으로 이 문제를 어떻게 좀 더 적극적으로 해결해 나갈 수 있을 것인가에 대한 고민들을 같이 해 주시면 좋겠다는 생각에서 또 법 개정안을 내게 됐고요.

복지부의 입장을 좀 부탁드립니다.

○**보건복지부제1차관 이스란** 위원님, 저희 지금 경로당 부식비도 해결을 못 해 가지고요. 일단 지금 예결위에 말씀을 드리기는 했는데, 그러니까 필요성을 저희가 인지를 못하는 건 아닙니다. 그런데 재정의 한계도 있고 그다음에 어느 것을 우선순위로 할 건지 이런 고민도 있는 것 같아요.

그래서 이것은 좀, 지난번에 제가 어디 위원회에서 말씀을 드리기는 했는데 지방이양사업에 대해서 전체적으로 한번 저희가 돌아볼 필요가 있다고 생각해서요 간단한 연구를 하려고 합니다. 원칙이 뭐고 어떤 게 문제가 있는 건지, 특히 갔다가 돌아오는 사업도 있고 해서요.

이것은 두 가지 방향으로…… 우선은 위원님, 경로당 부식비 먼저 우리가 해결을 하고요. 그다음에 지방이양 전체에 대해서 지방 간 격차가 크게 벌어지는 분야에 대해서는 어떤 걸 우선순위로 국고 지원을 이야기를 할 건지 또 지방이양을 해도 지역 간 격차 없이 진행되는 건 이양을 하고 이런 원칙을 마련하는 과정으로, 이렇게 두 가지 방향으로 업무를 진행해 봤으면 합니다.

○**김남희 위원** 그러면 혹시 경로식당의 현황이나 지역별 편차에 대해서 복지부가 현황 파악을 하거나 이런 것들을 좀……

○**보건복지부제1차관 이스란** 기본 통계는 갖고 있는데요. 정확한, 이게 얼마나 편차가 있느냐. 그러니까 사실 위원님 말씀 주신 건 되게 디테일한 걸 요구하는 거거든요.

그런데 그것은 저희가 보지는 못한 것 같은데, 혹시 국장님 있으시면……

○**보건복지부노인정책관 임을기** 지금 저희가 노인복지관 같은 경우에는 455개인데 그중에 경로식당을 운영하고 있는 기관이 89% 정도 됩니다. 그중에서도 무료로 운영하는 기관이 84개로 34% 정도 되고 유료로 같이 하고 있는 기관이 대다수입니다. 66.6%고요. 금액은 3000원에서 4000원 정도로 하고 평균적으로 3800원 정도의 급식, 식당 식비를 받고 저희가 운영을 하고 있는 걸로 알고 있습니다.

그리고 이와 관련해서 지방에서 이러한 경로식당과 관련되는 냉난방비나 그다음에 부식비 이런 비용을 지원하고 있습니다.

○**김미애 위원** 제가 좀 현장에…… 우리 지역에 복지관만 10개거든요, 노인복지 분관까지 해서. 어쨌든 복지관은 그 안에 경로당이 있는 곳도 또 있어요, 복지관 안에. 그리고 복지관에는 다양한 단체들이 점심을 무료로 제공하는 봉사활동을 또 하러 많이 와요, 여러 복지관에. 그래서 조금 사정이 다른 측면이 있고.

경로당은 경로당마다 다 다른데 어쨌거나 밥을 해 먹을 수 있는 시설은 있어요. 그런데 복지관도 대부분은 시설이 있어요, 취식할 수 있도록. 다만 여기 보니까 노인교실은

그것부터 확인이 돼야 될 것 같아요. 취식할 수 있는 설비 자체가 안 돼 있을 때가 아마 많을 거기 때문에 이것을 먼저 좀 파악하셔야 될 것 같고.

지난번에 우리가 경로당 할 때도 그때 기재위 공무원까지 불러 가지고 보조금법 시행령 빨리 개정하라고 요구하고, 제 기억으로는 그때 10월 말까지 하겠다고, 그때 안 하면 나는 이 법 통과시키겠다라고 엄포를 놓듯이 해 가지고 그때 지난 정부 때 보조금법 시행령 개정에서 경로당은 풀렸거든요. 그런데 이것도 한다면 노인교실까지는 아직 좀 그러니까 노인복지관을 하는데 이미 또 무료로 하고 있는 곳들도 있는데 이게 과연 어떻게 고민은 됩니까.

그래서 그런 부분에 대해서 현황 파악을 먼저 해 보셔야 될 것 같습니다.

○**보건복지부노인정책관 임을기** 노인교실도 지금 말씀하신 대로, 원래 노인교실은 프로그램을 진행하는 곳이라서 식당이 없는 공간이, 한 80% 정도가 식당을 둘 수가 없는 공간입니다. 그래서 그런 애로사항이 있습니다.

○**김미애 위원** 그러니까 노인교실은 좀 빠더라도 노인복지관이라도 현황 파악을 해야 될 것 같습니다. 지금 아마 상당수 복지관들이 중식을 제공하거든요. 그 현황을 좀 파악할.....

○**소위원장 이수진** 방금 김남희 위원님이 말씀하셨듯이 노인복지관 저도 봤는데 식권이 다 나가서, 그날 소진분이 있잖아요. 그러니까 이게 지자체 사업이다 보니까 금액을 좀 낮춰 주거나 아니면 냉난방비 지원, 이 정도는 관심이 있는데 그 식수를 늘리는 거에 지자체가 그렇게 관심 있는 것 같진 않아요. 그리고 주로 복지관이 지하철역 주변이나 교통이 편리한 데 또 노인 인구가 좀 많은 데, 그런 데에 있는 노인복지관은 식수가 부족한 것 같아요. 그래서 지금 실태조사가 필요하지 않냐 하는데 이것도 어려운 건 아닌 것 같아요. 노인복지관 거기에 공문을 내려서 하루 식권 나가고 나서 몇 분이나 더 이렇게 못 드시는지, 그거 다 알거든요. 그것 조사하면 그분들이 다 알고 계세요. 그래서 주로 복지관에 계시는 선생님들이 이런 문제가 있어요라고 얘기하는 거기 때문에 저희 위원들이 그 상황들을 파악하고 있는 거라서, 그런 것들을 파악을 해서 그 실태조사를 기반으로 지자체에다가도 조금 더 권고를 하고 그런 방법들이 저는 필요하다는 생각이 들어요.

그런데 최종적으로는 지자체도 여력이 없다 보니까 이게 보조금사업으로 묶여져 있는 부분들에 대한, 최종적인 이런 노력들을 다 해 보시고 그런 노력을 추가로 더 복지부가 의무를 가져야 되지 않나 저도 그런 생각을 합니다.

이주영 위원님.

○**이주영 위원** 저도 이 개정안에 매우 동의를 하고 필요한 어르신들 많다는 것에도 공감합니다. 그런데 논의가 이미 나왔으니 제가 좀 부탁일 수도 있고 같이 좀 검토해 주십사 하는 부분은 보호필요아동복지시설도 지금 다 여기서 제외가 돼 있거든요. 개정에 대한 논의도 아직 시작이 안 된 걸로 알고 있는데, 지금 경로당 같은 경우에는 특별히 제한 없이 이용하실 수 있는 시설이고 지역에 계신 어르신들이 아무튼 활용도라든가 이런 걸 조금 높으시면 더 많은 어르신들이 혜택을 받으실 수 있을 것 같기는 합니다. 그래서 만약에 여기에 대한 게 논의가 되고 있으면 같은 취지로 이것을, 보호필요아동복지시설 같은 것도 결국은 확장이 돼야 될 수밖에 없지 않을까요? 그러면 전체를 해야

되는 그런 예산들이나 아니면 정책의 우선순위나 이런 게 있어야 될 것 같은데 그거를 조금 숙고를 해서 결정을 하시는 게 좋지 않을까 하는 생각도 들고. 나중에 이런 부분도 같이 좀 챙겨 주셨으면 좋겠다 하는 말씀을 좀 드리고 싶습니다.

○**보건복지부제1차관 이스란** 위원님, 아까 말씀드린 대로 저희가 전체적으로 한번 들여다보고 어떤 걸 우선순위로 할지 그거를 좀 고민을 하겠습니다. 얼마나 저희가 원하는 만큼의 내용이 나올지는 잘 모르겠습니다만 일단 한번 들여다본다는 자체에 의미를 부여하고요.

위원장님 말씀 주신 실태조사는 저희가 노인복지관협회랑 같이 하든지 해서 한번 보고요. 그다음에 말씀드린 대로 우선순위는 좀 있어야 될 것 같습니다. 그거 정해 가지고 그 이후에 이 법안은 조금 더 심도 있게 논의해 주시면 감사하겠습니다.

○**소위원장 이수진** 김남희 위원님, 다음에 다시 논의할까요?

○**김남희 위원** 예, 계속 상정해서……

○**소위원장 이수진** 의사일정 제10항은 보다 깊이 있는 검토를 위해 계속 심사하기로 하겠습니다.

그러면 의결하겠습니다.

의사일정 제9항 노인복지법 일부개정법률안은 수정안을 채택하여 수정한 부분은 수정한대로, 기타 부분은 원안대로 의결하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

어쨌든 차관님.

○**보건복지부제1차관 이스란** 예, 위원장님.

○**소위원장 이수진** 노인복지법 일부개정법률안 김남희 의원 법안도 실태조사도 계획을 해서 위원들께 알려 주시고.

○**보건복지부제1차관 이스란** 예.

○**소위원장 이수진** 그런데 이거를 다, 보조금법을 다 손대면 쉽지 않잖아요. 그런데 우리가 잘 알지만 경로당에 방문하시는 어르신과 복지관에 가서 식사하시는 어르신은 약간 차이가 있어요. 복지관에 오시는 분들이 소득 수준이 낮거나 아니면 다양한 분들이 오시는데 경로당에 가지 못하시는 분들이 실제로 거길 가시는 건 맞더라고요. 그래서 조금 취약 어르신들이 많이 오시는 곳인 만큼 우선적으로 좀 빠르게 어떻게 대책을 만들 수 있을지 좀 찾아 주세요.

○**보건복지부제1차관 이스란** 연구비 찾아 가지고요 계획 짜는 대로 보고드리겠습니다.

○**소위원장 이수진** 의사일정 제11항부터 제12항까지 국민연금법 일부개정법률안을 심사하겠습니다.

수석전문위원 보고해 주시기 바랍니다.

○**수석전문위원 이지민** 현행법에서는 노령연금 수급개시연령에 도달한 수급권자가 그때부터 5년간 소득이 있는 업무에 종사하면서 사업소득 또는 근로소득을 얻은 경우 초과소득월액 구간별로 노령연금액의 일부를 감액·지급하는 소득활동 연계 노령연금 감액제도를 규정하고 있습니다.

2쪽입니다.

각 개정안은 소득활동 연계 노령연금 감액제도를 완화하거나 폐지하려는 것인데 부모와 자녀를 동시 부양하여야 하는 경제적 부담 등으로 인하여 다수의 60대가 소득활동에 종사하고 있다는 점, 사업소득·근로소득이 A값을 초과하는 경우에만 노령연금액이 감액되고 있어 이자소득·배당소득 등 다른 종류의 종합소득과의 형평 문제가 제기될 소지가 있다는 점 등을 종합적으로 고려할 때 타당한 측면이 있는 것으로 보입니다.

4쪽입니다.

다만 소득활동 연계 노령연금 감액제도는 소득이 있는 업무에 종사하는 모든 노령연금 수급권자를 대상으로 하는 것이 아니라 소득월액이 A값을 초과하는 수급권자에 대해서만 적용되는 것이므로 동 제도의 완화 또는 폐지는 주로 고소득자의 수혜 증대로 이어질 소지가 있다는 지적이 제기되는 점을 고려할 필요가 있습니다. 아울러 동 제도의 폐지 또는 완화에 따라 증대되는 국민연금기금의 재정부담 규모도 고려할 필요가 있는 것으로 보입니다.

5쪽 하단입니다.

또한 공무원연금·군인연금 등 각 직역연금에서도 수급권자의 사업소득·근로소득이 일정 기준을 초과할 때 급여액 일부의 지급을 정지하고 있는 점, 소득활동 연계 노령연금 감액제도가 근로 의향에 미치는 효과가 작거나 통계적으로 유의미하지 않다는 연구 결과가 제시된 점 등도 종합적으로 고려될 필요가 있는 것으로 보입니다.

6쪽입니다.

각 개정안들은 초과소득월액 구간별 폐지 여부와 부양가족 연금액·적용률·시행일 등에 관하여 서로 다르게 규정하고 있으므로 각 사항에 대해 구체적으로 논의할 필요가 있습니다.

김선민 의원안은 1~5구간 전부를 폐지하려는 것인 반면 박희승 의원안은 1구간만 폐지하려는 것이므로 5개 구간 중 어느 구간까지에 대해서 동 제도를 폐지할 것인지 논의가 필요합니다.

7쪽입니다.

부양가족연금액 지급 여부입니다.

박희승 의원안은 초과소득월액이 100만 원 이상인 2~5구간의 노령연금 수급권자에 대하여는 감액 제도는 유지하더라도 부양가족연금액은 지급받을 수 있게 하려는 취지인 것으로 보입니다. 현행법에 따르면 사업·근로소득월액이 A값을 초과하여 노령연금액 일부가 감액되는 경우에는 부양가족연금액이 지급되지 않고 있습니다.

수급권자의 소득월액이 A값을 초과하거나 수급권자의 배우자·자녀·부모가 국민연금·직역연금의 수급권자인 경우 등에는 부양가족연금액 지급을 제한하는 현행법의 취지를 고려할 필요가 있는 것으로 보입니다.

8쪽입니다.

시행일입니다.

소득활동에 따른 노령연금금액의 감액 기준 등이 변경될 경우 연금공단의 시스템 개편이 병행될 필요가 있다는 정부 의견을 고려하여 시행일을 조정할 필요가 있습니다.

다음, 적용례입니다.

김선민 의원안은 이 법 시행 이후 지급하는 노령연금 급여분부터 개정규정을 적용하되

종전규정에 따라 노령연금액 일부가 감액되고 있는 수급권자에 대하여도 개정규정이 적용되도록 하는 적용례를 규정하고 있습니다. 그런데 노령연금액 감액분은 종합소득과세표준 확정신고 결과에 따라 최종 정산되고 있으므로 실무에서는 소득발생 시점과 감액지급 시점이 서로 일치하지 않고 있는 상황입니다.

노령연금 급여분을 기준으로 개정규정의 적용례를 정하게 되면 이 법 시행 이후의 노령연금 급여분을 전년도 소득에 따라 감액하여 지급하는 사후 정산이 제한될 수 있고 이 경우 본인의 소득월액을 미리 성실 신고하여 이미 일부 감액된 노령연금액을 지급받고 있던 수급권자와 같은 기간에 소득이 있는 업무에 종사하면서도 자신의 소득월액을 신고하지 아니한 수급권자 간의 형평 문제가 제기될 수 있으므로 노령연금 감액의 원인이 되는 소득이 발생한 시점에 따라 개정규정의 적용 여부를 결정할 필요가 있는 것으로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 이수진 정부 측 의견 들겠습니다.

○보건복지부제1차관 이스란 저희 수석전문위원의 검토보고에 비춰 보면 고소득자에 대한 과도한 보호 문제 제기가 있어서요. 저희 정부는……

○소위원장 이수진 잠시만요. 정부에서 준비한 자료 배포해 주세요.

○보건복지부제1차관 이스란 정부가 준비한 대안은 1·2구간을 폐지하는 건데요. 자료를 설명드리겠습니다.

○소위원장 이수진 계속……

○보건복지부제1차관 이스란 정부가 제시하는 수정의견안입니다.

노령연금 감액 구간은 5개 구간이 있습니다만 저희는 초과소득월액이 200만 원 이상인 경우, 그러니까 1구간·2구간만 폐지하는 걸로 제안드립니다. 시행 시기는 전산시스템 등등 고려해서 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행했으면 하는 바람이고요. 아까 적용례 말씀 주셨는데 2025년 1월 1일 이후 발생한 소득, 다시 말씀드리면 2025년 귀속분 소득부터 적용하는 걸로 제안드립니다.

하단에 신·구 조문대비표가 있습니다.

보시면 현행의 1구간은 100만 원 미만인 사람, 이 부분을 삭제하고 다음 쪽입니다. 100만 원 이상, 200만 원 구간도 삭제를 하고 3구간 이상부터는 현행 규정대로 감액을 유지하는 걸로 마련했습니다. 부칙에는 아까 말씀드린 시행일과 적용례 규정하고 있습니다.

이상입니다.

○소위원장 이수진 질의하실 위원님 있으신가요?

지금 전체 5구간 중에서 박희승 의원님은 1구간인데 정부 수정안은 1·2구간, 200만 원 미만은 제외하고.

○보건복지부제1차관 이스란 그렇습니다. 상대적으로 소득 구간이 낮은 구간만 폐지하는 걸로 제안드립니다.

○소위원장 이수진 이주영 위원님.

○이주영 위원 저는 기본적으로 정부안에 동의합니다. 그런데 궁금해서 여쭙보는 건데 김선민 의원님 안이 전체 폐지인 걸로 알고 있는데 2구간일 수도 3구간일 수도 있는데 2구간으로 설정하게 된 정부 측의 근거가 궁금하고 혹시 이걸 앞으로 확대하실 계획도 있

으신지 여쭙습니다.

○**보건복지부제1차관 이스란** 저희는 이게 필요하다고 판단하는데요. 아까 수석전문위원 말씀 주신 대로 소득이 많은 사람도 감액을 안 하는 건 문제가 있지 않냐라는 지적이 있어서, 1·2구간으로 정한 이유는 평균 감액 금액이 1구간은 한 2만 원, 2구간은 9만 3000 원, 10만 원 안쪽인데요. 이 부분에 적용받는 사람을 다 합산하면 60%가 넘습니다. 그러니까 다시 말씀드리면 돈을 많이 못 버는데 조금 깎이는 사람들이 또 아까 소득발생 시점과 감액 시점이 다르다 보니 한참 지난 후에 연금 깎였어요 이렇게 하니까 국민연금에 대한 신뢰 문제도 좀 있었고요. 또 말씀하신 대로 이거는 사업소득만 들어 있는데 요즘은 배당·이자소득도 많은데 어떤 경우에는 우회할 가능성이 많은 거지요. 나에게 근로소득을 주지 말고 배당으로 주세요. 그러면 또 이 부분은 해당이 안 되고. 이런 형평 때문에 소득 구간으로 가급적 적게 활동하시는데, 금액도 되게 작는데 비중이 높은 1·2구간만 우선하는 걸로 제안드린 겁니다.

○**소위원장 이수진** 제가 이게 궁금해서 금액이 얼마나 되는지 계산을 한번 해 봤어요. 예를 들어서 기준 소득이 300만 원일 경우에, 만약에 월소득 350 그러면 기준 소득을 300을 빼면 초과 소득이 50만 원이잖아요. 그러면 이 초과 소득의 5%더라고요. 그러면 그동안 월 2만 5000원 차감을 했던 건데, 애네들 1구간에 해당되겠지요. 그거를 차감을 안 하겠다는 거잖아요.

○**보건복지부제1차관 이스란** 예, 그렇습니다.

○**소위원장 이수진** 1구간에 해당되는 숫자는 몇 명이지요?

○**보건복지부제1차관 이스란** 저희 전체 감액 대상자가 15만 명인데요. 1구간이 6만 7000명입니다.

○**소위원장 이수진** 6만 7000명?

○**보건복지부제1차관 이스란** 예. 44% 가까이 차지합니다.

○**소위원장 이수진** 그러면 6만 7000명, 15만 명 중에 6만 7000명이면 나머지 8만 3000명이 2구간인가요?

○**보건복지부제1차관 이스란** 2구간은 3만 명 정도 됩니다.

○**소위원장 이수진** 2구간은 3만 명 정도 돼요? 거의 반 미만으로 떨어지네요.

○**보건복지부제1차관 이스란** 예. 그래서 60%가, 1·2구간에 65% 가까이가 포함되어 있는데, 감액 금액은 굉장히 작습니다.

○**김미애 위원** 금액은 16.4%.

○**소위원장 이수진** 한지아 위원님.

○**한지아 위원** 노령연금 수급자 소득구간별 노령연금 감액 현황을 보면 말씀하신 대로 65% 이상이 감액 폭이 크지 않은 1·2구간에 집중되어 있긴 합니다. 실질적으로는 김선민 의원안처럼 아예 노령연금 감액제도 폐지가 사실 맞다고 생각하는데 우선적으로 1·2구간 폐지에 대해서 동의하는 부분을 기록에 남기겠습니다.

○**김미애 위원** 그런데 국민연금을 가입하는 목적은 다 똑같은 텐데 이후에도, 소득에 따라서 이렇게 차등이 있잖아요. 그런데 노인빈곤률이 높기 때문에 1·2구간을 폐지하고 또 연금기금의 지속가능성 때문에 1·2구간을 우선 폐지하는 것은 어쩔 수 없는 측면이 있다고 봅니다.

그렇다 하더라도 그 이상에도 감액분을 좀 낮춰 주는 이런 노력은 안 합니까, 3구간부터라도?

○**보건복지부제1차관 이스란** 위원님 그 지적도 타당합니다만 우선은 1·2구간 폐지를 해 보고 저희가 상황을 좀 봤으면 좋겠습니다. 이게 반대하는 분들도 꽤 많으시거든요. 그래서 우선 저소득이다, 소득이 낮다 그다음에 되게 조금 깎으면서 불만 제기하는, 국민연금 제도에 대한 신뢰 문제가 있다, 다른 소득과 형평 이렇게 저희가 논리를 만들어서 우선 이렇게 해 보고요.

위원님 말씀 주신 부분은 저희가 한번 일이 년간 시행을 해 보고 더 확대가 필요한지 그다음에 65세 이상 노인들의 경제활동이 더 늘어나는지 이런 것들을 보고 판단할 수 있으면 하는 바람입니다.

○**소위원장 이수진** 한지아 위원님.

○**한지아 위원** 그러니까 우리가 일하면 손해 보는 구조라는 부정적인 인식이 있으면 안 되기 때문에 이 부분은 전향적으로 1·2구간 폐지로 시작은 하지만 확대돼야 될 거라는 의견을 꼭 드리고 싶습니다. 고령층이 일하는 환경을 우리가 제도적으로 뒷받침하는 부분도 필요할 수 있지 않을까라는 의견 드립니다.

○**보건복지부제1차관 이스란** 전적으로 동의합니다, 위원님.

○**김미애 위원** 이 불합리함이 있는 것은 아시지요?

○**보건복지부제1차관 이스란** 예, 압니다, 위원님.

○**김미애 위원** 그러니까 이 불합리함을 개선해야 되는데 완전 폐지는 아니더라도 감액 비율이라도 좀 낮춰 가는 그런 노력을 병행해야지 방금 한지아 위원님 말씀하신 것처럼 더 열심히 살고자 하는 사람은 더 열심히 살아서 또 다른 방식으로 사회 기부도 하고 하거든요. 그렇게 자발적으로 할 수 있는 길을 열어 놔야지 똑같은 환경에서—뭐 다르겠지만—연금 가입을 해서 기대를 하고 있는데 그것을 감액하면 저는 자꾸만 우리 사회가 불필요한 갈등을 야기할 수 있다고 생각합니다. 그래서 감액 비율이라도 낮추는 노력을 정부가 진심으로 하길 바랍니다.

○**보건복지부제1차관 이스란** 예, 위원님 그렇게 하겠습니다.

○**소위원장 이수진** 위원님들께서는 여러 가지 의견을 주셨습니다. 앞으로 점점 감액하는 부분들을 개선해라 그다음에 다만 시작이니까 1·2구간으로 시작을 해 보라, 그래서 이 정도로 정리하는 것으로 하고.

다만 이게 국민연금만 있는 게 아니라 공무원연금, 사학연금, 군인연금, 기타 다른 연금들이 있는데 거기에는 일정 소득 이상 되면 연금이 안 나오지요. 그래서 결국은 다 영향을 미치기 때문에 이걸 여기만 과도하게 확대하게 되면 그쪽도 아마 변화를 요구하게 될 거예요. 그렇기 때문에 우리가 일단 1·2구간 보면서 정부에서, 저는 여러 가지 의견들이 앞으로 많이 들어올 것 같아요. 그 부분에 대한 대책도 세우셔야 될 겁니다.

○**보건복지부제1차관 이스란** 예, 위원장님.

○**소위원장 이수진** 그것은 복지부가 세울 대책은 아니지만.

○**보건복지부제1차관 이스란** 예, 유념하겠습니다.

○**소위원장 이수진** 의사일정 제11항 및 제12항은 국민연금법 일부개정법률안을 모두 심사한 후 의결하도록 하겠습니다.

의사일정 제13항 국민연금법 일부개정법률안을 심사하겠습니다.

수석전문위원 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 이지민 개정안은 26년 1월 1일 시행 예정인 민법 일부개정법률 제1004조의2에 따라 가정법원의 선고로 상속권이 상실된 피상속인의 직계존속인 유족에 대하여는 3항에 따라 발생하는 유족연금 등의 수급권을 제한하려는 것입니다.

2쪽입니다.

개정안은 국민의 보편적 정서에 부합하는 방향으로 상속제도를 개편한 민법 제1004조의2 신설 취지와 다른 직역연금에서의 유사 입법례 등을 고려할 때 타당한 것으로 보입니다.

다만 공무원연금법 등에서는 각 법률에 따라 설치되어 있는 행정기관 소속 위원회가 양육책임 미이행 유족에 대한 퇴직유족급여 등의 지급 제한을 심의할 수 있는 반면 국민연금의 경우에는 급여의 적정성 등을 심의할 행정기관 소속 위원회가 현행법에 설치되어 있지 아니하므로 민법 제1004조의2에 따라 상속권 상실 선고가 확정된 유족에 대하여 유족연금 등의 수급권을 제한하려는 개정안은 그 수급권의 제한 절차·대상·급여액이 공무원연금 등과 서로 다른 점이 있다는 점을 고려해서 심사할 필요가 있는 것으로 보입니다.

4쪽입니다.

개정안은 법원의 상속권 상실 선고가 확정된 경우 유족연금 등을 제한하는 것이므로 법적 안정성이 제고될 수 있으나 항소·상고 등으로 행정기관 소속 위원회의 결정보다 속행되지 못하게 되면 부양의무 위반 유족에 대한 유족연금 등의 지급 제한이라는 법적 정의 구현이 지연될 수 있다는 점 등을 고려할 필요가 있습니다.

그리고 개정안은 민법 제1004조의2에서 상속권 상실 선고를 할 수 있는 대상으로 피상속인의 직계존속을 규정하고 있어서 조부모의 유족연금 등 수급권이 제한될 여지가 있으나 공무원연금 등에서는 부모로 제한하고 있습니다.

5쪽입니다.

개정안은 유족연금 등의 전액을 지급하지 아니하도록 규정한 반면 공무원연금 등에서는 수급권의 전부 또는 일부를 제한할 수 있도록 규정하고 있습니다.

안 부칙에는 시행일에 관한 사항 외에 적용례가 규정되어 있지 않습니다. 그런데 어느 시점 이후의 유족연금 등 급여분부터 개정규정에 따라 지급을 제한할 것인지를 명확히 하기 위하여 적용례를 규정할 필요가 있는 것으로 보입니다.

또한 개정안은 법원의 상속권 상실 선고가 확정되기까지 이미 지급된 유족연금 등의 환수에 관하여는 규정하고 있지 않은데 선고가 확정되기까지 이미 지급된 유족연금 등을 환수할지 여부와 환수할 경우 이자를 가산할 것인지 등을 입법정책적으로 결정하고 그 결정에 맞추어 현행법 제57조를 함께 개정할 필요가 있는 것으로 보입니다. 참고로 공무원연금 등에서는 이미 지급된 급여분을 환수하고 있습니다.

이상입니다.

○소위원장 이수진 정부 측 의견 들겠습니다.

○보건복지부제1차관 이스란 정부는 수석전문위원의 수정의견에 동의합니다.

○소위원장 이수진 위원님들 의견 주세요.

김미애 위원님.

○**김미애 위원** 제가 대표발의했는데 입법 취지는 전부 다 공감하는 면이고 수석전문위원님 수정의견이 타당하다고 생각합니다.

○**소위원장 이수진** 다른 위원님들 의견 있으십니까?

수석전문위원이 얘기한, 어느 시점의 유족연금 등 급여분부터 개정규정에 따라 지급 제한할 것인가 그다음에 지급된 유족연금 환수 등에서는 규정을 어떻게 할 것인가 혹시 정부 측 대안이 있습니까?

○**보건복지부제1차관 이스란** 아닙니다. 수정의견 주신 대로 개정규정은 이 법 시행 후 최초 도래하는 것부터 하는 것으로 정하면 될 것 같고요. 환수 범위도 정확하게 57조 4호에 규정을 해 주셔서 이렇게 진행하면 될 것 같습니다.

○**소위원장 이수진** 그러면 더 이상 위원님들 의견이 없으시……

○**김미애 위원** 잠깐만, 여기서 가는 의문이 이런 경우에 유족연금이 일시금으로도 지급이 됐던가요?

○**보건복지부제1차관 이스란** 예, 그런 경우 있습니다, 위원님.

○**김미애 위원** 그러면 이런 게 문제될 때 지급을 중단할 수 있는 방법은 없잖아요.

○**보건복지부제1차관 이스란** 예, 대부분 사후에 저희가……

○**김미애 위원** 그리고 이것을 관심 있어서 누가 챙길 것도 아니고. 그러면 일시금으로 지급…… 사망 시점에 바로 상속이 되니까 행정적으로 절차가 다 끝나 버리면 이게 있느냐 마나 할 것 같은데.

○**보건복지부제1차관 이스란** 위원님, 그래서 이 법안이 되면 저희가 법원행정처하고 이야기를 해서 이런 판결을 받은 사람들의 자료를 구하는, 그러니까 정보를 입수하는 경로를 좀 해야 될 것 같고요. 대부분 미리 하기는 어렵고……

○**김미애 위원** 그러면 반환 청구를 해야 되는데……

○**보건복지부제1차관 이스란** 그런 상황이 될 수 있습니다.

○**김미애 위원** 그게 문제겠네.

○**보건복지부제1차관 이스란** 예.

그런데 한 가지 말씀을 드리면 보통 유족연금은 배우자들이 많이 가져갑니다. 내년 1월 1일부터 시행하는 것은 부모의 친권 제한이 있기 때문에, 부모님이 받는 경우는 전체 유족연금의 한 3~4%밖에 되지 않아서 그 사례가 많지 않습니다만 어쨌든 본인의 부양 의무를 다하지 않은 사람한테 유족연금을 주는 것은 맞지 않기 때문에 이 부분은 제도적인 보완이 필요한 것이 사실입니다.

○**소위원장 이수진** 그러면 더 이상 위원님들 의견이 없으신 관계로 의사일정 제11항부터 제13항까지 이상 3건의 국민연금법 일부개정법률안은 이를 통합 조정하고 위원님들과 전문위원의 의견을 반영하여 위원회 대안으로 채택하며 본회의에 부의하지 않는 것으로 의결하고자 합니다. 이의 있으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

이상으로 보건복지부 1차관 소관 법률안에 대한 심사를 마치도록 하겠습니다.

이스란 1차관님 수고하셨습니다.

○보건복지부제1차관 이스란 예, 감사합니다.

○소위원장 이수진 지금부터 보건복지부 2차관 소관 법률안을 심사하도록 하겠습니다.
이형훈 2차관님 수고해 주시기 바랍니다.

○보건복지부제2차관 이형훈 예, 참석했습니다.

○소위원장 이수진 의사일정 제14항부터 제16항까지 국민건강보험법 일부개정법률안을 심사하겠습니다.

수석전문위원보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 이지민 3건의 개정안은 수가체계와 관련된 것인데 임종득 의원안은 지역별 수가 관련된 것이고 한지아·김선민 의원안은 대안적 지불제도 또는 공공정책수가와 관련된 내용입니다.

먼저 임종득 의원안 보고드리면, 현행법 제47조의3은 금전적 인센티브를 제공함으로써 지역별 의료자원 배분의 불균형을 해소하고자 지역별로 요양급여비용을 달리 산정할 수 있도록 규정하고 있고 이에 따라 지역별 요양급여비용은 의료취약지, 중소도시, 비수도권 등을 대상으로 입원료, 분만 등에 대한 가산이 이루어지고 있습니다.

2쪽입니다.

임종득 의원안은 이와 관련하여 지역별 요양급여비용 산정의 대상 지역과 가산율의 범위를 법률에 명시함으로써 예측 가능성을 높이고 국민의 생명과 건강에 직결된 진료과목을 운영하는 의료기관의 경우 더 높은 가산율을 적용하여 지역필수의료의 격차 해소를 도모하려는 것으로 그 취지는 긍정적인 것으로 보입니다. 다만 현행 수가제도에 미치는 영향 등을 고려하여 대상 지역 및 가산율 범위의 적정성 등이 신중하게 검토될 필요가 있는 것으로 보입니다.

다음, 대안적 지불제도 또는 공공정책수가 관련입니다.

현행 요양급여비용 결정체계(행위별 수가체계)와 관련하여 양 중심의 수가체계하에서는 고위험·고난도에 대한 보상을 반영하는 체계가 미흡하여 의료기관으로 하여금 진료량에 치중한 의료공급을 유도하여 의료전달체계의 왜곡 현상을 초래하고 필수의료 기피 현상을 야기하는 측면이 있다는 지적이 있습니다.

4쪽입니다.

개정안들은 현행 행위별 수가체계를 보완하기 위하여 행위별 수가를 가산하거나 의료기관의 성과, 협력 네트워크, 대기시간, 필수의료 인프라 유지를 위한 손실에 대한 의료기관 단위 보상 등을 위하여 의료기관에 대하여 추가적인 비용 등을 지원할 수 있도록 하는 내용을 법률에 규정하려는 것으로 현행 수가체계로 인한 필수의료 기피 현상, 상급종합병원 쏠림 현상 등을 해소하려는 취지로 보입니다.

다만 다음과 같은 점을 검토할 필요가 있습니다.

먼저 김선민 의원안 제47조의3제2항은 요양급여비용을 달리 정하여 지급할 수 있다고 규정하고 있는데 필수의료의 기반 유지 등은 현재 이 법에 따른 요양급여가 아니라는 점에서 그에 대하여 요양급여비용을 지급하는 것이 적절하지 않고, 한지아 의원안 제47조의5제1항은 공공정책목적의 급여를 요양기관별로 지급할 수 있다고 규정하고 있는데 요양기관 등이 지급받는 것은 급여비용이므로 양 개정안과 같이 요양기관 또는 의료기관에 대하여 필수의료의 기반 유지 등에 대하여 급여비용을 지급하고자 하는 경우 이들을 보

협급여화한 이후에 그에 대하여 급여비용을 지급하도록 규정할 필요가 있는 것으로 보입니다.

또한 건강보험 재정에 대한 영향 등을 종합적으로 고려하여 이와 같은 정책적 목적을 위한 지원의 방식 및 그에 따른 재원에 대하여 논의가 필요할 것으로 보입니다.

참고로 복지부에 따르면 현재 실시 중인 행위별 수가 가산 및 시범사업에 따라 2026년도에 4조 7385억 원이 소요될 것으로 추계된다고 합니다.

한편 요양급여 외에 요양기관이 실시하고 급여비용을 지급받는 새로운 급여를 신설하게 될 경우 그 급여기준 및 급여비용에 관한 사항을 건정심에서 심의하도록 하고 요양급여와 같이 의료법 등을 위반한 경우 급여비용 지급을 보류할 필요가 있는 것으로 보이며 이러한 급여를 받는 가입자 등이 요양급여와 같이 비용을 일부 부담하도록 할 것인지 등 현행법 전반에 대한 추가 검토가 필요할 것으로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 이수진 정부 측 의견 들겠습니다.

○보건복지부제2차관 이형훈 정부 측 의견 드리겠습니다.

세 법안에 대한 정부 측 의견은 수정 수용입니다. 필수의료법과 별도로 규정이 필요한 데 이는 행위별 수가 외에 대안적 지불제도와 같은 다양한 보상 방식의 근거가 필요하기 때문입니다. 또한 공공정책목적의 급여의 방법 등 기준은 하위법령으로 위임하는 것이 타당합니다.

따라서 공공정책급여 신설에 따라 건강보험법 내 타 조항의 개정·준용 필요성 등에 대한 세부 검토가 더 필요한 상황입니다.

○소위원장 이수진 질의하실 위원님들 계신가요?

없으시면 제가……

저희가 필수의료 강화 지원법도 지금 법사위에 가 있잖아요?

○보건복지부제2차관 이형훈 예.

○소위원장 이수진 거기서 필수의료 특별회계도 지금 준비 중이시고.

그래서 결국 이 재원이라는 게 공공급여, 그러니까 공공수가, 지금 보니까 액수가 상당한데 재원을 어디서 마련할 것인지 이런 고민들도 담아서 정부가 준비를 해야 되는 거잖아요?

○보건복지부제2차관 이형훈 예.

○소위원장 이수진 어떻게 지금 계획을 하실 건가요?

○보건복지부제2차관 이형훈 건강보험정책국장이 답변드리도록 하겠습니다.

○소위원장 이수진 예.

○보건복지부건강보험정책국장 이종규 건강보험정책국장입니다.

현재 지금 재원은, 현재 저희 생각으로는 이 개념이 기존의 행위별 수가의 개념이 아니고 기관 단위 보상이나 아니면 네트워크에 대한 보상이기는 하지만 그것이 인건비 보상이 아니라면 저희 생각에는 건강보험에서도 충분히 가능하다고 판단하고 있는 게 저희 실무자의 입장입니다.

그런데 다만 기존의 통상적인 의료서비스의 반대급부로 하는 서비스가 아니기 때문에 이것이 예산사업으로 하는 것이 타당하지 않냐라는 의견이 제시될 수는 있는데요. 현재

저희 담당자 입장에서는 건강보험 재원으로 추진하는 것이 맞다고 판단하고 있습니다.

다만 아까 여기, 수석님 법률 검토에 따라서도 보면 실제 다른 법률과의 조항, 준용이나 이런 부분들에서 세부 검토가 필요한 상황이라 저희가 조금 이것은…… 방향성은 동의하지만 법률적인 정합성 측면에서 조금 더 검토가 필요하다는 것을 저희도 동의하고 있습니다.

○소위원장 이수진 예.

혹시 여기 임종득 의원안에 보면 입원료, 이 입원료를 이게 등급이 있잖아요? 4등급·5등급. 이게 간호사 인력 대비 해서 등급 나눠 놓는 거지요?

○보건복지부건강보험정책국장 이종규 예, 맞습니다.

○소위원장 이수진 그런데 5등급·6등급은, 간호사 인원이 사실 법적인 범위 밖이잖아요?

○보건복지부건강보험정책국장 이종규 그렇습니다.

○소위원장 이수진 그런데 거기에 가산을 더 해 주라는 그런 내용이지요?

○보건복지부건강보험정책국장 이종규 예, 취지는 그렇게 되어 있고 그다음에 법률안에 되게 구체적으로 안을 주셨습니다. 그 취지는 맞습니다, 위원님.

○소위원장 이수진 그러니까 그러면 안 된다는 제 얘기에요.

○보건복지부건강보험정책국장 이종규 아, 예.

○소위원장 이수진 이게 법을 넘어서는 가산을 해 주라는 건데 방금 말씀하신 것처럼 건강보험에서 인건비에 대한 지원을 못 하는 문제 때문에 이러시는 것 같은데 그래도 이것을 이렇게 하면 안 되는 거잖아요? 우리가 기준이라는 게 있는 건데, 간호사 인력에 따라서 입원료 관련해서 등급을 나눠 놓은 건데 이 등급을 그 기준, 복지부에서 건정심을 통해서 정해 놓은 기준을 넘어서서 더 지급하는 것은 문제가 될 것 같아요. 이것은 들어가면 안 될 것 같은데요, 이런 내용은?

○보건복지부건강보험정책국장 이종규 건강보험국장입니다.

지금 말씀해 주셨던 것처럼 너무 구체적인 안들은 정합성이나 이런 부분들에 따라서 저희도 여기 법률에 넣는 것은 일단 걱정하지 않다고 판단하고 있고 위원장님 말씀해 주신 것처럼 현행 관련된 부분은 나중에 하위법령에 내리더라도 그 부분은 맞춰서 다시 검토하도록 하겠습니다. 위원장님 말씀해 주신 것 고려해서 검토하겠습니다.

○소위원장 이수진 예.

혹시 또 질문?

한지아 위원님.

○한지아 위원 사실상 저는 건강보험으로 하는 게 맞다고 생각을 합니다. 이게 말씀하신 정부의 취지대로 동의를 하고요. 그리고 건정심에서 심의하도록 하는 부분도 추가가 필요할 거라는 것에 동의를 합니다.

다만 준용 부분에 있어서 그런 부분들 다시 또 고려를 해야 된다 그러면 오늘 소위에서 통과가 불가능한 상황이라는 의견이신 것 같은데 어떤 부분들을 말씀하시는 건지 좀 구체적으로 말씀을 해 주세요.

그리고 한 가지 더, 사실상 지금까지 거의 지불은 행위에 따라서만 된 부분이 많습니다. 그런데 그 기관이 공공 역할을 했을 때 기관 전체가 서비스를 제공하는 데서 손해를

보는 경우가 많았거든요. 이런 부분에 대해서 건강보험을 통해서 보상해야 되는 것은 맞다는 의견을 기록에 남기고 싶습니다.

준용 부분에 대해서만 설명 좀 부탁드립니다.

○**보건복지부건강보험정책국장 이종규** 건강보험국장이 설명드리겠습니다.

지금 현재 건강보험에서는 요양급여라고 하는 것들이, 예를 들면 의료서비스에 대한 것이 법에 정의가 돼 있습니다. 간호·입원·처치가 이렇게 돼 있는데 현재 지금 저희가 다시 정의를 하면, 위원님마다 약간씩 용어 차이는 있지만 저희가 예를 들면 공공급여 이렇게 정의를 바꾸면 기존의 요양급여에 대한 비용이 수가라고 하는 것이 정해지고요. 그 수가를 어떤 원칙에 따라서 정하는 그런 원칙이 지금 현재 건보법에 있는데 저희 조항에는 그러면 공공급여라는 것을 정의하고 공공급여 비용이라고 하는 것들을 어떻게 산정할 것이냐에 대한 그런 것들을 기존의 것을 따르는 것이 맞는지, 왜냐하면 기존 것은 행위별 수가의 관점으로 수가를 산정하다 보니까 여기는 기관 단위 보상이나 성과 보상이나 이런 관점으로, 측정하는 방식이 좀 달라서 이것을 그대로 준용해도 될지 이런 부분들에 대한 검토가 조금 추가적으로 시간이 필요하다는 의견들이 있었고 저희도 그것은 같이 동의를 하는 측면이 있어서요. 그런 측면의 검토가 필요했고.

저희 담당 과장이 추가 설명을 한번 더 하겠습니다.

○**소위원장 이수진** 예.

○**보건복지부건강보험지불혁신추진단장 공인식** 건강보험지불혁신추진단 공인식입니다.

수석전문위원님께서 말씀 주신 것처럼 공공정책급여라는 것이 행위별의 서비스 항목을 중심으로 비용을 산정하고 그것에 대해서 지급하는 경우에 본인부담을 실제로 이 급여에 대해서는 어떻게 부담시킬 수 있는지에 대한 부분 그리고 요양급여 비용 이외에 이의신청이라든지, 비용에 대한 허위 부당청구에 대한 이의신청이나 본인부담에 대한 이의신청 그리고 건강보험공단과 심평원이 기존의 요양급여 비용과 관련된 업무 이외에 공공정책 급여에 대한 업무가 추가되는 부분, 이런 관련 조항들이 현재 국민건강보험법은 행위별 수가의 요양급여 그리고 그것에 대한 비용을 중심으로 되어 있다 보니까 관련 규정들을 저희가 같이 추가로 규정하거나 그리고 준용해야 하는 그 조항들을 적시해야 되는 부분들을 살펴볼 필요가 있습니다.

이상입니다.

○**소위원장 이수진** 질문 더 있으세요?

○**한지아 위원** 예.

그러니까 그런 구체화에 대한 부분을, 그러면 준용 부분에 대해서 구체적으로 다시 설명을 해 주시기를 부탁드립니다.

이 취지나 방향성에 있어서 우리가 너무 시간을 끌면 안 된다고 생각합니다. 이것은 당연히 진행이 돼야 되는 부분이고 지금 많은 공공병원들이 특히나 이런 공공정책수가가 없기 때문에 여러 가지 불편함을 호소하고 그렇다고 지자체들이 그런 의료원에 무한대로 정책 보전을 할 수가 없는 상황이기 때문에 그런 준용 부분에 대해서 이제, 그 이야기는 일리가 있어서 받아들이기는 하지만 다음번에는 통과될 수 있도록 정부에서는 이 부분을 시급히 생각해 주시고 진행을 했으면 좋겠습니다.

○**소위원장 이수진** 차관님.

○보건복지부제2차관 이형훈 위원님, 알겠습니다.

한지아 의원님, 김선민 의원님, 임종득 의원님의 세 법안이, 발의안이 있습니다. 주요 내용을 잘 통합 조정하고 해서 정부대안을 마련하도록 하겠습니다. 공공정책급여 그리고 그 비용의 산정, 지급 방법, 절차와 범위 등의 세부 기준 등을 마련하는 것들이 필요합니다. 그래서 정부대안을 마련해서 다음 심의에, 심의가 될 수 있도록 그렇게 준비하겠다는 말씀 드립니다.

○소위원장 이수진 차관님, 잘 아시겠지만 지방의료원·공공병원들이 겪는 어려움 너무나 잘 아시지요?

○보건복지부제2차관 이형훈 예.

○소위원장 이수진 그래서 이런 수가가 또 따로이 필요하지 않냐 이런 요구는 굉장히 오래전부터 있었고 정부의 대책 마련이 필요하고, 그런 영역도 있고.

또 하나 예를 들면, 응급실 뺑뺑이 문제와 관련해서도 공공병원이 아니더라도 응급환자들을 위해서 미리 대비해 놓는 중환자 병상이라든지 수술방이라든지 병실들이 있어요. 왜냐하면 배후진료 중의 하나기 때문에 의사 외에도 이런 것들이 준비돼 있지 않으면 환자를 못 받는 경우가 있잖아요.

그래서 응급·중증환자들 같은 경우도, 제가 보면 병원장의 철학에 따라서 이것을 하는 병원이 있고 이것을 운영 안 하는 병원이 있어요.

○보건복지부제2차관 이형훈 예.

○소위원장 이수진 그래서 이런 제도를 어떻게 보면 사실 공공정책수가처럼 녹여 준다면 일정 부분, 하루 병실을 비워 놓음으로 인해서 얻는, 손해 보는 그런 영역 때문에 실제로는 운영을 잘 못하는 병원들도 상당하거든요. 결국은 경영자한테 책임을 묻거나, 그 부서, 과에다가 책임을 묻거나 수입을 못 내면 이런 문제들이 있어요.

그래서 그런 것들도 사실 통합적으로 한번 고민해 보셔야 될 문제인 것 같아요. 그래야지 응급실이 언제 올지 모르는 환자들을 위해서 배후진료 강화하는 데 도움이 되지 않을까 싶어요.

○보건복지부제2차관 이형훈 예.

○소위원장 이수진 김미애 위원님.

○김미애 위원 제가 말씀을 안 드리려고 하다가……

어제 부산에서 한 고등학교 3학년이 아침에 6시 17분에 출근하는 선생님께 발견돼 가지고 119 신고하고 119가 33분에 도착했는데 그 당시의 상황이 다른 외상은…… 제가 기사로만 보면 그리고 확인해 본 바로 외상이 안 보이고 그런데 몸 경련을 하고 있었기 때문에, 그 상황에서 119구급대는 경련이라는 사실을 알고 있고 그것으로 병원을 이송해 가야 되는데 병원을 물색했는데 거절을 했다는 건데 그 거절의 이유는 배후진료가 어렵다는 거고.

그리고 저는 의아한 게 부산에는, 양산부산대병원이 소아 권역센터 아닙니까?

○보건복지부제2차관 이형훈 예.

○김미애 위원 그런데 왜 그랬을까 몹시 안타깝고, 궁금해서 보니까 이 상황이 의사가, 전문의가 24시간 상시 있는 게 아니잖아요, 어느 병원이든? 대한민국 지금 어느 병원이든 그게 불가능하잖아. 게다가 또 소아신경과 하면 더 힘든 상황이고. 그래서 내가 다른

대학병원에도 오늘 선생님과 통화도 해 봤는데 보는 병원도 없다고 해요, 소아신경과 선생님들이. 상당수가 없거든요.

그런데 국민들은 이런 기사를 보면 전부 다…… 누군가를 비판을 잘하잖아요? 어떻게 뽕뽕이…… 뽕뽕이라고만 하면 안 되고 그게 뽕뽕이 하고 싶어서가 아니라 모든 병원이 가도 이것은 응급한 상황이고, 그러니까 8시쯤 돼서 심정지 상태가 된 거겠지요?

○보건복지부제2차관 이형훈 예.

○김미애 위원 여러 가지 문제를, 제가 어제에도 지역의사제 법안을 심사했지만 이렇게 해서 해결이 될까 너무 고민인 거예요. 오늘도 나중에 지역의대 법도 있던데 과연 이렇게 하면 의사들이…… 그 병원에 근무하게 해 줘야 될 거 아니에요. 그리고 왜 안 할까. 안 하는 것들에 대한 이유는 알고 있잖아요. 그래서 이런 부분을 저는 정부가 계속 이 부분에 있어서 이재명 정부는 앞으로 어떤 계획을 가지고 있냐 그 계획에 맞는 로드맵을 우리가 하나하나 정해가야 된다.

이 법도 안 해 주면 마치 큰일 날 것 같이 모든 것을 다 그렇게 얘기하지만 그것 없어서 안 된 게 아니라는 거 알잖아요. 그래서 이런 부분도 마찬가지로 고민이 필요해요. 각 병원의 현장의 목소리도 좀 들어야 되고 저는 법 하나 통과되고 말고 이런 것보다 근본적으로 그걸 풀어 나갈 해법이 참 안 보이는 것 같아요.

그래서 내가 오늘도 마구 비판하는 분에게 그러면 우리가 서울의 빅5 병원에서도 간호사가 쓰러졌을 때도 치료 안 된 그건 무엇으로 설명할 거냐 제가 이렇게 얘기를 하기도 했었는데, 근본적으로 왜 그러면 그런 필수의료진이 없을까부터 고민해서 그에 대한 해법을 가지고 입법도 해야지 다 이렇게 분절적으로 이 법 만들고 저 법 만들고 하면 만능일 것처럼 하는 게 그렇게 해서 저는 해결 안 될 것 같아요. 그러니까 뭐라도 해 보자 심정으로 하기는 하는데 그러니까 해서 이런 게 해결될까요? 소아과만 해도 너무나 세분화되어 있는데 선생님들 거의 안 계실 걸요, 대학병원에? 여기 의사 출신 두 분이 계시지만……

그래서 이런 부분에 있어서 정말 심사숙고해서 책임 있는 안을 좀 가지고 임해 주시기 바랍니다. 하나하나 법 통과, 이것 이것 갖고 저는 만능이 아니고 진심으로 책임 있는 걸 가지고 할 때 여기에서 당을 가리지 않고 그런 걸 반대할 위원님들 안 계시거든요. 그래서 다시 한번 그 부분을 좀 진심으로 고민하고 대책을 마련해 주시기를 바랍니다.

○보건복지부제2차관 이형훈 예, 위원님.

○소위원장 이수진 마지막으로 이주영 위원님.

○이주영 위원 제가 정부안을 가지고 오시겠다고 하셔서 지금 정부에서 굉장히 열심히 노력하시는 부분이 있는 걸 알고 있기 때문에 웬만하면 그 방향에 맞게 거기서 현실적으로 할 수 있는 방향에 대해서 고민을 하려고 노력을 많이 하고 있습니다.

그런데 지금 존경하는 김미애 위원님이 말씀을 주셔서 제가 여기에 대해서는 보건복지부에 전달드리고 싶은 내용이 있어서 말씀을 드리는데요. 방금 나온 그 경련하는 고등학생 사건의 경우에는 아주 전형적으로 제대로 된 병원 전 단계의 처치 그리고 정확한 환자 보고와 인계가 안 되었기 때문에 발생한 아주 대표적인 사건일 겁니다.

이 고등학생은 그냥 경련을 한 것이 아니라 추락한 것으로 결국 확인이 되었거든요. 만약에 만 18세인데 추락으로 인해서 경련을 하고 있다고 했으면 오히려 신경외과만 있

어도 되는 상황이었을 겁니다. 그런데 경련하는 18세다라고만 초기에 그걸 119에서 병원 쪽에 노티를 했기 때문에 그렇게 되면 병원 입장에서 소아신경과부터 소아신경외과까지 다 있지 않으면 그 이후 처치가 안 되고 골든타임은 6시간도 채 안 되고 이미 발견 당시에 시간이 늦었기 때문에 당연히 모든 게 준비되어 있지 않으면 현재의 이러한 사법적인 리스크가 있는 상황에서는 받기가 당연히 불가능합니다. 그리고 이송을 의뢰하는 과정에서 문제가 있었던 것으로 저희가 파악을 하고 있는데요.

이런 부분에 대해서 이송이라든가 공공정책이라든가 이런 것들이 굉장히 현장에서는 적용이 아예 불가능한 것들이 많은데 공공정책수가나 이런 취지에 대해서 저는 모두 동의하는 입장입니다만 어제 지역 의사제 같은 경우도 그렇고 또 지금 공공의대에 대한 것도 이 다음에 바로 논의가 될 것 같고 또 의료원 운영에 대한 것도 아직 정리가 안 된 상태에서 공공정책수가라는 것이 법안으로 먼저 나가기 시작하면 그 이후에 공공의대가 만약에 생기게 되면 공공의대 부속병원이 생겨야 될 거거든요.

그래서 일본 같은 경우에도 자치의대가 있으면 자치의대 부속병원이 있지 않습니까? 일본의 경우에는 공립민영대학으로 운영되고 있기는 한데 지금 우리나라에서의 논의는 그것을 공공이 책임지는 것처럼 지금 진행 중인 것으로 보이는데 그렇다면 공공의대 부속병원과 공공의료원과 보건소와 그리고 지역이나 취약지에 있는 일반병원들에 주는 공공정책수와 이런 것들을 결과적으로는 형평성을 맞춰서 동시에 가야 하는 부분이 분명히 있거든요.

그래서 지금 정부안을 다시 주신다고 하시니 그런 것들을 포괄적으로, 통합적으로 그래서 나중에 너무 두더기처럼 수정하지 않아도 되는, 어쩌면 이 범위를 줄여야 될 수도 있습니다. 그런 부분에 대해서 통합적으로 다른 곳에도 적용할 수 있는 법안으로 만들어 주시면 감사하겠습니다.

○**김미애 위원** 제가 하나만, 여기 남기 때문에 오해가 있을 것 같아서……

어제 그 사건은 왜 제가 제대로 사실관계 파악이 안 되기 때문에 조심스럽다고 했냐면 발견한 선생님도 그 상태만 본 거예요, 경위를 모르고. 그리고 119 신고할 때도 그 현상에 대해서만 말씀드렸기 때문에 그것 가지고 한 것 같아요. 그래서 제가 자칫 잘못하면 우리가 누구를 항상 비난·비판하기 십상인데 이런 부분을 다 모른 채 함부로 얘기하면 곤란하고 그래서 제가 그 전제에서 또 전달은 그렇게 전달이 다 됐을 거 아니에요, 병원에도. 그러니까 이런 문제가 있었던 것 같다.

제가 이걸 문제 삼으려고 하는 게 아니라 이런 상황에서도 이송체계나 의료전달체계나 이런 게 지금 안 갖춰져 있거든요. 그 근본적인 이유에 대해서 파악을 하고 그걸 해소하기 위한 해법을 찾아가는 게 우리의 길인데 지금 정부가 그걸 가지고 좀 제대로 로드맵을 정해서 하나하나 입법을, 정책을 펼쳐 나가기를 바란다는 취지입니다.

○**소위원장 이수진** 다 이해할 것 같습니다.

○**김미애 위원** 다 이해하셨지요?

○**소위원장 이수진** 한지아 위원님.

○**한지아 위원** 혹시 지금 응급실에 도착하기 전의, 이제는 그 전 단계에 관련된 정책적인 보완은 필요합니다. 그런데 이것은 그 나머지를 하는 것은 당연한 거고 하지만 말씀했듯이 필수의료, 취약지에서 그 노력을 하려고 하는 기관들에 대해서 추가적인 보상체

계를, 지금까지는 거의 주가 말씀하시는 행위별 수가였기 때문에 그것의 추가적인 어떤 보상을 해 줘야 되는 것은 우리 국가 차원에서 건강권 보장에 있어서 굉장히 중요합니다.

그러니까 공공의대 설립, 의료원 이런 것들을 새로 만든다 이런 것들은 부담스러울 수 있지만 일단 있는 곳은 잘 작동할 수 있게끔 해야 되지 않겠습니까? 앞으로 생겨나는 곳에 대해서는 그쪽이 잘 활성화될 수 있도록 하는 것이 사실 의료가 그 지역에서 작동하지 않으면 이걸 대한민국의 그 지방뿐만 아니라 전체의 지속가능성과도 연결돼 있다고 생각하기 때문에 당연히 배후진료에 대한 인센티브도 주고 119 관련해서 교육이나 이런 것들도 당연히 보완해야 되고 이런 것도 있지만 제가 발의한 법 관련해서는 정말 이재명 정부에서는 실제로 공공의료 그리고 지역医료를 살리겠다는 의지가 있다면 반드시 이 법안은 준용돼야 되는 부분을 세분화해서 진행돼야 된다는 것을 꼭 기록에 남기고 싶습니다.

○소위원장 이수진 한지아 위원님 굉장히 중요한 말씀 주셨습니다.

자료 19페이지에 보면 공공정책 수가 개요가 있습니다. 위원님들 한번 보시면서 다음에 대안을 갖고 왔을 때 또 자세하게 질문 주시면 좋을 것 같습니다.

그리고 20페이지 상급종합병원 구조전환 지원사업도 정부가 계속하고 있는 거니까 방금 나왔던 문제들 해소를 위해서 잘 추진해 주시기 바랍니다.

의사일정 제14항부터 제16항까지는 보다 깊이 있는 검토를 위해 계속 심사하기로 하겠습니다.

효율적인 심사를 위하여 잠시 정회하다였다가 2시에 속개하도록 하겠습니다.

정회를 선포합니다.

(12시04분 회의중지)

(14시07분 계속개의)

○소위원장 이수진 좌석을 정돈해 주시기 바랍니다.

회의를 속개하겠습니다.

의사일정 제17항 국민건강보험법 일부개정법률안을 심사하겠습니다.

수석전문위원 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 이지민 개정안은 본인부담상한액 초과금액 지급 시 보험료 등 체납액을 공제하려는 것입니다.

4쪽입니다.

개정안은 본인부담상한액 초과금 지급 대상인 당사자가 보험료 또는 그 밖에 이 법에 따른 징수금을 체납한 경우에는 공단이 지급하여야 하는 본인부담상한액 초과금액에서 체납한 금액만큼을 공제하고 지급할 수 있도록 근거를 마련하려는 것으로 건강보험료 성실납부자와의 형평성을 제고하고 체납자의 도덕적 해이를 방지한다는 점에서 긍정적인 것으로 보입니다.

본인부담액상한제는 고액의 진료비로 인한 가계의 경제적 부담을 완화하기 위하여 도입된 제도로 초과금 지급 대상자 중 소득수준이 낮은 1·2구간 가입자의 비중이 높게 나타난다는 점에서 공제하는 것이 적절한지 이점이 제기될 수 있을 것으로 보이지만 본인부담상한액 초과금 지급은 이미 요양급여를 받고 본인부담금을 지불한 이후 사후적으로

환급되는 것으로 본인부담상한액 초과금 공제로 인하여 요양급여에 대한 제한이 이루어지는 것은 아니고 오히려 채납이 지속되는 경우 법 제53조에 따라 요양급여에 대한 제한이 이루어질 수 있다는 점 등을 고려할 때 개정안은 타당한 것으로 보입니다.

다만 복지부 및 건보공단은 채납금 공제를 위한 전산시스템 구축을 위하여 6개월의 준비기간이 필요하다는 입장으로 이를 고려해 시행일을 조정할 필요가 있는 것으로 보입니다.

또한 안 부칙 제2조 적용례에서는 2025년 1월 1일 이후 보험료 또는 그 밖에 이 법에 따른 징수금을 채납한 경우부터 적용한다고 규정하고 있는데 복지부와 공단은 25년 이전에 채납된 보험료 등도 공제 적용대상으로 포함시킬 필요가 있다는 의견을 제시하고 있습니다.

11쪽입니다.

수정의견은 시행일을 공포 후 6개월이 경과한 날로 수정하는 것이고 12쪽의 적용례는 적용대상을 명확하게 하기 위해서 이 법 시행 이후 초과금액을 통보하는 경우부터 적용하는 것으로 하였습니다. 이렇게 하는 경우 공제 대상이 25년 1월 1일 이후 채납된 경우로 한정되지 아니하고 채납이 지속되고 있는 경우에 대해서도 공제할 수 있을 것으로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 이수진 정부 측 의견 들겠습니다.

○보건복지부제2차관 이형훈 해당 법안에 대한 정부 입장은 수용입니다.

공제는 채권과 채무를 상호 가감하는 방식으로 채납금의 효과적인 환수가 가능해지고 이에 따른 건강보험 재정건전성 확보가 기대됩니다. 수석위원님 보고하신 것처럼 부칙 수정은 필요하다고 봅니다. 시행일을 공포 후 6개월로 변경하고 적용대상을 명확히 하는 부칙 수정안에 대해 동의합니다.

○소위원장 이수진 위원님들 질의하시겠습니까?

서미화 위원님.

○서미화 위원 제가 지난 국감에서도 지적을 했던 본인부담상한제 고액 장기채납 제한 환급금 지급에 대한 개정안인데요. 건보료를 안 내고 환급금만 받아가는 도덕적 해이도 막고 성실납부자와의 형평성을 맞추고자 하는 입법 의도에 따라서 본 법안이 개정되면 채납자에게는 동의 여부와 무관하게 먼저 채납액부터 상계하고 환급금이 지급되도록 하는 업무 프로세스가 바뀔 거라고 기대하고요. 저도 정부 측에서 제안한 부칙 수정도 동의합니다.

이상입니다.

○소위원장 이수진 더 질문하실 위원님들이 안 계시므로 그러면 의결하겠습니다.

의사일정 제17항 국민건강보험법 일부개정법률안은 수정안을 채택하여 수정한 부분은 수정한 대로, 기타 부분은 원안대로 의결하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

의사일정 제18항 정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률 일부개정 법률안을 심사하겠습니다.

전문위원 보고해 주시기 바랍니다.

○전문위원 오세일 자료 2쪽입니다.

1번, 보호의무자 폐지 등입니다.

개정안은 보호의무자와 보호의무자의 의무 조항을 삭제하고 민법에 따른 후견인 또는 부양의무자를 후견인등으로 약칭하여 후견인등의 현행법의 보호의무자를 대체하려는 것입니다.

개정안은 보호의무자의 개념을 삭제하면서 보호의무자가 될 수 없는 결격사유도 삭제를 하고 있는데 후견인은 민법 제937조의 결격사유가 있기는 하나 현행 정신건강증진법 제39조의 결격사유와는 차이가 있고 부양의무자의 결격사유에 대해서는 별도의 규정이 없어 입법적 미비로 보입니다. 따라서 보호의무자의 의무 조항은 삭제하지 않고 후견인등의 의무사항으로 수정하여 존치할 필요가 있다고 보았습니다.

자료 12쪽입니다.

동의입원등과 보호입원등 폐지 및 행정입원등으로의 변경입니다.

현행법상 입원등은 자의입원등, 동의입원등, 보호입원등, 행정입원, 4종류로 나뉘는데 개정안은 이 중에서 동의입원등 제도와 보호입원등 제도를 폐지하고 행정입원등으로 편입시키려는 것입니다.

개정안에 따르면 행정입원의 주요 절차가 변경되는데 아래쪽 표를 보시면 신청권자로 후견인등 또는 정신질환자와 생계를 같이하고 있는 사람을 신설하고 진단입원의 사유로 정신질환자가 정신의료기관등에서 입원치료 또는 요양을 받을 만한 정도 또는 성질의 정신질환을 겪고 있는 경우를 신설하였습니다. 그리고 진단입원 정신의료기관으로 현행법에서는 지정정신의료기관이라는 제도를 두고 있으나 개정안에서는 국·공립 정신의료기관으로 대체하고 있습니다.

자료 13쪽입니다.

개정안에 대해서는 다음과 같은 사항을 고려할 필요가 있습니다.

2021년부터 2024년까지 동의입원과 보호입원에 따른 입원자 수는 연평균 2만 6000명~2만 8000명 정도인데 이들이 행정입원으로 편입될 때 국·공립 정신의료기관이 감당할 수 있는 상황인지 파악이 필요한 것으로 보입니다.

자료 14쪽입니다.

국가 또는 지방자치단체는 행정입원등에 따른 진단과 치료에 드는 비용의 전부 또는 일부를 부담할 수 있는데 이러한 비용이 폭증할 것으로 예상되고 폭증할 행정입원등의 신청 수요를 감안할 때 국·공립 정신의료기관만으로는 지정정신의료기관 제도를 대체하기 힘들 것이므로 지정정신의료기관 제도 폐지 여부에 대해서는 신중한 검토가 필요하다고 보입니다.

국·공립 정신의료기관에서의 진단 이후에 치료를 위해서 입원할 정신의료기관으로 환자를 이송하는 경우 이송 및 비용 부담의 주체와 환자의 안전 문제 등에 대해서도 규정이 필요할 것으로 보입니다.

개정안에 대해서는 대한의사협회, 국립정신건강센터, 대한병원협회, 대한정신장애인가족협회, 대한간호협회 등에서 반대 의견을 제시하고 있습니다.

자료 45쪽입니다.

입원적합성심사위원회입니다.

정신의료기관의 장이 입원적합성심사위원회에 신고해야 하는 기간을 단축하고 입원적합성심사위원회 위원으로 동료지원인 등을 신설하며 위원회의 입원 적합 여부 통지기간을 단축하려는 것입니다.

자료 46쪽입니다.

신고기간을 3일에서 24시간으로 단축하는 것과 관련하여 신고가 조속히 이루어지면 위원회의 판단도 신속히 나올 수 있는 장점은 있으나 정신의료기관 등의 장에게 부담이 될 수 있고 진단결과서에는 정신질환자 등의 성명, 주소, 주민등록번호 등을 기재해야 되는데 24시간 이내에 관련 정보를 알아내기 힘든 경우가 있을 수 있을 것 같습니다.

위원회 위원으로 동료지원인 등을 신설하는 것과 관련하여 동료지원인이 되기 위해서는 보건복지부령으로 정하는 동료지원인 양성 과정을 수료하여야 하기 때문에 위원회의 위원으로의 진입을 오히려 까다롭게 하는 측면이 있을 것 같습니다.

자료 47쪽입니다.

입원심사소위원회 위원으로 정신질환자의 가족, 동료지원인을 의무적으로 위촉하는 것과 관련해서는 입원심사소위원회 위원 구성이 5명 이상 15명 이내의 위원으로 구성되는 점을 감안할 때 필수로 포함돼야 되는 위원이 2명이 되면 위원회 위원장의 임명권의 폭을 줄이게 되고 심사를 받는 대상자에 따라서는 비전문가의 심사에 대해서 거부감을 갖는 경우도 있을 수 있다고 보았습니다.

자료 48쪽입니다.

입원 적합 여부 통지기간을 1개월 이내에서 14일 이내로 줄이고 입원적합성 사전조사를 의무화하는 것과 관련해서는 통지기간을 줄이기 위해서는 심사에 소요되는 기간을 단축시켜야 하고, 대면 조사를 의무화하기 위해서는 위원회의 활동과 조직 규모의 강화가 필요할 것으로 보입니다.

자료 55쪽입니다.

정신건강심의위원회 및 정신건강심사위원회입니다.

개정안은 정신건강심의위원회와 정신건강심사위원회의 구성과 심의 및 심사 사항 등을 개정하려는 것입니다.

자료 56쪽입니다.

개정안은 기초정신건강심의위원회를 두지 아니할 수 있는 경우를 삭제하여 모든 시군구에 기초정신건강위원회를 설치하도록 의무화하고 있는데 각 시군구의 현실적 여건과 인력, 예산 운영의 효율성 등을 종합적으로 고려할 필요가 있다고 보았습니다.

심사대상자의 퇴원계획 및 퇴원지원을 기초정신건강심의위원회의 심의 또는 심사 사항으로 신설하는 것과 관련해서는 퇴원 이후까지도 지원을 하겠다는 입법 취지로 보이나 퇴원계획과 퇴원지원의 범위가 모호한 측면이 있다고 보았습니다.

자료 57쪽입니다.

정신질환자의 의사능력이 미흡하다고 판단되는 경우 보호의무자의 청구 또는 동의로 당사자의 청구 또는 동의를 갈음할 수 있도록 한 규정을 삭제하는 것과 관련해서는 정신건강심의위원회로부터 보고를 받은 지자체의 장이 정신질환자를 다른 정신의료기관 등으로 이송을 할 때 해당 정신질환자의 의사능력이 미흡한 경우에는 후견인 등이 그 역할을

대신해야 되는 경우도 있을 수 있음을 고려할 필요가 있다고 보았습니다.

자료 64쪽입니다.

개정안은 시행일을 공포 후 1년이 경과한 날부터 규정하고 있는데 국공립 정신의료기관의 병상 확보와 그 밖의 인프라 구축 등을 고려할 때 충분한 준비기간을 보유할 필요가 있으며, 개정안의 규정은 이 법 시행 이후 입원 등을 하는 정신질환자부터 적용하도록 적용례 규정을 둠으로써 기존의 동의입원 등이나 보호입원 등에 따라 입원이나 입소 중인 사람에 대해서는 적용되지 않음을 명확히 할 필요가 있다고 보았습니다.

이상입니다.

○소위원장 이수진 정부 측 의견 들겠습니다.

○보건복지부제2차관 이형훈 해당 법안에 대한 정부 입장은 신중 검토입니다.

개정안의 취지에 충분히 공감하는 측면이 있고 또 보호입원 과정에서 발생하는 가족 등의 어려움을 알고 있습니다. 정신질환자 보호 및 입원체계를 전면 개편하려면 충분한 사회적 논의와 제도적 준비가 필요합니다.

제3차 정신건강복지계획이 지금 수립되고 있는데 그 과정에서 당사자, 가족 등이 참여하는 추진단 논의와 공청회 등을 통해 개정 방안을 마련하도록 하겠습니다.

○서미화 위원 저요.

○소위원장 이수진 서미화 위원님.

○서미화 위원 정부의 입장도 제가 이해는 하지만 이걸 굉장히 빨리 개정이 돼야 되는 인권적 관점에서 저는 찬성 의견을 드리고 싶고요.

이 개정안의 내용에 보면 보호의무자에 의한 입원 그리고 보호의무자에 의한 동의입원의 폐지를 담고 있는데요.

이 법안을 발의하신 김예지 의원님께서 제가 알기로는 오랜 기간 동안에 지적을 해 오신 걸로 알고 있고 현재 의료계 일각에서는 한국형 사법입원 도입을 주장하기도 합니다. 그렇지만 우리나라의 경우에 판사 1명이 맡는 재판 건수가 다른 나라에 비해서 5배 이상 차이가 난다는 분석도 있고요. 이런 상황에서 사법입원이 도입이 되더라도 형식적인 절차로 남을 수 있는 우려가 크다는 의견들이 많습니다.

그리고 이 법안의 이런 내용의 기본적인 근거가 되는 것은 유엔장애인권리협약 또는 고문방지협약 등 국제인권조약 등에서 수용형 복지시설이나 정신의료기관에서 발생하고 있는 인권침해에 대해서 깊은 우려를 표명해 왔습니다. 이제 당사자의 동의 여부나 지역사회 복귀나 재활 이런 내용들이 최우선적으로 고려돼야 되는 것이 인권적인 삶의 기준이 돼야 된다고 봅니다.

그래서 보호의무자 제도라든가 동의입원 제도를 폐지하는 이 법안이 미루지 않고 조속히 통과되었으면 좋겠고, 결국 이런 법안들이 정신질환자와 정신장애인의 국가책임제로 나아가는 그런 기반이 될 것이라고 봅니다. 그래서 정부 측에서 적극적으로 검토해 주실 것을 당부드리겠습니다.

이상입니다.

○소위원장 이수진 차관님, 혹시 아까 공청회가 필요하다고 그러셨나요?

○보건복지부제2차관 이형훈 예, 지금 제3차 정신건강복지기본계획을 수립하고 있습니다. 그래서 그 과정에서 이렇게 제안하신 내용도 논의하고 공청회 등을 통해서 이번 제

도개선에 대한 방안을 마련해 보고자 하고 있습니다.

○소위원장 이수진 언제쯤 하실 예정이세요?

○보건복지부정신건강정책관 이상원 정신건강정책관 답변드리겠습니다.

공청회는 약 두 차례 정도 예정하고 있고요. 금년 내에 12월 달에 한 번 하고 그다음에 계획을 수립한 다음에 내년 초 2월 정도에 계획안을 가지고 공청회를 할 계획입니다.

○소위원장 이수진 김미애 위원님.

○김미애 위원 이걸 참 쉽지 않은 문제인 것 같습니다. 이걸 현재 겪고 있는 당사자나 가족, 그 주변인들의 어려움 그리고 우리가 가고자 하는 그 이상 사이의 괴리가 참 크다고 생각합니다.

저는 과거에 변호사 시절에 국선 변호의 상당 부분을 이런 분들을 뵈는 적이 있는데 참 쉽지 않았거든요, 개인적 경험으로는. 접견을 갔을 때도 항상 제가 뵈는 손이 이렇게 가 있는 그게 쉽지 않았고 또 법정에서도 여러 돌발행동이 있을 때 가급적이면 이분들의 행동이 아니라 말하지 않는 마음 속의 의사를 추정해 가면서 변론을 하기도 하고 막 그랬습니다.

그런데 지금 인프라가 구축 안 된 상태에서 이 대상이 2만 6000~2만 8000이나 되는데 바로 가기에는 오히려 이분들을 더 큰 인권침해 상황에 놓이게 할 수도 있을 겁니다. 그러면 다 준비가 돼야 되는데 그러면 마냥 또 준비될 때까지 기다릴 수도 없고, 제가 법을 충분히 보지 못했지만 의사능력이 부족한 분들에게 누군가는 그러면 행위능력을 가지는 후견인 등이 그 역할을 또 해야 되는 게 현실이거든요. 그래서 그런 현실도 감안을 해야 돼서 이 부분을 쉽게 말하기는 어렵고.

저는 가장 중요한 게 이런 일들을 오래 했다는 현장에 계신 의료인이나 또 당사자 또 다른 전문가들 의견을 듣는 게 무엇보다 중요하다고 생각합니다. 그래서 정부 차원에서도 공청회를 하시겠다고 하는데 우리 상임위 차원에서 공청회를 통해서 다양한 목소리를 듣는 기회를 가졌으면 합니다.

○소위원장 이수진 좋은 의견이신 것 같습니다.

혹시 다른 위원님들, 김윤 위원님.

○김윤 위원 저도 존경하는 김미애 위원님 하시는 말씀에 동의하고.

정부가 아마 1차 공청회를 하고 나면 어느 정도의 방향성이 잡힐 거라고 생각을 해서 1차 공청회를 마친 이후에 국회 차원의 공청회를 하면 좋지 않을까 생각합니다.

○소위원장 이수진 그러면 정부가 1차는 12월 내에 하신다고 했으니까 12월 내에 하는 공청회를 보고 그 내용을 가지고 국회에서도 위원님들과 함께, 의견이 다양하실 것 같아요. 그래서 저희도 한번 논의 테이블을 형식은 어떻게 할지는 고민해 보고 만들기로 하고. 또 2월에는 계획을 가지고 하신다고 했으니까 그 계획에 우리 위원님들의 의견이 반영되도록 그렇게 한번 하는 것으로 하겠습니다.

○김미애 위원 저는 심사숙고해서 천천히 갔으면 합니다. 속도를 빠르게 한다고 꼭 좋을까 하는 데 대한 의문을 가집니다.

서미화 위원님이 빠르게 하라고 하는데……

○서미화 위원 나는 빠르게 한다는 말인 줄 알고 동의합니다 이러면서……

○소위원장 이수진 한지아 위원님.

○한지아 위원 저도 이걸 굉장히 여러 가지 사회적 과장이 있을 수가 있기 때문에 인권을 잘 보호하면서도 심사숙고를 하면서 우리 상임위 차원에서도 갔으면 좋겠습니다.

인권이라는 게 여러 면이 있을 것 같습니다. 하나는 본인의 의사가 잘 반영될 수 있도록 하는 부분 또 우리 사회가 안전할 수 있다는 그런 부분도 감안을 해야 되겠지만 본인이 치료받을 수 있는, 국가가 그런 치료를 할 수 있게끔 하는 그러한 건강권에 대한 부분도 우리가 놓쳐서는 안 된다고 생각합니다.

유엔에서 정신건강질환자들에 대해서 인권에 대한 얘기를 하고 비자발적인 입원에 대한 얘기를 하면서 한 얘기가 정신질환 때문에 그 사람이나 다른 사람에게 즉각적인 임박한 위해가 발생할 중대한 가능성이 있는 경우에도 비자발적인 입원이 필요할 수도 있겠지만 그보다도 정신질환이 심각하고 판단력이 손상된 사람의 경우 그 사람이 입원을 해서 치료를 받을 수 있게 하는 것 또한 인권에 입각한 그런 접근이라고 명시했습니다.

그렇기 때문에 우리가 그 두 가지를 다 고려해서 여러 가지 사안들, 우리 사회의 기반, 인프라를 다 고민해서 이 부분은 갖고 갔으면 좋겠다는 말씀을 드립니다.

○김윤 위원 저도 한 말씀만 덧붙이면 ……

○소위원장 이수진 김윤 위원님.

○김윤 위원 한지아 위원님 말씀에 100% 공감하고요.

OECD 통계 중에 정신과에 입원했다가 퇴원한 환자의 자살률에 관한 통계가 있는데요. 우리나라 정신질환자, 정신병원에 입원했다 퇴원한 환자의 자살률이 OECD 평균에 비해서 2배나 높습니다. 그건 무슨 얘기냐 하면 치료환경이 좋지 못하다는 얘기지요. 그러니까 치료시키려고 병원에 입원했는데, 치료하려고 병원에 입원했는데 병원에서 오히려 트라우마를 입고 나와서 자살을 하게 되는 일이 벌어진다는 뜻입니다.

그렇게 된 이유는 뭐냐 하면 정신과의 입원수가 현저하게 낮아서 지금 대학병원과 종합병원의 정신과가 병상을 줄이고 있고 병동을 없애고 있지 않습니까? 그러니까 제대로 치료받을 수 있는 병상은 줄어들고 제대로 치료받을 수 없는 병상에 환자들이 입원하니까 그런 일이 벌어지는 거거든요.

그래서 복지부에서 계획을 세우실 때 정신건강정책국의 영역에서 계획을 세우시는 게 아니라 건강보험과 돌봄까지를 아우르는 계획을 세워 주시고, 특히 지금 현재 현저하게 부족한 소위 급성기에 좋은 치료병상, 치료시설을 어떻게 확보할 것인가에 중점을 가지고 계획을 만들어 주시면 좋겠습니다. 그래야 오늘 논의한 내용과 치료라고 하는 내용이 서로 균형을 이룰 수 있다는 점……

○소위원장 이수진 보건복지 차관님, 잘 말씀 다 동의되시지요?

○보건복지부제2차관 이형훈 예.

○소위원장 이수진 저희가 같은 생각들을 참 많이 하거든요. 그래서 그 문제를 해결하는데 각 영역, 보건복지부의 과별로 정책별로 이런 정신건강 관련한 대책을 어떻게 세워야 될지 촘촘하게 만들어서 공청회 때 좀 해 주시고, 그 전에도 자료 같은 것들이 있으면 우리 의원실에, 여기 계신 소위 위원님들에게 다 제공을 해 주세요.

○보건복지부제2차관 이형훈 예, 알겠습니다.

○소위원장 이수진 왜냐하면 저희도 좀 부족한 부분에 대한 의견들을 위원님들도 고민해야 되니까.

그러면 의사일정 제18항은 보다 깊이 있는 검토를 위해 계속 심사하기로 하겠습니다.

의사일정 제19항 응급의료에 관한 법률 일부개정법률안을 심사하겠습니다.

전문위원 보고해 주시기 바랍니다.

○전문위원 오세일 자료 2쪽입니다.

개정안은 응급의료 미수금 대지급금의 상환 의무자인 응급환자 본인 및 그 배우자, 응급환자의 1촌의 직계혈족 및 그 배우자를 응급환자 본인으로 한정하려는 것입니다.

개정안은 응급환자와 친족 관계에 있는 자에게 미수금 대지급 제도로 인한 경제적 부담이 발생하지 않도록 하려는 취지로 보입니다. 다만 응급의료 미수금 대지급금의 상환율이 2024년 기준으로 14.9%로 저조한 측면이 있어 상환 의무자가 응급환자 본인으로 한정될 경우 상환액이 감소하여 응급의료기금의 재정 부담이 증가할 우려가 있다고 보았습니다.

자료 3쪽입니다.

또한 응급의료 미수금 대지급 제도와 유사한 의료급여비용 대지급 제도의 경우 상환 의무자가 본인 및 그 부양의무자로 규정되어 있고 응급의료 미수금 대지급금에 대한 구상권의 소멸시효는 3년으로서 민법의 일반채권 소멸시효인 10년보다 단기로 규정되어 있다는 점도 고려할 필요가 있다고 보았습니다.

이상입니다.

○소위원장 이수진 정부 측 의견 들겠습니다.

○보건복지부제2차관 이형훈 해당 법안에 대한 정부 입장은 신중 검토입니다.

본인 외에 상환 의무자에게 부당한 부담이 가지 않도록 일부 상환 의무자 범위 조정의 검토 필요성에는 동의합니다. 본인으로 한정하는 경우 경제적 능력이 있는 상환 의무자가 있어도 진료비를 지불하지 않는 악용 우려가 있습니다. 현재 경제적 능력이 없거나 가족 관계가 단절된 경우에는 결손 처리를 하는 등 불필요한 피해자가 발생하지 않도록 제도를 운영하고 있다는 점을 말씀드립니다.

○소위원장 이수진 질의하실 위원님 계십니까?

소병훈 위원님.

○소병훈 위원 결손 처리의 그 과정이 어떻게 되고 있습니까? 그러니까 결손 처리를, 이 경우에 왜냐하면 악용하는 경우와 선의의 피해자가 동시에 존재할 수 있기 때문에 예컨대 결손 처리가 제대로 된다면 이 부분은 어느 정도 고려할 수 있는데 결손 처리가 쉽지 않아요. 그리고 그것을 어찌면 그 당사자들이 증명을 또 해야 되는 경우가 있고, 예를 들면 아버지하고 딸의 관계라면 20년도 넘게 같이 살지 않고 따로 살았는데, 따로 관계도 없는데 그 딸한테 대신 내라는 게 온단 말입니다. 그러면 그런 결손 처리를, 그 정도 상황 같으면 깊게 증명하지 않아도 알아서 결손 처리를 할 수 있어야 되는데 그렇지 못하거든요. 그러니까 그런 부분이 보완되지 않으면, 이런 악용하는 사람이 나쁘기는 하지만 선의의 피해자를 보호하는 게 우선이다라는 생각이 들어요.

그리고 아까 말한 다른…… 지금 이거는 응급환자, 친족 관계에 있는 자 이렇게 쪽 되는데 다른 케이스하고는 약간 다르다, 부양의무자하고는 또 다른 케이스다. 그래서 이 부분을 어떻게 그러면 조정을 할 수 있고 선의의 피해자들을 어떻게 보호할 수 있는지 그 부분을 한번 말씀해 보십시오.

○**보건복지부제2차관 이형훈** 위원님, 한 번 더 상세히 말씀드리겠습니다.

지금 결손 처리는 상환 의무자가 경제적으로 상환 능력이 없거나 또 응급환자와 가족 관계 단절이 확인되는 경우에 그렇게 처리하고 있습니다. 상환 의무자의 행방을 알 수 없거나 재산이 없는 경우, 소멸시효 3년이 완성된 경우, 상환 의무자가 수급자인 경우 또 상환 의무자가 가족 관계 단절 상태로 판단되는 경우에 그렇게 하는데요. 지금 상환의 결손 상황은 2020년부터 2024년까지 5년간 총 지급액 390억 중에 상환액은 54억 원, 약 14%를 상환했고 51%는 결손 처리를 했습니다. 51%이면 반 이상은 결손 처리했구요. 그 외에 137억은 지금 독촉, 압류 등 채납처분 절차가 진행 중이라고 말씀드리겠습니다.

또 다음으로 말씀하신, 상환 의무자를 본인으로 한정하자라고 하셨습니다. 경제적 능력이 있는 배우자 또는 1촌의 직계혈족이 있는데 본인이 경제적 능력이 없다는 이유로 응급진료를 받고 진료비를 지불하지 않는 등의 악용 우려가 있기 때문에 이 부분에 대해서 좀 신중한 검토가 필요하다는 말씀을 드렸습니다.

○**소병훈 위원** 그러니까 악용하는 사람이 충분히 있을 수 있다는 건 제가 압니다. 그렇지만 그 악용하는 사람을, 악용하는 사람 때문에 선의의 피해자를 만들면 안 된다. 그리고 그걸 본인에게 입증하라고 하는 것보다도 객관적인 어떤 근거가 있고 객관적인 상황을 우리가 이해할 수 있다면 결손 처리 대상을 폭넓게 규정을 해야 되는데 그 부분에 대한 준비를 좀 하셔야 된다 이거지요. 단순히 20년을 따로 떨어져 있다는 것보다도 매일 같이 살지만 정말 자기는 부자 관계, 부녀 관계, 가족 관계를 끊고 싶을 정도로 자기에게 큰 피해를 주는 그런 가족 관계도 있습니다. 그래서 그런 부분까지도 이 결손 처리 케이스를 어떻게 규정해야 될 것인지, 그래서 정말 선의의 피해자는 없어야 되는 그런 케이스를 좀 더 구체적으로 준비해야 되지 않을까요, 이 법으로 이렇게 안 하려면?

○**보건복지부제2차관 이형훈** 위원님, 건강보험심사평가원에 결손처리심의위원회를 설치·운영하고 있습니다. 여기에서 또 여러 사례들이 축적이 되고 지금까지 한 5년간 50% 이상의 결손 처리를 하고 있어서 그런 사례들이 많이 축적이 되면서 또 그에 따른 판단들을 빨리빨리 하고 있기 때문에 이런 부분들은, 지금 일단은 제도적으로는 그렇게 운영을 하고 있다는 말씀 드리고요.

혹시 위원님 좀……

○**소병훈 위원** 쉽지 않아요. 그게 케이스가 한두 가지가 아닌데요.

○**보건복지부제2차관 이형훈** 그렇습니다.

○**소병훈 위원** 예를 들면 어느 병원 응급실에서 환자를 치료를 하고 그 환자가 눈에 안 보여. 그러니까 경찰에 신고합니다. 그런데 그 환자는 휠체어를 타는 환자라 멀리 가지도 못해. 경찰에서는 응급치료 받고 도망갔다고 하니까 와서 그 환자를 찾아보니까 바로 문 앞에 있어요. 그건 뭐냐 하면 이 사람이 응급치료비를 못 낼 것 같으니까 이 사람 가족을 찾아내려고 신고를 하는, 대손 지급을 할 수도 있는데도 이런 식으로 이용을 하는 그런 데도 있고. 그리고 심한 경우에는 보기에 좀 능력이 없어 보인다 그러면 무슨 핑계를 대서라도 자기 병원에서 밖으로, 다른 데로 내보내고 심한 경우에는 서울에서 강원도까지 밀려간 경우도 있고 이렇거든요. 그러니까 그런 케이스를 없앨 수 있는 뭔가 좀 구체적인 안을 만들어야 되지 않을까요, 이 법을 안 만들고 싶으면?

○**보건복지부제2차관 이형훈** 담당 국장이 다른 보완설명 드리도록 하겠습니다.

○**보건복지부공공보건정책관 정통령** 공공보건정책관 정통령입니다.

말씀 주신 부분 충분히 공감하고요. 저희가 응급의료법에서는 다른 법에 비해서 그래도 상당히 좀 유연하게, 그러니까 이런 부분들을 결손 처리를 할 수 있게 되어 있습니다. 그래서 저희가 소멸시효도 민법상 채권은 10년인 반면에 3년으로 운영을 하고 있고요. 의료급여법 같은 경우에는 결손 처리하는 이런 형태를, 상황을 대통령령에 규정하도록 돼 있는 반면에 여기에는 건강보험심사평가원장이 인정하는 경우로 해서 심사평가원에서 위원회를 운영하면서 조금 더 탄력적으로 이런 제도들을 운영할 수 있게 되어 있기 때문에 저희가 심사평가원과 다시 한번 위원회의 어떤 그런 사례들, 현재 규정상 미비한 부분들을 조금 더 깊이 조사를 해서 그 부분을 좀 보완해서 보고드릴 수 있도록 그렇게 하겠습니다.

○**소병훈 위원** 예, 그렇게 좀 해 주십시오, 구체적으로.

○**보건복지부공공보건정책관 정통령** 예.

○**소위원장 이수진** 김운 위원님.

○**김운 위원** 소병훈 의원님께서 발의하신 대로 법 개정이면 상환율이 떨어질 거다 이렇게 예측을 하시는 거잖아요. 그런데 지금 상환되는 비율, 실적을 고려할 때 이 법이 개정되면 상환율이 얼마나 떨어질 거라고 생각하십니까? 예측할 수 있는 객관적인 자료가 있습니까?

○**보건복지부제2차관 이형훈** 지금 말씀드렸지만 지난 5년간 상환율은 13.8, 14% 정도 됩니다.

○**김운 위원** 그거는 알겠는데, 예를 들어서 24년에 14.9%가 상환이 됐는데 그러면 이 14.9% 중에서 본인이 아닌 다른 가족, 배우자나 또는 부양의무자가 상환한 금액을 구분해 낼 수 있으십니까?

○**보건복지부공공보건정책관 정통령** 현재 통계로는 정확한 구분은 어렵습니다. 다만 저희가 상환율이 제일 낮을 때는 한 7.8%까지 간 해도 있었기 때문에 그것보다는 조금은 더 영향을 받을 수 있다라고 생각은 하고 있습니다.

○**김운 위원** 그러니까 복지부의 주장이 좀 뭐랄까, 설득력을 가지려면 이게 본인이 상환한 금액과 나머지 부양의무자가 상환한 금액이 얼마인지를 구분해서 얘기를 해 주셔야 복지부의 주장이 개연성이 있는 주장인지, 어느 정도의 실질적인 영향이 있는 주장인지를 좀 판단할 수 있을 것 같습니다.

그래서 앞서 말씀하신 세부적인, 예외적인 상황에도 불구하고 상환 의무를 계속 부양의무자에게 부과하는 방식의 문제를 해결하려는 그 분석과 함께 법 개정했을 때 실질적인 상환율이 어느 정도 떨어질지에 대해서도 같이 자료를 제시해 주면 좋겠습니다.

○**보건복지부제2차관 이형훈** 예. 위원님, 상환액과 결손액이 있는데 그 내용에서 관계가 어떻게 되는지 하는 부분들을 한번 분석해 보도록 하겠습니다.

○**소위원장 이수진** 위원님들 충분히 질문하신 것 같습니다.

의사일정 제19항은 보다 깊이 있는 검토를 위해 계속 심사하기로 하겠습니다.

의사일정 제20항 응급의료에 관한 법률 일부개정법률안을 심사하겠습니다.

전문위원 보고해 주시기 바랍니다.

○**전문위원 오세일** 자료 2쪽입니다.

개정안은 모든 국민이 거주지역을 이유로 차별받지 않고 응급의료를 받을 권리를 법률에 명시함으로써 응급의료서비스의 지역별 편차 해소를 위한 국가의 책무를 강화하려는 것입니다.

수도권 인구 집중도가 계속 증가하여 50.8%에 이르는 등 인구 분포의 불균형이 심화되고 있어 지역별 의사 수와 같은 보건의료서비스의 격차 또한 증가하는 것에 대한 우려가 있는 상황을 감안할 때 거주지역에 따른 차별 없이 응급의료를 받을 권리를 법률에 명시하는 것은 지역적으로 균형 있는 보건의료의 공급과 의료취약지역 등에 대한 지원을 강조하는 의의가 있을 것으로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 이수진 정부 측 의견 주시기 바랍니다.

○보건복지부제2차관 이형훈 해당 법안에 대한 정부 입장은 수용입니다. 응급의료 취약지에 대한 지원을 강화하고자 하는 입법 취지에 동의합니다. 그리고 복지부는 취약지역 응급의료기관 육성 사업을 통해 응급의료기관에 대한 운영비 지원, 의료인력 파견, 응급원격협진 그리고 응급영상판독 등을 지원하고 시행하고 있습니다.

○소위원장 이수진 위원님들 의견 주시기 바랍니다.

김윤 위원님.

○김윤 위원 좀 사소한 문제일 수 있는데 3조에, 그러니까 5페이지에 있는 조문 자료 3조에 ‘사회적 신분’ 이렇게 되어 있는데 이 신분이라는 말이 좀 적절한지, 보통 우리가 사회·경제적 지위, 사회적 지위, 영어로는 소시오이코노믹 스테이터스(socioeconomic status) 또는 소시오이코노믹 포지션(socioeconomic position) 이런 말을 써서 이게 신분이라는 용어가 적절한지 잘 모르겠습니다.

○김미애 위원 과거에 이런 신분을 썼는데, 형법에도 신분법, 비신분법 이렇게도 했기 때문에, 그런데 요즘은 그렇게 잘 표현 안 하는 것 같기도 합니다. 사회적 지위, 어차피 개정할 거면 그렇게 해도 괜찮을 것 같네요.

○소위원장 이수진 그냥 원안 그대로 유지해 주시지요. 논의하지 않은 거를 갑자기 지금 와서……

○김윤 위원 예, 알겠습니다.

○소위원장 이수진 그러면 의결하겠습니다.

의사일정 제20항 응급의료에 관한 법률 일부개정법률안은 원안대로 의결하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

의사일정 제21항 공공보건의료대학 설립·운영에 관한 법률안과 의사일정 제22항 공중보건장학을 위한 특별법 전부개정법률안을 심사하겠습니다.

전문위원 보고해 주시기 바랍니다.

○전문위원 오세일 두 안건은 소위에서 세 차례씩 심사가 이루어졌었고요. 지난번 소위에서는 원활한 토론을 위해서 정부에서 수정대안을 마련해서 다음번 회의에서 보고할 필요가 있다는 의견이 제시된 바 있습니다.

이상입니다.

○소위원장 이수진 지난번 소위에서 보고할 때 정부가 안을 안 갖고 있어서 구체적으로 내용 얘기를 못 했어요. 그래서 이번에 다시 보고하기로 했는데 정부 측에서 준비하신 만큼은 보고해 주시기 바랍니다.

○보건복지부제2차관 이형훈 예, 위원님.

법안의 취지에 적극 공감한다는 말씀은 드렸습니다.

지금 현재 공공의대 정원 규모 산출을 위한 연구를 추진 중에 있습니다. 그래서 아직 그 연구가 진행 중이라는 말씀 드리구요. 공공의대 정원 규모가 추계되는 대로 공공의대 정원 학군을 확보할 예정이라는 말씀 드립니다.

○소위원장 이수진 잠시만요, 차관님.

저희가 전문위원 보고도 지난번에 다 안 받은 것 같으니까 일단 전문위원 보고를 받고 정부 측 의견 듣지요.

○보건복지부제2차관 이형훈 예.

○전문위원 오세일 그러면 조문별 검토를 간략하게 보고드리겠습니다.

자료 13쪽입니다.

법률의 제명, 목적 및 정의 조항입니다.

두 법률안은 공통으로 공공보건의료 양성을 위하여 공공보건의료대학 또는 공공보건의료인력양성 의과대학을 설립 또는 지정함으로써 공공보건의료 발전에 이바지하고자 한다는 목적을 제시하고 있습니다.

김문수 의원안에서는 제2조제3호에서 공공보건의료인력을 공공보건의료인력양성 의과대학의 학사학위 소지사로서 의사면허를 취득하고 의무복무하거나 의무복무를 마치고 공공보건의료업무에 종사하는 인력으로 정의하고 있는데, 간호대학 학생은 제외된다는 점을 고려할 필요가 있다고 보았습니다.

자료 15쪽, 2번 설립 방식입니다.

박희승 의원안은 국가와 지방자치단체가 공공보건의료대학 법인을 설립하도록 되어 있고 김문수 의원안은 시도별로 의과대학이 있는 하나 이상의 대학을 공공보건의료인력양성 의과대학으로 지정하도록 되어 있습니다.

박희승 의원안의 경우 국가와 지방자치단체가 공공보건의료대학을 별도 법인으로 설립하는 경우 해당 대학법인은 운영의 자율성은 높은 반면에 운영재원 확보의 안정성이나 교직원 신분의 안정성을 상대적으로 낮아질 수 있다고 보았습니다.

김문수 의원안에서는 의과대학에 대한 보건복지부의 관할권이 없을 경우 보건복지부 및 교육부의 지도·감독 체계가 명확하지 않을 수 있으며 현재 운영되고 있는 의과대학을 공공보건의료인력양성 의과대학으로 지정할 경우 대학의 자율권에 근거한 이견이 제기될 수 있다고 보았습니다. 또한 전라남도의 경우와 같이 해당 지방자치단체에 소재한 의과대학이 없는 경우에 대한 고려도 필요할 것으로 보입니다.

자료 17쪽, 3번 조직입니다.

안 제9조 및 제10조는 공공보건의료대학의 장으로 총장을 두고 임기는 4년으로 하며 총장은 총장추천위원회가 추천한 후보자 중에서 이사회가 선출하여 보건복지부장관의 제청으로 대통령이 임명하도록 하고 있습니다.

현행 국공립 대학 등의 총장 선출방식의 경우 대학의 유형에 따라 일부 차이가 있는데

국가와 지방자치단체가 설립하는 모든 공공보건의료대학의 총장을 동일한 방식으로 선출하는 것은 다른 대학에 미치는 영향 등을 고려하여 추가적인 검토가 필요할 것으로 보입니다.

여기까지 보고드리겠습니다.

○소위원장 이수진 그냥 다 해 주세요.

○전문위원 오세일 알겠습니다.

자료 20쪽, 대학·대학원의 설치 여부 및 학생 선발입니다.

박희승 의원안은 공공보건의료대학의 의과대학 및 전문대학원인 의학전문대학원과 보건대학원을 둘 수 있도록 하고 학사·석사·박사 과정을 모두 운영할 수 있도록 규정하고 있습니다. 김문수 의원안은 의과대학 지정만 규정하고 있습니다.

학생 선발의 경우 박희승 의원안은 해당 지방대학이 소재한 지역의 고등학교 졸업자의 수가 입학자 인원의 60% 이상이 되도록 하였고 의료 취약지의 시도별 분포, 공공보건의료기관의 수 및 필요 공공보건의료인력 수 등을 고려하여 시도별로 일정 비율을 선발하도록 규정하고 있습니다.

김문수 의원안은 고등학교 졸업자 중 학칙으로 정하는 바에 따르되 지방대학 및 지역 균형인재 육성에 관한 법률 제15조의 취지에 부합하여 선발하도록 규정하고 있습니다.

학생 선발에 있어 지역에 필요한 공공보건의료인력의 수 등 어떤 특정 기준을 적용하기 위해서는 그 기준을 검토하는 방법과 담당 기관 등에 대한 논의가 있어야 할 것으로 보입니다.

또한 제정안은 학생 선발에 있어 필요한 사항을 대통령령으로 정하도록 하고 있는데 개별 학교의 학생 선발에 관한 사항을 대통령령으로 정하도록 하는 것이 적절한지 검토가 필요한 것으로 보입니다.

지역 주민 60% 이상 선발이라는 기준의 적용에 있어서는 지역 의료격차의 해소 및 공공보건의료의 강화라는 입법 취지와 학생 선발의 지역 간 형평성 사이의 균형에 대한 사회적 논의가 필요한 것으로 보입니다.

자료 24쪽, 학비 등의 지원 및 반환입니다.

박희승 의원안은 입학금, 수업료 등의 비용을 국고 및 지방자치단체에서 전액 지급 가능하도록 규정하고 있고 김문수 의원안은 의사면허 취득 후 10년 동안 공공보건의료기관 또는 공공보건의료업무에 복무할 것을 조건으로 입학금과 수업료를 면제하고 실습비, 기숙사비 등을 국고에서 지급 가능하도록 규정하고 있습니다.

박희승 의원안의 경우 의무복무 불이행으로 의사면허가 취소된 사람의 경우 학비 등 반환 의무가 면제되는데 안 제32조제2항에 따라 의무복무 기간 중 복무하지 아니는 잔여기간이 지나면 의사면허가 취소된 자에게 의사면허를 재교부할 수 있다는 점을 고려할 때 의무복무 불이행으로 인한 의사면허 취소가 학비 등 반환 면제 사유가 되는 것은 적절하지 않은 것으로 보입니다.

자료 29쪽, 교육·실습기관 및 부속병원입니다.

박희승 의원안에서는 보건복지부장관 및 지자체장이 공공보건의료대학 설립 지역 내에 실습기관이 없는 경우에 별도 부속병원을 설립하도록 규정하고 있고 김문수 의원안은 의과대학이 없는 국립대학에 공공보건의료인력양성 의과대학이 설치된 경우 해당 국립대학

에 부속병원을 설립하도록 규정하고 있습니다.

박희승 의원안과 관련하여 국가가 아닌 지자체가 의과대학을 설립한 경우에 부속병원 설립에 보건복지부장관이 관여하여야 하는지 명확히 규정할 필요가 있다고 보았습니다.

자료 32쪽, 의무복무 조항입니다.

두 법률안은 공통으로 의무복무 기간을 10년으로 규정하고 있고 의무복무를 조건으로 하여 의사면허를 부여하도록 규정하고 있습니다.

박희승 의원안은 보건복지부장관이 정하는 의료기관에서 수련하거나 특정 전문과목을 전공 수련할 경우에 의무복무 기간을 인정하도록 규정하고 있고 김문수 의원안은 군 복무기간은 의무복무기간으로 인정하고 있습니다.

제정안과 전부개정안이 설정한 의무복무기간 10년은 학비지원기간의 1.7배~2.5배 수준으로 이는 학비지원기간 대비 의무복무기간을 1.5배~2.5배 사이로 규정한 사관학교나 경찰대학, 한국농수산대학 등과 유사한 수준으로 보입니다.

의무복무를 이행하지 아니한 의무복무의사에 대한 면허 취소가 재량규정이고 해당 사유로 면허가 취소된 사람은 학비 반환 의무에서도 제외되며 취소된 면허를 일정 기간 경과 시 재교부할 수 있도록 규정한 것은 제재수단으로서 실효성 문제가 제기될 수 있다고 보았습니다.

자료 33쪽입니다.

김문수 의원안에서는 의무복무를 이행하지 아니한 사람에 대해서 의사면허를 취소하도록 규정하고 있는데 질병 또는 심신의 장애 등 부득이한 사유로 인해 의무복무 이행이 어려운 경우에 의사면허 취소를 달리 규정할지 논의할 필요가 있다고 보았습니다.

이상입니다.

○소위원장 이수진 정부 측 의견 들겠습니다.

○보건복지부제2차관 이형훈 정부 측 의견 드리겠습니다.

수석전문위원님 보고에 따라서 조항별 말씀을 드리겠습니다.

13쪽 제명, 목적 및 정의 등에 대해서는 두 법률안의 목적은 지속가능한 공공의료인력 양성 체계를 마련하기 위한 것으로 법안의 전체적인 취지에 동의합니다.

다만 김문수 의원안의 경우에는 공중보건장학제도의 폐지를 초래하여 현재 공중보건장학제도 혜택을 받고 있는 의대생과 간호대생에 대한 지원이 중단되므로 이를 고려한 법안 제정이 필요합니다.

다음, 15쪽 2번 설립 방식에 대한 의견입니다.

두 법안은 모두 다수의 공공의대 설립이 가능하도록 규정하고 있습니다. 다수의 의대는 평가인증기준 등을 고려할 때 설립 가능성이 낮다고 판단됩니다.

복지부는 과도한 지역경쟁 유발을 방지하고 또 일정 수준 이상의 정원 확보를 통해 교육의 질을 담보하고자 국가 주도로 공공의대 1개소를 설립하는 방안을 고려하고 있습니다. 그 형태는 박희승 의원안 제4조와 같은 특수법인 형태가 가능한 방안이라고 보고 있습니다.

다음, 17쪽 조직에 대한 부분입니다.

박희승 의원님 안과 같이 공공의대가 특별법에 따른 특수법인 형태로 설립되는 경우가장 유사한 사례로는 한국과학기술원이 있습니다. 여기서는 총장을 선출하는 방식도 유

사업법례를 따르는 것이 합리적이라고 볼 수 있겠습니다.

박희승 의원안은 이사회 구성에서 공공의대 소재지의 시도지사 추천인을 포함하고 있는데 공공의대가 전국 단위 인력양성 체계인 점을 고려할 때 검토가 필요한 부분입니다. 이사회 구성은 의료계 및 관련 전문가들이 충분히 참여할 수 있도록 수정될 필요가 있습니다.

20쪽, 대학·대학원 설치 및 학생 선발에 대한 부분입니다.

○**김미애 위원** 잠깐만, 의사진행발언……

○**소위원장 이수진** 예.

○**김미애 위원** 제가 전문위원 보고를 아직 한 번도 제대로 안 들었길래 들었는데, 이렇게 정부 측 의견이 전체를 다 할 것 같으면 다시 돌아가서 또 질의해야 돼서 효율적이지 않을 것 같습니다.

아까 정부가 모두에 설명을 하면서 오늘은 준비가 안 됐다고 했는데 또 준비는 된 것 같은 느낌이에요, 하나하나 설명하시는 것 보니. 그래서 무엇인지를 보고 만약에 그렇게 하나하나 할 것 같으면 여기 한 챕터씩 잘라 가지고 정부 의견 듣고 질의할 것 있으면 질의하고 이렇게 가는 게 좋을 것 같습니다.

지금 전체에 대한 말씀을 주시고…… 그러면 벌써 제가 봐도 1개만 정부는 예정하고 있네요? 방금 말씀하시는 것 들어 보니.

○**보건복지부제2차관 이형훈** 예.

○**김미애 위원** 그러면 그 1개로 과연 이 법으로 달성하고자 하는 취지를 구현해 낼 수 있을까 하는 의문이 들거든요. 그래서 제가 오전에도 말씀드렸지만 지금 우리가 이것을 하는 이유가 지역의료·필수의료 정상화인데 상당한 고민이란 말이에요.

어제 소위에서 지역의사제법을 통과시켰잖아요?

○**보건복지부제2차관 이형훈** 그렇습니다.

○**김미애 위원** 그거랑도 사실은 여기에 있는 것도 일치시켜야 될 부분도 상당하고, 그래서 정부의 큰 그림이 무엇인지를 정하고 거기에 맞춰서 하나 하나 로드맵을 세워 나가야 되고 그 과정 속에 이 법도 들어가고 어제 통과시킨 법도 들어가고 필수의료법 다 들어가는데, 너무나 분절된 느낌이에요.

이렇게 되면 누더기가 되지 않을까, 우리는 정말 심사숙고해서 했다고 하지만 현장에서 작동이 제대로 안 되면 이것을 왜 해야 되는가 하는 의문이 들어요.

그래서 저는 오늘 과연 지금 차관님이 말씀하셔서 이게 다 정리가 될지, 그렇다면 하되 아니면 좀 더 정리해 줬으면 좋겠어요. 정리하고 계획을 좀 세우고 이것이 논의가 돼야지 실질적이라고 생각합니다.

○**소위원장 이수진** 그런데 이것을 발의해서 법안 상정을 요청한 의원님의 생각도 있고…… 지금까지 한 번도 논의를 안 했어요, 법안이 몇 번째 올라왔는데.

그래서 사실 저도 오늘 정부가 대안을 안 가져왔고 또 대안 없이 이 법안만 가지고 얘기하는 게 한계가 있다라는 것은 분명히 알고는 있습니다만 이 법안이 올라온 이상 전문위원의 의견이 있었고……

제가 보기에는 차관님 이것 설명을 정부 측 입장을 길게 얘기하시지는 않을 거지요?

○**보건복지부제2차관 이형훈** 예.

○소위원장 이수진 그래서 다 들어 보고 혹시 그 안에서 질문할 게 있으면 질문하시고 또 위원님들이 이것 말고 나는 다른 공공의대, 나는 다른 것을 생각하는 게 있다라는 의견이 있으시면 그 정도까지만 받고 이것은 정리하지요. 빠르게 진행해 주시고.

○김미애 위원 제가 하나만 좀 덧붙이면 차관님은 충분히 논의가 숙성되지 않은 것은 설불리 말씀 안 하시는 게 좋다는 생각이예요, 정부를 위해서도.

○보건복지부제2차관 이형훈 예, 알겠습니다.

○김미애 위원 아시겠지요?

○보건복지부제2차관 이형훈 예.

○김미애 위원 괜히 그게 오해를 사게 되고 갈등의 소지만 키울 측면이 있어서 제가 우려스러워서 드리는 말씀입니다.

○소위원장 이수진 계속해 주십시오.

○소병훈 위원 아니, 저도 짧게 한 말씀만 드릴게요.

보니까 공공의대 부분이 어제오늘 일이 아니고 지난 21대에서는 법사위까지 갔다가, 그쪽 법사위 사정을 들어 보니까 상정을 안 해서 이게 그냥 없어진 거다 이런 식으로 얘기하는데, 지금 복지부에서는 여기에 대해서 어떤 의지를 가지고 있습니까, 공공의대?

○보건복지부제2차관 이형훈 예, 어제 지역 의사 양성에 관한 법률도 심의를 하셨듯이 지금 지역·필수의료에서 의료인력이 부족하다라는 부분은 다 공지의 사실이고 그렇게 인식을 하고 계십니다. 그래서 지역 의사를 양성하는 법들이 어제 심의가 되었고 지금 저희가 이 공공보건의료대학 설립·운영 또 공중보건장학을 위한 특례법은 공공 복무 의사를 양성하기 위한, 즉 공공의료 분야에서 장기 복무할 의료인력을 양성하는 것입니다.

그래서 지역 의사 양성에 관한 법률하고는 또 다른 그런 의사들을 양성하는 거고 또 이렇게 양성된 의사들은 면허를 가진 이후에 공공의료기관, 분야에서 일정 기간 또 의무복무를 하는 것입니다. 그래서 지역 의사제하고는 또 다른 차원의 보완이 필요한 그런 의사 양성체도로 이해하고 그렇게 추진하고 있습니다.

○소병훈 위원 제가 알고 싶은 것은, 이게 한두 해의 문제가 아닌데 지금 정부에서는 공공의대 설립을, 그러면 이 법안을 정부의 공공의대 설립을 전제로 하고 진행해도 되겠습니까?

○보건복지부제2차관 이형훈 지금 이 법안이 발의되어 있기 때문에 저희들이 지금 계속 말씀드렸던 것은……

○소병훈 위원 그러니까 정부의 입장이 어떠한 거지요. ‘우리는 그 공공의대를 일단 설립을 할 테니 내용을 좀 다듬어 주세요’, 아니면 ‘우리 정부에서 어떤 내용을 가지고 내놓을 테니까 이것과 합해서 일단 설립은 한번 해 보겠습니다’ 이런 의지를 가지고 있다고 우리가 믿고 해도 되겠습니까?

○보건복지부제2차관 이형훈 예, 그래서 총론에서 제가 말씀드린 것처럼 공공의대 정원·규모 산출 등을 위한 연구를 지금 추진 중에 있고 그 내용은 규모와 함께 교육과정, 의무복무의 분야, 기관 등에 대한 구체적인 내용들이 포함돼서 연구를 할 것입니다.. 그래서 그런 방안이 마련되는 대로 이 법률안들에 대한 수정대안을 마련해서 논의할 수 있도록 그렇게 준비하겠습니다.

○소위원장 이수진 차관님, 그러니까 차관님은 지금 필수의료 지원 강화법은 저희가 통

과시켜서 법사위에 가 있고 또 지역의사제법은 저희가 어제 소위에서 통과시켰고……

○**보건복지부제2차관 이형훈** 그렇습니다.

○**소위원장 이수진** 그리고 공공의대 관련한 법도, 결국은 이게 다 따로따로 떨어져 있는 게 아니라 정부가 큰 틀에서 계획을 세워 가지고 진행을 하시는 거잖아요.

그러니까 지금 위원님들 질문에는 의지가 있느냐 이런 질문을 포함해서 이 법이 정부의 법이랑 같은 맥락이냐 이런 걸 물어보는 거거든요. 그래서 그걸 정부가 그렇게 큰 틀과 로드맵을 가지고 진행하고 있다는 것을 말씀해 주시면 되는 거예요.

○**보건복지부제2차관 이형훈** 그러니까 지금 이런 두 법안이 발의되어 있기 때문에 이 법안에 상당 부분 내용들이 들어가 있습니다. 그리고 이 내용들을, 저희가 보통 이렇게 다수 법안이 발의되었을 때 정부가 수정대안을 통해서 정부의 추진 방안을 법적 틀로 마련하고자 하는 것들은 계속되고 있으니까요. 그런……

○**소병훈 위원** 그러니까 이걸 전제하고 있다고 믿고 우리가 얘기를 진행해도 되겠지요?

○**보건복지부제2차관 이형훈** 예.

○**김미애 위원** 아니, 제가 2소위고 그래서……

오늘 세 번째잖아요. 처음부터 이재명 정부의 필수의료·지역의료 정상화를 위한 큰 그림이 뭐가 있는지, 그것을 실천하기 위한 로드맵은 뭔지, 그 과정에서 우리가 입법이 필요하다, 그래서 필요하다면 정부안도 발의하셔야 돼요. 그래 가지고 거기에 맞추는 게 맞는데 지금은 그게 안 나온 채로 계속 뭐라고 말씀하시니까 이걸 이렇게 한다고 해서 그게 맞는 방향으로 가는 건지 법안 심사하는 우리도 모르는데 국민들을 어떻게 설득시킬 수 있겠어요?

그래서 거기에 대한 그림을 먼저 제안을 하시라, 제시를 해야지요. 제시를 하고, 아니면 그 제시하는 게 어렵다면 우리가 또 이걸 토대로 공청회를 또 열어 가지고 다양한 관계자들 목소리를 듣는다든지 그래 가지고 이 시간들이 무의미하게 흘러가고……

법안심사는 하느냐, 안 하느냐가 중요한 게 아니라 그 전체의 틀 속에서 절차를 밟아 가는 의미잖아요. 지금 급하잖아요. 마음은 급한데 급할수록, 바늘허리에 꿰어 쓸 수 없잖아요. 그걸 누차 말씀했는데 아직도 저는 그게 와닿지가 않아요. 어떤 그림을 가지고 가는지 그때그때마다 말씀하시면 안 돼요. 왜냐하면 그게 있어야지 필수의료법 만들 때, 어제 지역의사제법 만들 때, 오늘 이것 할 때 이미 다 정리가 돼 있어야 돼요.

그걸 구체화시키기 위해서 이런이런 게 필요하다, 필수의료 지원에 이게 필요하고 지역의사제 규정에는 이게 필요하고 또 공공보건의료 관련해서 그 전문적인 대학을 설립해야 된다면 거기에 이게 꼭 필요한데 그건 큰 틀에서 어느 지역, 어느 지역 이 정도는 있어야 된다, 그리고 어제 말하는 입학전형에 의한 지역의사제 그거랑 이렇게 상호 보완적인 역할을 할 수 있다, 그 동일성은 뭐고 차별성은 뭔지 이런 것 하나하나 설명이 되어야지요. 이걸 계속 밀어붙여서……

자신 있습니까? 이렇게 해서 감당할 수 있겠어요? 저는 그게 걱정이에요. 어제든 제가 지역의사제법 해서 27학년도 입학전형부터 한다고 했지만 그것 감당할 수 있겠는지 저는 상당히 걱정입니다. 그래서 자꾸 이렇게 몰아붙이면 안 되고 진짜 심사숙고하고 신중히 그림 그리셔야 돼요.

○보건복지부제2차관 이형훈 예.

○소위원장 이수진 차관님, 어쨌든 공공의과대학의 역할과 기능에 대해서는 지금까지 설명을 해 주셨기 때문에 지역의사제와는 또 다르다고 저는 인지를 하고 있습니다.

다만 지금 개별 의원이 낸 법안과 정부의 안이 동일하지는 않은 것 같아요. 그래서 오늘 설명을 이렇게 하시는데 자세한 내용을 하실 것까지는 아닌 것 같습니다.

그러나 분명하게 공공의과대학이든 공공의료사관학교가 국정과제에 들어가 있습니다. 공공의료사관학교 방향으로 하든 어쨌든 개별 의원은 비슷한 성격의 이런 공공의대에 관한 제안을 한 거예요. 그렇기 때문에 그 제안에 대해서 자세하게 얘기하시기는 어려운 건 저희가 이해를 합니다만 그래도 간단하게 이 내용에 대해서 어떤 건 비슷한 취지의.....

아까도 설명을 하셨어요. 비슷한 취지로 가는 건 비슷한 취지다라고 말씀하셨기 때문에 저희가 오늘 이해하는 것은 여기서 확실한 정부안을 내놓아라가 아니고 지금까지 나온 걸 중심으로 해서 정부가 다른 것들에 대해서는 조금 생각하는 게 다른 부분이 있다 싶은 게 있으면 말씀을 주셔도 좋습니다. 그러나 확정되지 않은 걸 말씀하실 수 없을 수도 있다고 생각하기 때문에 가능한 범위 내에서의 의견을 달라는 거예요.

○보건복지부제2차관 이형훈 위원님, 말씀드렸지만 저희가 전문위원님 보고에 따라서 그런 의견을 드렸지만 전체적으로 공공보건대학, 공공보건의료대학에 대한 것들 또는 공공의료사관학교라고 할 때 그 법적 구성은 지금 얘기하는 것처럼 목적이라든가 정의 또 이 기관의 법인격이라든가 또 지정이라든가 이런 내용들 또 학생의 선발이라든가 이사회 구성·운영 이런 내용들이 같이 포함될 요소입니다. 그래서 이 법이 갖고 있는 기본적인 구성들이 저희들이 정부안으로 마련해야 될 또는 정부의 수정대안으로 마련할 법안들과 구성상 크게 다르지 않을 거라는 말씀을 드린 거고요.

거듭, 저희들이 이 연구용역을 지금 현재 추진 중에 있습니다. 그래서 연구용역이 완료되고 방안이 마련되는 대로 신속하게 이 법률안 또는 법률에 대한 수정대안 또는 정부안을 마련해서 심의하실 수 있도록 그렇게 준비하겠다는 말씀 거듭 드립니다.

○김미애 위원 아이고, 제가 말씀 안 드리려고 했는데 갈수록 태산이다, 갈수록 태산.

○소위원장 이수진 그러면 서미화 위원님 그다음에 이주영 위원님 이렇게 질문 듣겠습니다.

○서미화 위원 앞으로 지금 필수의료 강화 지원법 또 지역의사제법 제정도 앞두고 있는데요. 공공의대법도 어떤 큰 틀에서 맥락적으로 같이 가야 될 필요성이 있다고 저는 보입니다. 정부의 필수의료 정상화라는 큰 맥락에서 이 공공의대법도 우선 소위에서 나눌 수 있는 충분한 의견들을 나눴으면 좋겠고요.

아까 김미애 위원님께서도 말씀하셨던 공청회도 굉장히 좋은 아이디어로 보입니다. 그래서 복지위에서 공청회가 열릴 수 있도록 준비를 하시면 좋겠다는 의견을 드립니다.

그래서 보건복지부가 적극적으로 대응을 해 주셨으면 좋겠다는 의견을 드리고 싶습니다.

이상입니다.

○소위원장 이수진 이주영 위원님.

○이주영 위원 저도 공공 목적의 이런 의료인력이나 어떤 하드웨어를 구축하는 데 있

어서 전적으로 공감하고 정부 방향성에도 동의하는 바입니다.

그런데 어제 제가 지역의사 관련해서 공청회 때도 말씀드린 바가 있었는데 지금 여기 검토 자료에도 보면 많이 논란이 되고 있는 부분이, 15페이지에도 보면 지방자치단체의 대학법인 설립이 지방선거 관련 과잉 경쟁의 우려가 있다, 혹은 또 그다음에 보시면 개별 학교의 이런 학생 선발에 관한 사항을 대통령령으로 정하도록 하는 것 그리고 다른 학교였으면 학장이었을 공공의과대학의 그런 포지션인 것 같은데 총장으로 명하고 그 외에 위원회도 신설되고 하는 여러 부분이 있습니다.

그리고 29쪽에 보면 양질의 임상실습이 어려울 수 있기 때문에 부속병원을 설립해야 하는 이런 여러 가지 그리고 그렇다면 보건복지부장관이 관여해야 하는가 이런 다양한 논의들이 사실 궁극적으로 해결되기가 좀 어려운 부분은 있지요. 그래서 아마 정부 입장에서 정리하기 어려웠을 거라고 생각이 되는데요.

제가 공청회 때, 사실 지역의사제와 약간 다른 결이고 어쩌면 그다음 단계일 수도 있는 안에 대해서 말씀을 드렸던 이유는, 이 공공의대 관련한 법안이 지역의사제와 결국은 함께 가야 되는 법이기 때문에 먼저 말씀을 드렸던 겁니다.

공공의대를 설립하는 목적이 있을 텐데 저는 그 목적의 첫 번째는 그 지원하는 학생들이 최대한 가고 싶은 전형이어야 한다. 그리고 두 번째는 지역에 있는 국민들이 보시기에 그 전형을 통해 배출된 의사들이 내 몸을 맡기고 싶은 의사여야 한다. 그리고 결과적으로 지역의료가 다시 살아야 한다고 생각을 하는데 그런 면에서 이걸 다 해결하기 위해서는……

저는 지금 국립대학교 병원이 전국에, 이미 요지에 있고 지금 논의가 많이 되고 있는…… 제가 지금 공공의대 세우지 마라 이런 취지로 말씀드리는데 아니라 지금 우리에게 제한된 돈이 있고 최대한 빨리 이걸 확립을 해야 되지 않겠습니까?

그러면 지금 전남도에도 전남대에 163명, 전북도에도 126명의 입학생을 뽑고 있는 걸로 지금 자료상 나오는데 경북대, 부산대도 있고 다 있지 않습니까? 도별로 이미 병원이 있고 의과대학이 있는데 거기 있는 병원들이 딱 10년까지 굉장히 잘 돌아갔던 병원들이거든요.

그래서 지금 우리가 어떤 의사가 양성할지조차 나와 있지 않은 상황으로 보이는데 그것을 새로운 의과대학으로 만들어서 이걸 양성하기에는 너무 많은 시간이 걸린다는 게 걱정이 되는 겁니다.

그래서 일본 자치의대의 경우에는 지금 학생을 100명 정도 뽑는데 교수도 100명 정도 돼요. 그리고 부속병원 같은 경우에는 1100병상이 넘습니다. 그래야 겨우 수련이 가능한 단계거든요. 그런데 공공의대라고 해서 새로 신설했을 때 기초 과목이나 혹은 작은 서비스 과목들이라고 하는 이런 과목들의 교수 충원이 과연 가능할 것인가에 대한 의문이 사실은 의료계에서는 가장 큰 걸로 저는 알고 있고 이미 지방에서는 국립대학교들도 기생충학이라든가 해부학·생리학 이런 쪽들은 교수가 모자라서 순회 강연까지 하고 계시는 상황에, 이걸 만약에 빨리 계획 없이 밀어붙이면 분명히 현실적인 어려움이 있어서 또 지체가 될 가능성이 높습니다.

그렇기 때문에 저는 여기에 할당된 예산이나 정부의 의지가 있다면 오히려 각 국립대의 의과대학의 모집령을 좀 수정해서 그 각 국립대들이 지금은 지역인재 전형으로 뽑고 있

는데, 보니까 전남대 같은 경우는 거의 80% 가까이를 지역인재로 뽑고 있어요.

그래서 예를 들면, 그러면 그중 한 10% 정도, 전체 정원의 10% 정도를 모든 국립대에 공공의대 전형으로, 만약에 국가에서 책임지고 뽑고 확대된다 그러면 국가에서 생각하는 것보다 어찌면 훨씬 더 많은 수가 공공의사 인력으로 배출될 수도 있는 거거든요. 그리고 다른 국민들이 느끼시기에도 그냥 똑같이 경북의대 나온 의사, 전남의대 나온 의사, 충남의대 나온 의사로 인식이 될 것이고, 그러면 오히려 그 지역 거점 국립대를 살릴 수 있는, 어찌면 마지막 기회일 수도 있는 겁니다.

그러면 또 좋은 점이, 우리가 지금 수술하는 의사랑 어디 섬이나 아예 격오지에 가서 1차 의료 할 의사가 필요한 게 아니라 핵의학과라든가 진단검사의학과라든가 이런 과목들도 이미 회소합니다. 그런 과목들도 충분히 대학병원의 환경 안에서 잘 양성을 해낼 수가 있고 오히려 학생들도 거기에 대해서는 더 남고자 하는 마음이 많이 생길 수가 있거든요. 그러면 또 간호인력들도 훨씬 더 같이 일하기가 좋아지는 겁니다.

그래서 그런 형태로 국립대 거점으로 그 인력들이 10년 이상을 일을 하고 나면 당연히 그 지역에서의 역할이 생깁니다. 그렇기 때문에 이거를 공공의대 1개소라고 지금 말씀을 하셨는데 그렇게 특징을 너무 미리 하지 마시고 저는 오히려 이 전체 논의를 차라리, 실제로 이러면 더 숫자가 늘어나거든요. 그리고 나중에 이게 뭔가 문제가 생겨서 철회를 해야 할 때도 정부 측에서 잃는 게 거의 없어지기는 합니다. 각 국립의대들이 이미 운영하던 이 틀에서 하는 거기 때문에 그렇거든요.

계약의 조건만 만들고 전형을 신설하면 그 외의 교육은 대학에서 훨씬 더 잘할 수 있는 부분들이 있기 때문에 공공의대라는 것을 하나의 하드웨어로 생각하지 마시고 전국에 분산되어 있는 공공의대 전형에 학생들이 들어갈 수도 있다. 이런 방향성까지 좀 포함을 해서서 논의에 넣어 주시면 좋겠다라는 생각이 듭니다.

이게 법안 이 2개만 가지고 생각하실 거는 아닐 것 같아서 제가 말씀드리는 거고 공청회를 하게 되신다면 이런 부분들을 구체적으로 같이 설정을 좀 해 주시면 감사하겠습니다.

○소위원장 이수진 최보운 위원님.

○최보운 위원 저도 이주영 위원님 의견에 동의하고요. 지금 어떤 제도가 처음 설립이 될 때는 굉장히 여러 가지 다각적으로 보기로 할 필요가 있다고 생각을 합니다. 그리고 기존 제도에서 활용할 수 있는지에 대한 부분을 먼저 검토하는 것이 필요하다는 입장입니다.

우리가 기존 의과대학을 활용할 수 있는 부분을 먼저 검토를 하지 않고 이런 부분들이 추진되었을 때의 문제점이 있을 수 있기 때문에 기존 의과대학에 계신 교수님들, 학장님들 해서 관련된 부분을 어떤 식으로 활용할 수 있는지 현장의 의견을 청취하는 것도 방법일 것 같고요.

그 외에 또 정부와 함께 이런 부분들을 또 연계해서 할 수 있는 어떤 협의체라든지 구체적인 부분을 이렇게 해 보고 이게 정말 안 됐을 경우에 또 대안을 마련한다든지 보완하는 방법을 마련해야지 지금 기존에 있는 제도 없이 제로베이스에서 시작하는 것처럼 추진되는 것은 좀 신중히 검토될 필요가 있다는 의견 드립니다.

○소위원장 이수진 김미애 위원님.

○**김미애 위원** 제가 조금만 덧붙이면 이게 뭐냐면 단순하게 한번 생각을 해 봅시다.

지금 우리가 지역의료·필수의료 정상화를 위해서 어제 지역의사제법 통과했는데 이제 명 정부는 언론에 보면 의료사관학교도 또 신설하겠다고 발표하셨잖아요. 그러면 의료사관학교를 통한 배출 그다음 공공의대를 통한 것 그다음에 기존에 있는 대학의 입학 전형 을 통한 지역의사제 이렇게 하잖아요. 그러면 여기에서 각 나온 의사 수는 몇 % 정도가 적합한지가 나올 것이고 그러면 거기에 또 맞춰야 될 거 아니에요, 전국 현황도 봐야 되고. 그리고 지역적 특성 다 고려해야 되잖아요. 그렇게 하면서 틀이 대충 잡혀야지, 그래서 그 방향성이 정해져야 돼요.

제가 얼핏 이 법안을 봐도 공공의대를 신설하면서 지역의사제와 똑같이 10년 복무하면 구태여 공공의대는 왜 신설합니까라는 첫 번째 의문이 드는 거예요. 그냥 입학 전형을 통해서 하면 되지요. 여기는 아예 새로 만들면서 상당한 예산과 모든 또 의대, 교육 인프라까지 새로 갖추어야 되는데 그렇잖아요.

그래서 도대체 어떻게 해 간다는 건지 안 잡혀요. 이게 잡혀야 되잖아요. 그래서 제가 이거를 무슨 판지 거려고 할 것 같으면 어제 지역의사제법 같은 거 통과 안 시키지요. 그게 아니라니까요. 정말로 잘해야 된다는 거예요. 시대적 사명감을 가지고 우리 모두는 지금 여기에 임하고 있고.

특히 책임지는 정부는 정말 그래야 돼요. 그리고 못 할 게 뭐가 있습니까? 다 하잖아요. 그러면 여기에도 진심으로 집중해 가지고 좀 그런 틀을 마련해야지요. 그러면서 그거를 위해서는 이런 법이 필요하다는 설명이 돼야 돼요. 그래야지 우리가 법안 심사를 할 때도 서로 모순지점도 없고…… 법을 막 이렇게 저렇게 만들어서 통과시키면 됩니까? 그러면 나중에 어떻게 그 혼란을…… 그것 때문에 더 혼란스러워져요. 그래서 제가 계속 같은 말을 법안심사할 때마다 하고 있는데 아직도 해야 된다는 게 참 답답합니다.

○**소위원장 이수진** 한지아 위원님.

○**한지아 위원** 아마 다 비슷한 말씀들을 하시는 것 같습니다. 우선은 큰 그림이 있어야 되고 이게 정부도 참 어려울 것 같습니다. 정권이 바뀔 때마다 비슷한 의제들이 나오는 것 같고 또 정권이 바뀔 때마다 입장에 변화가 있는 것 같고요.

그런데 지역의사제가 아까 전에 차관님께서 공공성, 공공보건의료인력을 키우는 목적에 부합하기보다는 이제는 다른 목적이 있다는 말씀을 하셨던 것 같은데 그건 좀 동의하기가 어렵습니다.

공공보건의료인력은 공공보건의료를 목적으로 하는 건 분명하기도 하지만 지역의사제도, 저희가 공청회 때 분명히 김국일 국장님께서 두 가지를 강조했습니다. 하나는 취약지역에서의 활동. 그거는 공보의들이 보건지소나 보건소에 부재한 부분들에 대한 것을 장기적으로 그런 부분들까지 메꿀 수 있는 인력으로 고려를 하고 있다는 거고. 두 번째는 필수의료에 대한 부분을 채울 수 있는 것. 그리고 세 번째가 당연히 그 지역에서 정주할 수 있는 거기 때문에 이게 공공성을 띠지 않는다고 하는 것은 그것 자체가 지역의사제에 대한 목표의 모순이라고 생각을 합니다. 그래서 그거라고 생각하지는 않고요. 지역의사제도 공공보건인력의 하나의 일환으로 당연히 10년 동안 활동할 수 있는 거지요. 왜냐하면 그 지자체나 그 도에서 지정하는 곳에 가서 일을 하게 되어 있는 거니까요.

그래서 그런 면에서 공공보건의료인력을 아예 대학교를 따로 설립해서 하는 것보다 기

존에 있는 리소스를 사용해서 하는 게 나쁘지 않고 이게 경쟁적인 건 아니지 않습니까? 우리가 정말 이게 필요하다 그러면 여야 특히 보건복지위는 여야 할 것 없이 같이 합심해서 가는 경우가 많은 것 같습니다. 그런데 이게 명확하지 않은 부분이 있기 때문에 지적이 되는 것 같아서요. 그런 부분을 좀 정부 차원에서 통계를 포함해서 정리를 하시면 우리 국회에서도 훨씬 더 명확하게 공공의료를 그리고 지역의료를 살릴 수 있는 방안들에 대한 고민을 할 수 있을 것 같습니다.

○소위원장 이수진 김운 위원님.

○김운 위원 많은 위원님들께서 좀 혼란스러워 하셔서, 저도 아주 명확한 공공의과대학 또는 공공의료사관학교에 대한 상을 가지고 있는 건 아닌데 조금 설명을, 제 생각을 말씀드리는 게 좋을 것 같아서 말씀드립니다.

첫 번째, 제가 이해하고 있기로는 원래 얘기하던 공공의대를 명칭을 바꿔서 공공의료사관학교라고 부르는 것으로 알고 있습니다. 그래서 공공의대가 공공의료사관학교와 다른 게 아니고 이름이 바뀐 거다라는 점을 제가 이해하고 있는 바입니다.

그런데 그렇게 바꾼 이유는 의무 복무, 그러니까 공공의료사관학교에 들어온 모든 입학생들은 취약지, 의사가 부족한 공공적인 영역에서의 의무 복무를 하는 학생 100%로 구성되는 대학이라고 하는 점을 강조하기 위해서 공공의료사관학교라고 하는 명칭을 쓰기 시작한 것으로 이해를 하고 있습니다. 그런데 그렇다 하더라도 그러면 지역의사제를 통해서 양성하는 의사와 공공의료사관학교를 통해서 양성하는 의사가 어떻게 다르냐라고 하는 의문은 여전히 남는데요.

예를 들어서 우리가 코로나19 때 역학조사관이 부족하다. 그다음에 지금 공공의료와 지역필수의료 관련해서 부족한 영역의 의료 전문가들이 있습니다. 예를 들면 예방의학이나 이런 영역의 의사들도 있고 거기에 덧붙여서 이건 또 별도로 논의해야 될 문제이지만 하지만 군의관이나 또는 보훈병원이나 산재병원이나 이런 공공병원인데 우리가 흔히 얘기하는 지방의료원과 같은 공공병원이 아닌 또 별도의 공공병원들이 있어서 그런 공공 영역에 의사를 공급하는 것 역시 중요한 부분이라고 생각을 하고 있습니다.

또 다른 부분은 국립대학을 중심으로 하고 대학의 지역의사제를 중심으로 한 지역완결형 필수의료 네트워크와 별개로 중앙에서부터 지역까지 공공의료기관들을 체계적으로 연결한 소위 공공의료의 네트워크라고 하는 것을 만들 필요가 있다고 생각합니다. 그러니까 지역 차원에서 해결되지 않는 문제들이 있고 또 지역 차원에서 해결될 수 있는 문제이지만 이게 중요한 문제이고 24시간 365일 돌아가야 되는 시스템이기 때문에 일종의 세이프티 넷(safety net)처럼 이중적인 장치를 가져야 될 필요성이 있는 부분들이 있어서 수평적으로 지역 중심의 체계와 수직적으로 공공의료기관을 전국적으로 엮는 2개의 체계가 상호보완적으로 작동할 여지가 저는 있다고 생각합니다.

그리고 많은 위원님들께서 걱정하시는 게 대학을 세운다고 이게 제대로 운영이 되겠느냐, 수련이 되겠느냐라고 하는 말씀들을 하시는데 여러 위원님들이 제안하신 법 안에도 들어 있지만 국립중앙의료원과 공공병원들을 네트워크로 묶어서 수련병원, 교육병원의 역할을 하는 걸로 전제를 하고 있고요. 거기에는 국립암센터나 국립재활원이나 국립정신건강센터나 이런 병원들도 저는 함께 할 수 있을 거라고 생각합니다. 물론 그렇게 하기 위해서는 국립중앙의료원은 지금 이전신축을 하고 있는, 추진하고 있는 상황이기 때문에

공공의료사관학교가 생겨서 임상실습을 하기 시작하는 시점쯤에는 새 병원에서 아마 임상실습을 할 수 있는 타임라인이 맞게 될 것 같고요. 국립암센터는 수련병원으로의 역할을 하기에 부족한 점이 없고 국립재활원이나 국립정신건강센터는 수련병원으로의 역할을 하려면 지금보다는 아마 투자가 더 필요할 거로 생각이 됩니다.

○한지아 위원 국립재활원도 수련병원입니다.

○김윤 위원 그런데 국가중앙병원으로서의 수련병원의 역할을 하기 위해서는 지금보다는 수준이 조금 더 강화돼야 될 필요가 있다고 합니다.

그래서 그런 제반의 계획과 병행해서 공공의료사관학교 또는 공공의과대학의 설립 계획을 정부가 좀 제시해 주시면 좋겠다라는 말씀을 드립니다. 제가 이런 설명 해야 되겠습니까?

○소위원장 이수진 어쨌든 오늘 위원님들께서 의사일정 제21항, 22항 관련해서 심도 깊은 주문을 주셨어요. 그래서 차관계서는 이 내용들을 다 검토하셔서 지금 공청회를 좀 해 봐야 되지 않냐. 그런데 정부 대안을 포함해서 공청회를 하더라도 해야 되지 않겠습니까? 대안을 만드실 때 지금 주신 의견들을 참고하셔서 만드시고 그리고 이후에 공청회를 통해서 더 논의하도록 하겠습니다.

보다 깊이 있는 검토를 위해 계속 심사하기로 하겠습니다.

의사일정 제23항 자살예방 및 생명존중문화 조성을 위한 법률 일부개정법률안을 심사하겠습니다.

전문위원 보고해 주시기 바랍니다.

○전문위원 오세일 자료 2쪽입니다.

개정안은 자살예방센터가 수행하는 업무의 하나로서 자살예방 및 자살자의 유족 지원을 위하여 지방자치단체의 장이 필요하다고 인정하는 업무를 추가하려는 것입니다.

지역 내 자살이 빈발하게 일어나는 장소가 있는 등 지방자치단체별로 고유한 예방 대책을 마련할 필요성이 있을 수 있으므로 개정안은 타당한 것으로 보입니다.

다만 안 부칙은 공포 후 1년이 경과한 날부터 시행하도록 규정하고 있는데 개정안은 국민의 권리·의무관계의 변동을 가져오거나 집행기관에게 법률 시행에 필요한 사전 준비기간을 부여할 필요가 있는 내용이 아니므로 시행일을 앞당기는 방안을 고려할 필요가 있다고 보았습니다.

자료 5쪽에서 수정의견으로 시행일을 공포한 날부터 하는 것으로 제시하였습니다.

이상입니다.

○소위원장 이수진 정부 측 의견 들겠습니다.

○보건복지부제2차관 이형훈 해당 법안에 대한 정부 입장은 수용입니다. 또 전문위원께서 보고하신 것처럼 시행일을 공포 후 1년에서 즉시로 변경할 필요가 있다는 의견에도 동의합니다.

○소위원장 이수진 수정안 동의하셨고요. 특별히 질의하실 거 없으시지요?

○서미화 위원 있어요.

○소위원장 이수진 있으십니까?

서미화 위원님.

○서미화 위원 이거 지자체 자율성 확대 차원의 개정법안인데 저도 기본적으로 정부안

이나 또 이렇게 즉시 시행하는 것에 대해서 동의하는데요.

사실 각 지역에 있는 자살예방센터의 역할도 중요하지만 자살예방센터의 컨트롤타워는 복지부라고 봅니다. 실제로 컨트롤타워인 복지부의 역할이 굉장히 중요하잖아요, 차관님이.

지난 국감에서도 제가 지적을 했었는데 자살예방센터 업무가 지자체에만 전가하는 식의 이런 행정이나 확대가 되면 안 된다고 보고요. 이렇게 개정을 하고 확대를 한다고 해도 복지부의 역할이 강화되고 관리감독이 철저하게 되지 않으면 사실 OECD 국가의 자살률 1위라고 하는 불명예는 그렇게 바뀌지 않을 걸로 보거든요. 그래서 정부가 적극적으로 관리 감독해야 된다고 봅니다.

그래서 복지부의 컨트롤타워 역할은 어떤 식으로 좀 더 강화하려고 하는지 이런 것은 얘기 좀 해 주시면 좋겠습니다.

○**보건복지부제2차관 이형훈** 지금 위원님 말씀하신 부분에 대해서 답변……

국가와 지방자치단체가 함께 자살예방정책 내지는 국민 생명 존중을 위한 대책을 마련해야 한다는 것은 2025년 국가자살예방전략에도 반영되어 있습니다. 지금 말씀하신 복지부나 정부의 주도적인 자살 예방 정책은 지금 총리실 산하에 국가자살예방대책본부를 구성하려고 협의 중에 있습니다. 그래서 총리실 산하에 1급 단장을……

정전이 된 것 같습니다.

○**서미화 위원** 아, 그런가요? 그것은 입법하고 상관없이 할 수 있는 거예요?

전기가 안 나오는데……

○**김미애 위원** 켜졌어요.

안 들어와요?

○**김남희 위원** 저쪽 안 들어와요.

○**김미애 위원** 저만 들어오네. 저 혼자 말하라는……

○**보건복지부제2차관 이형훈** 그래서 조만간 그 대책본부가 구성·운영될 것이라는 말씀드립니다.

○**서미화 위원** 총리 산하에?

○**보건복지부제2차관 이형훈** 예, 총리 산하의 국가자살예방대책본부입니다.

○**서미화 위원** 그래요. 그런 것들 구체적으로 보고도 해 주시고요. 이런 지자체 자율성 확대가 혹시나 복지부에 책임이 전가되는 그런 일이 발생하지 않도록 각별히 유의해 주시고 저도 적극적으로 찬성하겠습니다.

감사합니다.

마이크가 꺼져 버렸네. 김미애 간사 것만 켜졌어?

○**김미애 위원** 그 말은 그만하라는 소리야.

○**소위원장 이수진** 그만하고 이제……

○**서미화 위원** 김미애 감사님하고 위원장님하고 하시면 되겠는데요.

○**김미애 위원** 아니, 저 혼자 말하라고 여기는 빨간불이 들어와 있네.

그리고 전문위원도 불 들어왔지요?

○**전문위원 오세일** 예, 들어와 있습니다.

○**김미애 위원** 둘이만 하고 빨리 집에 가라는 소리네.

○서미화 위원 그러면 되겠네.

○소위원장 이수진 그러면 의결하겠습니다

의사일정 제23항 자살예방 및 생명존중문화 조성을 위한 법률 일부개정법률안은 수정안을 채택하여 수정한 부분은 수정한 대로, 기타 부분은 원안대로 의결하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

오늘 일찍 끝내려고 그랬는데 안 되겠습니다.

효율적인 심사를 위해서 잠시 정회했다가……

○김미애 위원 그냥 마지막 해요, 비만.

○소위원장 이수진 아니, 위원님들 마이크가 다 안 들어와서 시설 정비되면 바로 속개하도록 그렇게 하겠습니다.

정회를 선포합니다

(15시32분 회의중지)

(15시41분 계속개의)

○소위원장 이수진 좌석을 정돈해 주시기 바랍니다.

회의를 속개하겠습니다.

마지막입니다.

의사일정 제24항부터 제26항까지 비만질환의 예방 및 관리에 관한 법률안 등 3건의 법률안을 심사하겠습니다.

전문위원 보고해 주시기 바랍니다.

○전문위원 정경윤 보고드리겠습니다.

자료 1쪽입니다.

심사하실 안건은 모두 3건입니다.

박희승 의원 대표발의의 비만 예방 및 관리에 관한 법률안, 이주영 의원 대표발의의 비만질환의 예방 및 관리에 관한 법률안, 전용기 의원 대표발의의 국민건강증진법 일부개정법률안입니다.

자료 2쪽입니다.

제·개정안의 주요내용 비교를 보시면 좋을 것 같습니다.

목적입니다.

2건의 제정안이 유사하지만 이주영 의원의 경우 진료 및 치료도 주요 목적으로 하고 있습니다. 이에 따라 이주영 의원안에서는 진료, 치료에 관한 부분도 국가 등의 비만관리 정책에 있어 강조되고 있습니다.

비만 정의입니다.

이주영 의원안은 체내 과다한 양의 체지방이 쌓인 상태로 규정하고 있습니다. 반면에 박희승 의원안에서는 구체적인 기준은 대통령령에 위임하고 있습니다. 그리고 전용기 의원안에서는 보건복지부령으로 정하도록 하고 있습니다.

국가 등의 책무입니다.

이주영 의원안에서는 진료, 치료 지원도 국가 등의 책무에 추가하고 있고 그 외 의료

인의 국가 비만관리사업에의 협조 규정도 추가되어 있습니다.

비만 예방의 날 지정입니다.

2건 제정안 모두 3월 4일을 비만 예방의 날로 하고 있습니다. 이날은 WHO에서 정한 세계비만의 날이 되겠습니다.

종합계획 수립·시행입니다.

법상 명칭은 이주영 의원안에서는 국가비만관리종합계획, 박희승 의원안에는 비만예방 관리 기본계획으로 되어 있습니다. 2건 모두 보건복지부장관으로 하여금 5년 주기로 수립하도록 하고 있습니다. 다만 이주영 의원안에는 비만치료에 대한 종합계획 수립을 국가비만관리종합계획에 포함하도록 하고 있습니다. 아울러 박희승 의원안에는 계획 수립 시 국회 소관 상임위원회에 보고 절차도 두고 있습니다.

비만관리위원회 설치입니다.

2건 제정안 모두 보건복지부 소속의 위원회를 두고 있지만 위원 수, 심의사항 등에서 일부 차이가 있습니다.

자료 3쪽입니다.

전문위원인력 양성은 2건 제정안 모두 동일합니다.

예방·관리사업 실시입니다.

교육, 홍보 등 3건의 제·개정안이 유사합니다. 다만 이주영 의원안에서는 비만 관련 데이터베이스 구축 및 관리 규정도 두고 있습니다.

치료지원사업 실시입니다.

이주영 의원안에서는 저소득층에 대한 비만질환 치료비용 지원 규정을 두고 있습니다. 하지만 박희승 의원안에서는 별도의 규정이 없습니다. 그리고 전용기 의원안에서는 비만 치료를 위한 시설과 설비를 확보하도록 하고 있습니다.

통계조사 실시입니다.

두 건 모두 비만 관련 통계 자료를 작성하도록 하고 있습니다.

그 외에 이주영 의원안에서는 역학 조사, 박희승 의원 안에서는 3년 주기의 실태조사를 규정하고 있습니다.

자료 4쪽입니다. 총괄적 검토 사항입니다.

검토의견 부분 보고드리겠습니다.

우리나라 19세 성인의 2024년 비만율은 BMI 25 기준으로 38.1% 수준입니다. 당뇨병 등 만성질환을 유발하는 원인으로 알려진 비만은 의료비 등 사적·공적 부담이 생애 전반에 걸쳐 발생할 수 있으므로 제·개정안과 같이 국가 차원에서 체계적으로 비만을 예방하고 관리할 필요성은 높은 것으로 보입니다.

다만 법 형식적 측면에서 비만 예방 관리를 이주영 의원안 및 박희승 의원안과 같이 제정법 형식으로 할지, 전용기 의원안과 같이 현행법을 일부 개정하는 형식으로 할지 논의가 필요해 보입니다.

아울러 법 내용적 측면에서 비만 예방·관리 정책의 범위, 특히 진료, 치료 부분입니다. 이러한 부분과 관련해서 제·개정안별로 차이가 있어서 조정도 필요해 보입니다.

자료 5쪽에 관계 부처 및 단체 의견이 기재되어 있습니다.

대한의사협회에서는 비만으로 인한 국민 건강의 위해 수준 및 질병 부담의 증가를 고

려할 때 국가적 관리를 보다 적극적으로 수행하기 위해서는 제정안 마련이 필요하다는 의견입니다.

여기까지 보고드리겠습니다.

○소위원장 이수진 정부 측 의견 들겠습니다.

○보건복지부제2차관 이형훈 세 발의안에 대해서 심사보고를 해 주셨습니다.

해당 법안들에 대한 정부 입장은 신중검토입니다.

법률안의 주요 내용은 국민건강증진법에 근거하여 시행 중입니다.

비만은 신체 활동, 영양, 생활 습관, 사회 환경 등이 복합적으로 작용한 결과로써 만성 질환을 유발할 수 있는 요인이므로 통합적 관점에서 접근할 필요가 있습니다.

병합 심사하는 전용기 의원님의 국민건강증진법 개정안에 국가와 지자체의 비만 예방 대책 추진 규정을 추가함으로써 이 법률안들의 취지를 달성 가능하다고 보고 있습니다.

일단 이렇게 개괄적인 말씀 드리고 위원님들 의견 들었으면 합니다.

○소위원장 이수진 위원님들 말씀.

이주영 위원님.

○이주영 위원 차관님, 이것 제가 발의한 법안인데 일부러 별도의 법안으로 마련한 이유가 있습니다. 지금 검토자료에서도 보시다시피 우리나라 비만율이 38.1%라고 되어 있는데 남성으로 한정하거나 또 중년을 보면 거의 50%에 육박을 합니다.

그런데 여기에 대한 사회적인 비용이 의료비만 6조에 육박을 하고 전체적으로는 15조가 넘는 걸로 확인이 되고 있거든요. 그런데 비만이라는 것이 지금은 마치 질병을 일으킬 수 있는 상황 이 정도로 인식을 하고 계신 것 같은데 비만은 사실 이미 심혈관계라든가 내분비라든가 근골격, 정신 건강에 이르기까지 이미 같이 노출되어 있는 질병 상태라고 보는 게 맞다는 것이 학계나 WHO의 입장이고요.

실제로 지금 특정 질병군을 하나의 법률로 만들어서 관리하는 사례가 우리나라에 이미 많지요. 후천성 면역결핍증, 결핵, 치매, 손상 예방·관리, 심뇌혈관 질환, 암 전부 다 별도의 법으로 규정되어 있습니다. 왜냐하면 건강증진법 안에 삽입하는 형태로는 여기에 대한 대책이 제대로 진행이 되지 않기 때문입니다.

그래서 실제로 비만 관련해서도 2018년부터 22년까지 1차 국가 비만 관리 종합대책 이후에 지금 3년 지났는데 아무 대책이 없고 2차 계획조차 없는 상황이거든요. 전 국민의 이 정도의 비율이 이미 유병되어 있는 상황에서 당연히 앞으로 사회적인 비용도 더 증가할 것인데 이것이 에이즈나 결핵, 치매, 손상 예방, 심뇌혈관 질환, 암에 비해 사회적인 중요도가 덜하다고 할 수 없고 또 앞으로 이것을 관리했을 때 우리가 얻을 수 있는 사회적인 비용의 감소를 생각하면 이것은 당연히 개별법으로 제정되어야 할 필요가 있다고 생각을 하는데요.

○보건복지부제2차관 이형훈 지금 개별법으로 제안하는 부분에 대해서 위원님 말씀하신 것처럼 질병에 대한 특별법들은 존재합니다. 암 관리법, 결핵 예방법, 치매 관리법 등 특정 질병에 대한 법률은 이렇게 있고 또 그것은 국가 책임을 강조하고 있습니다.

다만 비만은 위원님 말씀하셨듯이 신체적 활동, 영양, 생활 습관, 사회 환경 등이 복합적으로 작용한 결과고 또 만성 질환을 유발할 수 있는 요인이라는 것도 있고 그래서 예방과 관리를 강조하고 있는데 위원님 말씀하신 것처럼 치료의 접근까지도 필요하다는 것

을 인식하고 있습니다.

그런데 비만 인구의 증가에 대응해서 정부는 지금 국정과제에 비만 대책을 포함하고 강력히 추진할 예정입니다. 특히 국정과제 중에는 소아 비만 등에 대한 국가적 관리 체계 구축 이런 안이 있고 또 이게 소아 비만만이 아니라 염려하시는 성인 남성에 대한 비만도 많다고 하셨고 그래서 이런 부분들은 좀 개별법에 대한 취지는 이해하겠습니다마는 어쨌든 국민건강증진법 개정안에 추가를 하고 또 이 비만 대책에 대해서는 위원님 의원실과 또 상임위와 충분히 협의하면서 진행하면 좋겠다는 의견을 드립니다.

○소위원장 이수진 더 질의하실 위원님 안 계십니까?

일단 정부에서 비만 관련한 이 법안이 지금 제정법으로 두 분의 의원님께서 법률안을 내셨는데 정부 입장에서는 이 법안 관련해서 개별법에 대해서 검토가 충분히 잘 안 된 거 같아요.

○보건복지부제2차관 이형훈 예.

○소위원장 이수진 그러면 이것을 어떻게 하실까요? 정부가……

김미애 위원님.

○김미애 위원 그러면 저도 사실은 이 비만 현황이 우리 국민의 38%가 넘는다는 게 좀 충격이거든요. 저도 비만일까 이런 생각을 하면서……

그래서 이 정도면 특정 질환으로 보고 관련법을 제정할 필요성이 저는 높다고 보는데요, 차관님. 굳이 그것을 국민건강증진법에 포함시켜 가지고 하기보다 사실은 비만을 질환으로 인식하는 것부터 저는 좀 바뀌어야 되겠다는 생각도 있습니다. 그래서 이렇게 특별히 관리할 필요가 있어 보이는데…… 정부의 입장이 확고한 건 아니지요?

○보건복지부제2차관 이형훈 일단 말씀드렸듯이 지금 국민건강증진법 개정안을 통해서도 국가, 지자체가 비만 예방 대책을 추진할 수 있겠다는 말씀을 드리는 거고요. 또 이주영 위원님이 말씀하시는 치료 관련 규정들은 지금 국민건강증진법의 입법 목적에는 부합하지 않는 측면들도 있습니다. 그래서 이게 지금 치료 부분을 두면 개별법 내지는 이런 수요도 있는데 일단은 비만에 대한 통합적 관점에서의 접근이 필요하다는 점 그리고 개별법으로 할 것이냐에 대한 부분은 좀 더 신중한 검토가 필요하다는 그런 입장입니다.

○소위원장 이수진 이주영 위원님.

○이주영 위원 그거는 국민건강증진법에 넣으려고 하시니까 치료를 포함하는 게 부적절해 보이는데 개별법일 경우에는 당연히 들어갈 수 있는 부분이고요.

이 치료에 대한 종합 계획을 세워야 하는 이유는 이번에 위고비나 마운자로 등이 들어와서 우리나라에서 오히려 오남용이 문제가 되고 있고 제가 또 일부러 저소득층 비만 질환에 대한 치료 비용 지원을 넣어 놔는데 이거는 치료에 대한 영역이 들어가지 않으면 저소득층을 따로 우리가 도와줄 수 있는 방법이 없습니다.

저소득층에 대해서는 우리가 못 먹는 상태 그래서 뭔가 식재료나 아니면 식품을 공급하는 것에는 많은 재정이 들어가고 있지만 그것이 얼마나 건강한 식단으로 제공되고 있느냐에 대해서는 국가적인 논의가 어렵고 그걸 가능하게 하는 통로나 도구가 존재하지 않습니다. 그런데 이것이 비만에 관련된 법이라고 이름이 비만이라는 표현밖에 지금 없어서 이렇게 들어가 있지만 이 전체가 오히려 저소득층 영향에 대한 개입을 정부가 할 수 있게 되는 근거가 되기도 하고요.

그렇기 때문에 이 계획을 넣고, 데이터베이스 이것도 사회적인 비만에 따른 건강 격차를 줄이기 위해서 통계가 없이는 안 되는 거거든요. 그래서 제가 이번에 미숙아 관련된 것도 통계부터 시작을 했던 것이 여기에 대한 제대로 된 파악이 없으면 그 이후에 사업을 진행하기 어렵기 때문입니다.

앞으로 미국의 경우에도 저소득층이나 사회적으로 취약한 계층이 비만에 훨씬 더 취약한 것으로 나타나 있기 때문에 이 부분에 5개년 계획, 종합 계획 그리고 데이터베이스 구축 그리고 저소득층에 대한 치료 비용 지원 이런 것들을 포괄해서 우리가 정책적으로 장기적으로라도 지원하기 위해서는 근거 법령이 필요하고 그렇기 때문에 지금 이것을 국민건강증진법으로 삽입해서 하지 마시고.

지금 개정안 주요 내용에서 이것 검토하신 것 보면 거의 그냥 상징적인 것만 집어넣고 실질적인 정책은 안 나올 수밖에 없는 정도예요. 그래서 이게 아직 정부 측에서 확고한 게 아니라면 제 안과 박희승 의원님 안을 통합 조정하셔서 정부의 제정안으로서 만들어서 가지고 오셔서 검토를 하면 좋겠습니다.

○소위원장 이수진 한지아 위원님.

○한지아 위원 저 궁금한 게 한 가지 있는데 비만율이 OECD 국가 대비 몇 위 뭐 이런 게 있습니까, 혹시?

○보건복지부제2차관 이형훈 비만율을 지금 저희 보고서에도 정리하고 있지만 BMI 25 기준에……

○한지아 위원 예, 그거는 아는데요.

○보건복지부제2차관 이형훈 비만율로 얘기하는 거고요.

○한지아 위원 그랬을 때 OECD에서 순위라는 게, 우리나라의 비만율이 다른 OECD 국가에 비해서 어떻게 뭐 이런 게 있습니까?

○보건복지부제2차관 이형훈 국제 기준은 체질량지수 30을 기준으로 우리나라의 비만율을 측정하면 9.2%, 질병청이 산출한 게 있고요. 그 수준인데 미국은 체질량지수 30을 기준으로 했을 때 42.9%, 뉴질랜드가 34.2, 영국은 28.7 뭐 이런 게 OECD 비교 자료…… 아니, WHO의 2022년 통계는 있습니다.

○한지아 위원 그러면 그런 국가들에 있어서는 어떻게 비만을 따로 법령으로 관리하는 부분이 있습니까?

○보건복지부제2차관 이형훈 아니요, 그러지는 않는 것으로 지금 아는데요. 지금 미국이 비만을 암이라든가 치매 같은 국가 책임 질병으로 보고 개별법으로 규정한 사례는 저희들이 아직 조사하지 못했습니다.

○한지아 위원 그러면 저희가 BMI 30을 기준으로 했을 때 미국이나 영국이나 호주에 비해서 낮기는 낮는데 비만율이 올라갈 것 같기는 하거든요. 그 정도면 정말로 국가 위기 상황이기 때문예요.

그래서 이주영 위원님께서 말씀하신 부분에 대해서 통계 부분에서는 적극 공감합니다. 그런 부분을 트렌드나 이런 것들을 살펴보셔야 되실 것 같고 BMI 30을 기준으로 하는 이유는 있을 것 같습니다. 이게 유리하기 때문일 것 같거든요. 25로 하면 미국 같은 경우에 더 높아진다는 말씀이시기 때문에 그렇기 때문에 우리가 굳이 30을 기준으로 할 필요는 없을 것 같고 25로 했을 때 이 비만율이 어떻게 변할지에 대한 예측이나 이런 부분들

을 좀 꼼꼼히 챙겨 주셔서 우리가 좀 대비를 해야 되는 부분이 맞을 것 같습니다.

외국은 보니까 비만에 대한 법령을 따로 제정하는 것 같지는 않기는 합니다. 하지만 설탕세와 같은 오히려 더 과격할 수 있는 부분으로 가는 것 같거든요. 그래서 그런 논의로 가기 시작하면 아마 산업계도 난리가 날 것 같으니까 그런 차원에서 여러 가지 이 비만에 대한 초점을 맞춰서 좀 정책 제언과 법률이라든가 통계라든가 이런 걸 챙겨 주시기를 부탁드립니다.

○**보건복지부제2차관 이형훈** 예, 위원님. 뭐 하나만 말씀드리겠습니다.

보통 이렇게 BMI 체질량지수는 30을 기준으로 하는 것은 국제 기준, 국제 비교에서 쓰는 거고 25로 저희가 측정했을 때 38.1%가 나오는 거고 보통 이거는 비만이라기보다는 과체중이라고 이렇게 표현하는 걸로 알고 있습니다.

어쨌든 우리나라의 국제 기준에 따른 비만율은 어쨌든 OECD에서는 일본 다음으로 낮은 수준이고요. 하지만 비만에 대한 문제의식을 경시해서는 안 된다는 생각을 하고 있습니다.

○**김미애 위원** 제가 여기 몰라서 한번 찾아보니까 비만을 별도 법률로 제정한 나라는 이탈리아가 최근에 비만을 질환으로 인정하고 예방·관리하는 법안을 통과시켰다는데 정확히 우리가 제정법으로 하고자 하는 것과 유사한지는 모르겠습니다.

그리고 칠레가 비만 예방을 위해서 식품 영양표시 및 광고 제한을 담은 식품 환경을 규제하는 그런 입법은 한 것 같고 만약에 한다면 식품 광고 세제, 방금 한지아 위원님 말씀하신 것처럼 설탕세 같은 걸 도입한다든지 그래서 전반적으로 예방하고 관리해서 만성 질환으로까지 나아가지 않게 하는 중요한 계기는 마련될 수 있겠다 싶습니다.

그래서 제가 대충 이것 찾아본 거니까 정부도 이런 노력을 하셔야 되니까 좀 더 검토해서 과연 어느 것이 적절한지에 대해서 준비 좀 해 주시고 각 의원실로도 알려 주시면 좋겠네요.

○**보건복지부제2차관 이형훈** 예, 알겠습니다.

○**소위원장 이수진** 차관님, 저도 좀 궁금한 게 저도 이주영 위원님 말에 동의가 되거든요. 어떻게 보면 비만이 노쇠로 인한 질환보다 더 무서운 것 같아요, 비만으로 인한 질환이.

그런데 비만을 질환이라고 생각하지 않으니까 오히려 적극적인 어떤 예방이나 대책이, 사실 체계적인 정책이 마련되고 그 정책에 따른 시책들이 있어서 효과를 보고자 하는 법이라는 생각이 드는데 그래서 한번 검토를 해 봐 주셨으면 좋겠고.

그런데 제가 두 가지, 이 내용에서 이것은 한번 생각을 해 볼 문제는 비만 예방의 날, 우리가 무슨 날을 만드는 것은 많은 영역에서 뭔가 기념하거나 아니면 다양하게 여러 가지 이유에 의해서 날 같은 걸 만드는데 날을 만들고 이러한 것들에 대해서는 김미애 위원님도 지난번에 지적한 바가 있고 다 만들어 달라면 다 만들어 줘야 되냐 이런 지적이 있어서 그것도 좀 따로 검토는 필요할 것 같고.

그리고 또 하나는 저희가 국감 때도 그렇고 많은 위원님들이 비만 치료제 오남용에 대한 얘기를 많이 하셨어요. 위고비라든지 기타 이런 것들이 무분별하게 처방이 되거나 해당이 안 되는데 사용되거나 여러 가지 문제들이 있는데 이게 비만이 질환으로 확실하게 인지가 됐을 때, 과체중 정도는 위고비나 이런 것들이 남용돼서는 안 되는데 그런 분들

이 ‘나 질환이다’ 해 가지고 이걸 더 많이 사용하려고, 혹시 국민들 의식이 그렇게 되지는 않는지…… 그러니까 기왕에 만들어지는 법은 그렇게 되지 않게 만들어야 되는 거거든요. 그런 오남용을 막고 그것으로 인해서 실제로 국민들의 건강과, 건강보험 남용이나 이런 것들도 같이 우리가 막아 줘야 되잖아요.

그래서 그런 것들도 기왕에 검토하실 때 매우 중요한 결과물로서 의미가 있기 때문에 같이 좀 챙겨서 다음에 한번 보고를 해 주시면 어떨까 싶어요.

○**보건복지부제2차관 이형훈** 예, 위원장님, 그렇게 하겠습니다.

제가 하나만 더 말씀드리도록 하겠습니다. 지금 비만 관련된 과제들을 추진하고는 있습니다. 그런데 별도의 비만관리 대책으로 하지는 않았고 지금 5차 국민건강증진종합계획에도 그런 세부과제를 담아서 건강증진 2030 계획에 건강생활 실천이라든가 또 인구집단별 건강관리라든가 건강친화적 환경관리라든가 또 비감염 분야에서의 그런 추진 과제들 중에는 비만 관련된 과제들을 하고 있는데 지금 두 의원님 발의하시고 말씀하신 것처럼 비만 관련된 특별한 대책과 또 그런 것들이 국가적으로 필요한 시대, 상황이다라는 인식에는 공감합니다.

○**서미화 위원** 저도 한 말씀 드리겠습니다.

○**소위원장 이수진** 서미화 위원님.

○**서미화 위원** 지금 이재명 정부의 비만 국가책임제도 국정과제로 들어 있는 거 아니지요?

○**보건복지부제2차관 이형훈** 예.

○**서미화 위원** 그런데 저도 이주영 위원님 아까 의견에 굉장히 상당 부분 동의하거든요. 미국도 제가 알기로는 비만이 질환으로 지정이 돼 있는 것으로 알고 있는데 사실은 이게 법안을 발의하고 제정하고 이런 검토 과정에서 비용의 문제가 상당히 고려가 되지 않습니까?

그런데 비만의 문제는 사실 결국 혈압이나 당뇨, 성인병의 원인이 다 비만이라고 하는 이런 지적이 있는데 실제로 그런 부분도 잘 검토하셔서…… 비만이라고 하는 게 실제 우리 국민들이 비용을 지불하는 사회적 비용이 굉장히 많이 지출이 되고 있는 부분이기도 하고 그런데 이것을 뭔가 국가에서 책임을 지고 질환으로 해서 별도 법률을 만들고 비만을 예방하고 치료하는 이런 것들이 결국은 비용적인 면에서도 상당 부분 좀 더 효율을 나타낼 수 있는 이런 것들도 충분히 연구하고 검토하면 나올 수 있는 근거가 될 수 있을 거라고 보이거든요. 그래서 그런 점도 좀 감안해서 적극적으로 검토해 주시면 좋겠다는 의견을 드립니다.

이상입니다.

○**소위원장 이수진** 그러면 오늘 위원님들 거의 대부분이 필요성에 대해서 공감을 하고 정부가 대책 마련을 하면 좋겠다, 그렇더라면 이 제정법 관련해서 정부 대안이 필요할 것 같습니다.

○**이주영 위원** 위원장님, 저 마지막으로 하나만……

○**소위원장 이수진** 이주영 위원님.

○**이주영 위원** 차관님, 이것 제정법으로 정부 수정안이 올 것을 기대하며 제가 몇 가지만 중요한 것을 말씀드리고 싶은데 제정법으로서 꼭 들어가야 되는 것은 여기 진료·치료

만 까맣게 볼드가 돼 있는데 진짜 중요한 건 연구 지원이거든요, 비만에 대한 연구. 그래서 연구에 대해서는 명시적으로 들어가야 되고.

치료에 대해서도 아까 제가 저소득층을 포함해서 이렇게 말씀드린 부분이 있어서 적어도 ‘할 수 있다’ 정도의 임의조향으로라도 반드시 삽입이 되어야 한다는 부탁드립니다.

세 번째는 통계와 종합계획은 분명히 들어가야 됩니다. 그래서 여기에 대해서는 참고를 하셔서 전향적으로 검토를 해 주시면 좋겠고요.

BMI에 대해서 25, 30 기준이 나왔는데 물론 우리나라 기준이 지금 25로 돼 있는데, 이러면 또 정부에서는 기준을 막 바꿔서 적은 것처럼 혹시 하실까 봐 제가 걱정이 돼서 드리는 말씀인데 우리나라의 과체중은 다른 나라의 과체중, 특히 서양인들의 과체중과 조금 다르게 봐야 되는 부분은 있습니다. 우리나라가 특히 당뇨, 고지혈증에 취약한 구조를 가지고 있거든요. 그렇기 때문에 우리나라 노년층은 과체중에서 비만으로 넘어가는 그 시기에 당뇨 유병률이 현저히 높아집니다. 비만으로 갔을 때는 이미 합병증이 많이 생긴 상태이기 때문에, 우리나라에 민족적, 유전적으로 그런 특성이 있기 때문에 우리가 조금 더 선제적으로 해야 된다는 것에 대해서는 국가적으로 문제의식을 가지고 전향적으로 검토를 부탁드립니다.

이상입니다.

○소위원장 이수진 보니까 13일 날 미국 의회에서는 비만 치료 및 감소법이 발의가 됐다고 나오네요. 어쨌든 세계 각국에서 비만에 대한 그런 문제의식을 가지고 여러 발의라든지 제도 개선의 진행들이 있는 것 같긴 합니다.

그러면 더 이상 위원님들 의견이 없으시므로 의사일정 제24항부터 제26항까지는 보다 깊이 있는 검토를 위해 계속 심사하기로 하겠습니다.

이상으로 보건복지부2차관 소속 법률안에 대한 심사를 마치도록 하겠습니다.

이형훈 2차관님 수고하셨습니다.

이상으로 오늘 법안 심사를 모두 마쳤습니다.

오늘 의결한 법안의 체계와 자구의 정리는 위원장에게 위임하여 주시기 바랍니다.

위원님 여러분 수고 많이 하셨습니다.

산회를 선포합니다.

(16시06분 산회)

○출석 위원(11인)

김남희 김미애 김 윤 백종현 서미화 소병훈 이수진 이주영 장종태 최보운 한지아

○출석 전문위원

수석전문위원 이지민

전문위원 정경운

전문위원 오세일

○정부측 및 기타 참석자

보건복지부

제1차관 이스란
제2차관 이형훈
연금정책관직무대리 배경택
노인정책관 임을기
장애인정책국장 손호준
공공보건정책관 정통령
건강보험정책국장 이중규
정신건강정책관 이상원
식품의약품안전처
차장 김용재
기획조정관 우영택
식품안전정책국장 김성곤
식품소비안전국장 김현정
질병관리청
차장 임숙영
기획조정관 이상진
감염병정책국장 홍정익

임시회의록